سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة

المستوي الثاني

أستاذ المقرر

د.زينب بلال محمد احمد

٢٠٢٥- ٢٠٢٦م

المحتويات

الفصل الأول : التربية الخاصة

- مفهوم التربية الخاصة
- مبادئ التربية الخاصة
- مصطلحات في التربية الخاصة
- الفرق بين التربية العامة والتربية الخاصة
- مفهوم الإعاقة , و نسبة انتشار الإعاقة
- التكيف مع الإعاقة
- أهداف التربية الخاصة
- استراتيجيات التربية الخاصة ونظمها

أولا : نظام العزل :مميزاته /عيوبه

ثانيا : النظام الإدماجي : مميزاته /عيوبه

- خطوات بناء برامج التربية الخاصة.

الفصل الثانى : العوامل المسببة للاعاقات

- أسباب الاعاقات وطرق الوقاية والعلاج

الفصل الثالث : فئات التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة)

١ – الموهبة و التفوق

٢ – الإعاقة العقلية

٣ – الإعاقة السمعية

٤ – الإعاقة البصرية

٥ – صعوبات التعلم

٦ – اضطراب التوحد

٧ – اضطراب الإنتباه المصحوب في النشاط الحركي المفرط

٨ – اضطرابات اللغة و التواصل

٩ – الإعاقة الجسمية و الصحية

١٠ – الاضطرابات الانفعالية السلوكية

١١ – الإصابات الناتجة عن الدماغ

الفصل الأول

التربية الخاصة

مفهوم التربية الخاصة

تُعرف التربية الخاصة أنّها مجموعة من النشاطات والبرامج التربوية التي تختص بتقديم الرّعاية والعناية الخاصة لفئة معينة من الأشخاص غير الطبيعيّين، ويكون الهدف من هذه البرامج تحفيز القدرات العقلية والجسدية التي يمتلكونها لأكبر حد ممكن، ومساعدتهم على تحقيق ذاتهم وتكيفهم مع البيئة المحيطة بهم على أكمل وجه.

تُعنى برامج التربية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً خاصاً، إذ تبدأ بتعليمهم ضمن برامج التعليم الخاصة المراعية لظروف الاعاقة، ويخضع لهذه البرامج الأفراد غير القادرين على الانخراط في برامج التعليم العادية، كما يُمكن تعريف التربية الخاصة بأنها الخدمات التي تسعى إلى تنظيم حياة الأفراد غير العاديين ومحاولة أقلمتها مع الظروف المناسبة حتى يكون إنساناً ينمو نمواً سليماً.

وتشمل التربية الخاصة الجمع ما بين المنهج والتدريس والظروف التعليمية الضرورية من أجل تلبية احتياجات الفرد التربوية الخاصة بطريقة مناسبة وفعالة ، وقد تشكل هذه الاحتياجات كل المنهج أو جزءاً منه ، كما قد يتم إشباعها بطريقة فردية أو بربطها مع أشياء أخرى ، وقد تشكل كل الحياة الدراسية للفرد أو جزءا منها .(٥،ص ٧-١٠٠)

مبادئ التربية الخاصة

هناك العديد من المبادىء في التربية الخاصة،منها:-

- وجوب توفير بيئة تعليمية للافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة قريبةً من البيئة العادية.
- وجوب تضمّن البيئة التربويّة التعليمية عدداً من البرامج التربوية الفردية.
- الكشف عن المستوى الحالي للطفل من حيث الأداء.
- العمل على رسم أهداف ذات أمد طويل.
- التركيز على الأهداف ذات المدى القصير.
- وضع معايير للأداء الناجح.
- وضع خُطط لما سيتمّ استخدامه من مواد وأدوات لازمة للبرامج.

- تقييد البرنامج بتاريخ بداية ونهاية.
- إيجاد فريق متخصص وكفء لتقديم الخدمات المخصصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- توعية الأسرة بدورها تجاه طفلها نظراً لدورها المهم في بناء شخصيته.
- الدعوة لتربية الطفل غير العادي تربيةً خاصّةً حتى يكون لها أثراً إيجابيّاً عليه بشكل أكبر، فكلما كان العمر مبكراً كان ذلك أفضل. (٥،ص ٧-١٠٠)

<u>مصطلحات في التربية الخاصة</u>

الضعف :

وهو مصطلح يشير إلى محدودية الوظيفة وبخاصة الحالات التي تعزى للعجز والحسي كالضعف السمعي أو الضعف البصري.

العجز :

وهومصطلح يشير إلى تشوه جسدي أو مشكلة خطيرة في التعلم أو التكيف الاجتماعي نتيجة وجود الضعف وغالباً مايستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى الصعوبات الجسمية.

الإعاقة :

يستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى المشكلات في التعلم أو السلوك الاجتماعي (ولذلك نقول : اضطراب لغوي أو اضطراب تعلمي.

الحالات الخاصة:

وهذا المصطلح أوسع من المصطلحات السابقة حيث إنه لايقتصر على الذين ينخفض أداؤهم عن أداء الآخرين (ذوي الاحتياجات الخاصة) وإنما يشتمل على الذين يكون أداؤهم أحسن من أداء الآخرين اي الموهوبين والمتفوقين.

<u>الفرق بين التربية العامة والتربية الخاصة</u>

- تهتم التربية العامة بالأفراد العاديين ، في حين تهتم الخاصة منها بفئات الأفراد غير العاديين.
- تتبنى التربية العامة منهاجاً موحداً في كل فئة عمرية أو صف دراسي في حين تتبنى الخاصة منها منهاجاً لكل فئة ، تُشتق من الأهداف التربوية الفردية فيما بعد.
- تتبنى التربية العامة طرائق تدريسية جمعية في تدريس الأطفال العاديين في المراحل التعليمية المختلفة في حين تتبنى التربية الخاصة طريقة التعليم الفردي في تدريس الأطفال الغير عاديين في الغالب.
- تتبنى التربية العامة وسائل تعليمية عامة في المواد المختلفة ، في حين تتبنى التربية الخاصة وسائل تعليمية خاصة بفئات الأفراد غير العاديين.

ومهما يكن من فروق بين أهداف الخاصة والتربية العامة فإن كلاً منهما يهتم بالفرد ، ولكن كل بطريقته الخاصة مع ذلك فتشترك التربية العامة والخاصة في هدف مساعدة الفرد ، أيا كان على تنمية قدراته واستعداداته إلى أقصى حد ممكن والعمل على تحقيق أهدافه وذلك من خلال توفير الظروف المناسبة لتحقيقها. (٥،ص ٧-١٠٠)

مفهوم الإعاقة , و نسبة انتشار الإعاقة

تُعرف الإعاقة في أنها إصابة عضوية أو عقلية تحد أو تقلل في شكل كبير و ملحوظ من أنشطة الفرد و مهارته الحياتية و هذا الفرد يكون في حاجة إلى أجهزة تساعده على التنقل و الحركة أو اعتماد الفرد على اشخاص آخرين من أجل القيام في نشاطاته الفردية , و تختلف نسبة انتشار الإعاقة من مجتمع إلى آخر و ذلك وفق ظروف ذلك المجتمع و أوضاعه الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية على سبيل المثال يمكن أن تكون نسبة الإعاقة في أحدى المجتمعات تساوي ٢٠٪ و في مجتمع آخر ٤٪ .

التكيف مع الإعاقة

يواجه الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة عدد هائل من الضغوط و التي تتطلب من ذلك الشخص القيام في استجابات التكيف مع حالة الإعاقة و التي يعاني منها و العيش في سلام في المجتمع و هنا يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط من الاستجابات إلى حالة الإعاقة و هي التالي :

١ – الاستسلام و الخضوع للإعاقة و الفشل في التكيف مع الإعاقة.

٢ – استخدام وسائل الدفاع الأولية .

٣ – استجابات التعايش أو التعامل مع الإعاقة .

أهداف التربية الخاصة

يوجد أهداف للتربية الخاصة , و تشمل على التالي :

١ – هدف وقائي :

و يشمل نشر الوعي في كافة أشكاله المختلفة من أجل الحد من أسباب الإعاقة و هي تلك الإجراءات المنظمة و المقصودة و التي تهدف إلى عدم حدوث أو التقليل من حدوث الخلل أو التقصير المؤدي إلى العجز في الوظائف الفسيولوجية أو السلوكية عند الفرد .

٢ – هدف علاجي :

و هذا الهدف يكون بعد وقوع الإعاقة , و يكون هذا الهدف من أجل التخفيف أو التقليل من الآثار التي سببتها الإعاقة و هنا يتم تأهيل الفرد ذوي الاحتياجات الخاصة و استغلال إمكانياته و قدراته إلى أقصى قدر ممكن و يتم ذلك من خلال التدريب حيث تهدف الجهود العلاجية إلى

إزالة القصور أو العجز في المجالات الوظيفية المختلفة ، أو خفضه والتخفيف من حدته ، أو التعويض عنه ببناء بديل لهذا القصور أو ذلك العجز حالما يتعذر إزالته أو تصحيحه كاستخدام نظام "لويس برايل " في الكتابة والقراءة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة البصرية ، ولغة الإشارة مع الصم .

٣ – تحقيق الكفاءة المهنية لذوي الاحتياجات الخاصة:

و يشمل مساعدة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك على التكيف النفسي و الاجتماعي و هنا يقوم الإرشاد النفسي و التربوي في دوره الفاعل في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة و ذلك من خلال مساعدتهم على التكيف مع الإعاقة و التقليل من آثارها السلبية .

وتتعلق الكفاءة المهنية بإكساب ذوى الاحتياجات الخاصة بعضاً من المهارات اليدوية والخبرات الفنية المناسبة لطبيعة إعاقاتهم واستعدادتهم ، والتي تمكنهم بعد ذلك من ممارسة بعض الحرف أو المهن ويستلزم ذلك ضرورة المزج بين كل من الجوانب المعرفية الأكاديمية والنشاطات غير الأكاديمية ، والجوانب المهارية والمهنية والحرفية ، بحيث يتكامل التأهيل التربوي والنفسي والاجتماعى والمهنى لذوى الاحتياجات ، ويتم الكشف عن إمكاناتهم واستعداداتهم وميولهم المختلفة وتنميتها واستثمارها ، والإفادة من ذلك كله في توجيههم للعمل المهنى الذى يتلاءم معها.

فالتربية الخاصة تثرى خبرات ذوي الاحتياجات الخاصة بالقراءة والكتابة والحساب ، ومهارات السلوك التكيفي الأولية ، وخلال هذه العملية يتم استدخال عنصر آخر هو الاهتمام بمقدرات الطفل واستعداداته وميوله ومهاراته وتنميتها في خطة متدرجة منذ الطفولة المبكرة. (٥،ص ٧-١٠٠)

<u>وتتطلب عملية الإعداد والتأهيل المهنى عدة أمور لعل من أهمها :</u> (٥،ص ٧-١٠٠)

ا – توفير قاعدة من البيانات عن المهن والأعمال وفرص التشغيل المتاحة .

ب – توفير مجموعة من الاختبارات والمقاييس المقننة لاستخدامها في تحليل الفرد وتقييمه مهنيا للكشف عن استعداداته المهنية ويشمل ذلك تقييم استعداداته الجسمية مهاراته الحركية والحاسية ومهارات التآزر الحركى والبراعة اليدوية ، والمهارات العقلية والإدراكية وتستخدم فى هذا الصدد مقاييس عديدة كاختبارات المقدرة العقلية العامة ، ومقاييس الحركة وقوة العضلات ، والمرونة الجسمية ،والتآزر البصرى الحركي ، ومقاييس الميول المهنية ، والاتجاهات نحو المهن ، علاوة على مقاييس الشخصية للكشف عن سمات الشخصية اللازمة للتكيف المهنى سواء مع طبيعة العمل وروتينه ، أو مع الأشخاص الآخرين في بيئة العمل .

ج- تحليل المهن والأعمال وما يتطلبه كل منها من العامل من مهارات وظيفية ، استعدادات مهنية ، ومجالات ووسائل وأجهزة وأدوات ، علاوة على الظروف البيئية للعمل وصعوباته . ثم مقابلة النتائج التى يسفر عنها تحليل العمل بنتائج تحليل الفرد .

د – تحقيق المواءمة اللازمة بين متطلبات العمل أو المهنة من ناحية ، واستعدادات الفرد من ناحية أخرى وغالبا ما تستلزم هذه المواءمة تكييف العمل أو الأجهزة والأدوات المستعملة فيه لتتناسب مع مقدرات الفرد ذى الاحتياجات الخاصة وذلك بحسب نوعية هذه الاحتياجات ودرجتها ، كالاستعانة ببعض الأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية التى تقوم بتعويض القدرات الناقصة لدى الشخص كالأدوات المساعدة

هذا بالإضافة إلى إدخال بعض التعديلات والتجهيزات الإضافية في مكان العمل لتسهيل التحرك والقيام بالمهام الوظيفية المطلوبة بيسر كالأبواب ، والمصاعد ، والأرضيات المستوية الخالية من العوائق والمانعة للانزلاق

هـ – برامج للتوجيه والارشاد المهني .

و – تجهيزات مكانية ومادية وعناصر بشرية مؤهلة من المدربين والفنيين لازمة لعمليات التدريب والتأهيل . سلة

ز – برامج تدريبية مختلفة تتناسب وأنواع القصور المختلفة ودرجاتها

خ- أساليب تقييم لهذه البرامج الوقوف على مدى فاعليتها في إكساب المهارات والعادات اللازمة للعمل

ط- آليات للمتابعة المستمرة لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تشغيله لتذليل العقبات التي قد تعترض توافقه المهني ، وإعادة تأهيله عند اللزوم.

ولتحقيق هذه الجوانب الثلاثة للكفاءة فإن مناهج التربية الخاصة تشتمل على مجموعات متكاملة من المواد الدراسية والأنشطة المهنية . كما يشارك في عملية التربية الخاصة فريق متكامل من الإخصائيين ذوى الاهتمامات المهنية المختلفة لتخطيط الخدمات الواجبة للفئات الخاصة وتنفيذها ومتابعتها ، ويشمل هذا الفريق على إخصائيين في التربية الخاصة (معلمون وفنيون وأطباء وإخصائيون نفسيون واجتماعيون ، وإخصائيون علاجيون لعيوب النطق والكلام ، وإخصائيون سمعيون وبصريون ، وإخصائيون فى التأهيل المهنى.

٤ – تحقيق الكفاءة الشخصية:

و يشمل على مساعدة الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة , و ذلك من خلال تحسين قدراتهم و إنجازاتهم , و زيادة تحصيلهم في المجالات الجسمية و العقلية , و التي يعانون من قصور وظيفي فيها .

وذلك بمساعدة الفرد ذى الاحتياج الخاص على الحياة الاستقلالية والاكتفاء والتوجيه الذاتي والاعتماد على النفس ، وتمكينه من تصريف شؤونه الشخصية والعناية الذاتية بدرجة تتناسب وظروفه الخاصة بحيث لايكون عالة على الآخرين ، وذلك بتنمية إمكاناته الشخصية واستعداداته العقلية والجسمية والوجدانية والاجتماعية .

وقد تختلف مواطن التأكيد فى الجانب الشخصى باختلاف نوعية الانحراف ومداه ، فالكفاءة الشخصية بالنسبة للمتخلفين عقليا قد تتمثل في إكسابهم مهارات العناية بالنفس أو الوظائف الاستقلالية لإشباع احتياجاتهم الأولية من المأكل والمشرب والملبس والنظافة الشخصية، والمهارات الأساسية في اللغة

والاتصال الشفهي كتعلم الأسماء وسلامة النطق والتعبير ، والمهارات الحركية كالتوازن والتنسيق والتآزر الحاسحركي، وتدريبهم على أساليب الأمان وكيفية درء المخاطر عن أنفسهم أثناء التعامل مع المواقف التى يمرون بها ، والأشياء التي يستخدمونها ويتعاملون معها فى حياتهم اليومية .

وقد تعنى الكفاءة الشخصية بالنسبة لفاقدى وضعاف البصر إتقان مهارات الحركة والتوجه والتنقل بما يساعدهم على أن يكونون أكثر اعتماد على أنفسهم ، وأكثر اتصالا ببيئاتهم وتحكما فيها ، وأكثر شعورا بالأمن . أما بالنسبة للصم فقد يتركز إنجاز مثل هذا الهدف في اكتساب المهارات اللازمة للتواصل غير اللفظي، وتصويب عيوب النطق والكلام والاستعانة بالمعينات السمعية اللازمة لاستثمار مالديهم من بقايا سمع ، ومقدرة على الأداء الوظيفي السمعى .

٥-تحقيق الكفاءة الاجتماعية :

وتعنى غرس وتنمية الخصائص والأنماط السلوكية اللازمة للتفاعل وبناء العلاقات الاجتماعية المثمرة مع الآخرين، وتحقيق التوافق الاجتماعي لدى ذوى الاحتياجات الخاصة ، وإكسابهم المهارات التى تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة المحيطة والاختلاط والاندماج فى المجتمع ، والتي تمنحهم شعوراً بالاحترام والتقدير الاجتماعي وتحسن من مكاناتهم الاجتماعية ، وإشباع احتياجاتهم النفسية إلى الأمن والحب والتفهم والثقة بالنفس ، والتقليل من شعورهم بالقصور والعجز والدونية .

٦ – هدف تعليمي :

و يتمثل ذلك في إعداد البرامج التعليمية الخاصة , إلى كل فئة من فئات التربية الخاصة , و اختيار طرق التدريس المناسبة , إلى كل فئة من خلال الاعتماد على خطة تربوية فردية , و على خطة تعليمية فردية , كما يتضمن هذا الهدف , على إعداد الوسائل التعليمية و التكنولوجية المناسبة لكل فئة , في الإضافة إلى إعداد الكوادر التربوية المؤهلة , من أجل التعامل مع فئات التربية الخاصة .

٧ – هدف إنساني و ديمقراطي :

و هذا الهدف ينبع من مفهوم تكافؤ الفرص لجيمع افراد المجتمع , من خلال توفير التعليم و فرص العمل المناسبة لدى ذوي الاحتياجات الخاصة , و من خلال دمج هذه الفئة المهمة من المجتمع , في نشاطات المجتمع المختلفة , سواء كانت تلك النشاطات , نشاطات رياضية , أو تربوية , أو ثقافية , أو تعليمية , أو ترفيهية .

استراتيجيات التربية الخاصة ونظمها

استراتيجيتان هما: نظام العزل ، ونظام الدمج.

أولا : نظام العزل :

هو عزل الافراد ذوى الاحتياجات الخاصة في مؤسسات أو مدارس خاصة بعيدا عن العاديين أو عامة التلاميذ.

لمحة تاريخية لبداية الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة :

وتعتمد تلك النظرة لذوى الاحتياجات الخاصة على أساس أنهم عبئاً ثقيلا على المجتمع، منهم على سبيل المثال" افلاطون " الذى دعا إلى نبذ ذوي الاحتياجات الخاصة عقليا وطردهم أو نفيهم إلى خارج البلاد ، وحرمانهم من الحقوق والواجبات المتاحة لبقية المواطنين ، كما نادى " أرسطو " بأن الصم غير قادرين على التعلم لعدم مقدرتهم على الكلام وعلى فهم ما يدور حولهم.(٦ ، ص ٩٠) .

وبدأت إرهاصات الاهتمام الخاص بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم في مؤسسات ومدارس خاصة في أوربا وأمريكا منذ أواخر القرن الثامن عشر لاسيما مع بزوع أفكار المصلحين السياسيين والاجتماعيين فى أوربا، والمناداة بضرورة اعتراف المجتمعات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة والاهتمام اللازم بهم والرعاية الواجبة لهم ، ونتيجة لجهود مجموعة من الأطباء والمربين كانوا بمثابة الرواد الأوائل للتربية الخاصة .

وقد بدأ ظهور هذه المؤسسات والمدارس أولا بالنسبة للصم ثم تبعتها مؤسسات ومدارس أخرى للمكفوفين ثم للمتخلفين عقليا ، حيث أنشأ "ديليبيه" مؤسسة تعليمية للصم في باريس عنى فيها باستخدام لغة الإشارة في تعليمهم ، وتحولت هذه المؤسسة إلى مدرسة حكومية عام ١٩٧١ ، كما أسس " صمويل هانسيك " ١٧٧٨ م أول مدرسة للصم فى ألمانيا، وأنشأ " توماس برايد وودز " أول مؤسسة تعليمية للصم في بريطانيا ١٧٦٠ م بمدينة ادنبره ، واستخدم فيها طريقة قراءة الشفاة مع تلاميذه .

وأسس " توماس هوبكنز جالوديت " أول مدرسة لتعليم الصم ١٨١٧ م بمدينة هارتفورد بعد عودته من فرنسا وإثر دراسته للنظم الأوربية فى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا. وكان كل من " جون بايل بونيه " "جاكوب رودريجوس برير" قد وضعا منذ القرن السابع عشر الميلادي اللبنة الأولى في تعليم الصم ، حيث قام الأول بتأليف كتابه الشهير " اختزال الحروف وفن تعليم الصم الكلام، كما قام الثانى بوضع قاموس لغة الإشارة ، وابتكار طريقة قراءة الشفاة لتعليم الصم. .(٦ , ص ٩١ – ٩٣)

كما أنشئت أول مدرسة لتعليم المكفوفين بباريس عام ١٧٨٥ وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان لجهود الطبيب والمربى " صامويل جريدلي هوى " (١٨٠١)(١٨٧٦) م أكبر الأثر فى إنشاء مدرسة " بيركنز " للمكفوفين بمدينة واترتاون بولاية ماساشوستس . ويرجع الفضل إلى الفرنسى " لويس برايل " في اختراع الطريقة التي مازالت تحمل اسمه حتى الآن فى تعليم المكفوفين منذ عام ١٨٣٤ م وتعد من أكثر نظم القراءة والكتابة استعمالا من قبل المكفوفين في جميع أرجاء العالم، حيث تمت ترجمتها إلى لغات عديدة، وقد طور " برايل " – الذي أصيب بفقد بصره في السنة الثالثة من عمره – هذه الطريقة بناء على الفكرة التي حاول الضابط الفرنسي "باربيير" من خلالها قراءة الرسائل والإشارات فى ظلام الليل مستخدما مجموعة من الحروف البارزة التي يمكن قراءتها باللمس عن طريق الأنامل .

أما في مجال التخلف العقلى فقد قام الطبيب الفرنسى " جين مارك ايتارد " (١٧٧٥ – ١٨٣٨) فى مطلع القرن التاسع عشر بوضع برنامج لمدة خمس سنوات لرعاية وتعليم طفل متخلف عقليا أسماه " فيكتور " ، وكان أحد الصيادين قد عثر عليه بغابة أفيرون بفرنسا وسط الحيوانات ، وأطلق عليه الطفل المتوحش ، ومع أن " إيتارد " قد فشل في تعليم هذا الطفل الكلام والاندماج الاجتماعي رغم استمراره في مؤسسة داخلية حتى توفى فى سن الأربعين ، إلا أن هذه التجربة كان لها أكبر الأثر في أن يتابع تلميذه "إدوارد" سيجان " (١٨١٢ – ١٨٨٠) جهوده بإنشاء أول مؤسسة لرعاية المتخلفين عقليا وتعليمهم بباريس ١٩٣٨ م ، ثم فى ولاية ماسوشتس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٥٠ بعد هجرته إليها_عام ١٨٤٨ ، كما قام " جاكوب جيجنبول " بإنشاء أول مؤسسة لعلاج المتخلفين عقليا وتعليمهم في إبتبرج أوائل القرن التاسع عشر

وتواصلت من بعد ذلك جهود الطبيبة " ماريا منتسورى " (١٨٧٠ – ١٩٥٢) في إيطاليا ، و "دكروليه " في بلجيكا ، و " الفرد بينيه " في فرنسا حيث قام بوضع أول اختبار للذكاء عام ١٩٠٥ بتكليف من السلطات الفرنسية لاستخدامه في قياس الذكاء ، وعزل الأطفال المتخلفين عقليا عن الأطفال العاديين بالمدارس الحكومية ، وقد تمخضت هذه الجهود لأولئك الرواد الأوائل فى ميدان التربية الخاصة عن إعداد مجموعة من الطرق والبرامج الخاصة بتعليم المتخلفين عقليا

وتدريبهم ، قائمة على تفريد التعليم ، و استثارة حواس الطفل وتدريبها ، وتسلسل المهارات وتدرجها ، وتعديل بيئة التعلم وإثرائها، والتأكيد على إكساب الوظائف الاستقلالية ومهارات الحياة اليومية للطفل

وقد ظل الاهتمام حتى منتصف القرن العشرين تقريبا مركزا على تجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا لفئاتهم المختلفة ، وعزلهم فى مداس ومؤسسات مستقلة خاصة بعيداً عن مدارس الأطفال العاديين ، وتعليمهم وفقا لمناهج خاصة بهم حتى يتسنى مواجهة مشكلاتهم واحتياجاتهم عن طريق معلمين ومدربين متخصصين ، وحتى يمكن تفادى الصعوبات والمشكلات التى يمكن أن تنجم عن وضعهم مع العاديين في مدارس واحدة .

وهكذا قامت فكرة عزل ذوي الاحتياجات الخاصة وإقصائهم فى مستعمرات بعيدا عن الحياة العادية دون رعاية في باديء الأمر مقترنة بازدرائهم ونبذهم، وتجنيب المجتمع شرورهم على حد الزعم الذي كان سائدا حينذاك ، ثم اقترن العزل بعد ذلك بدوافع الإحسان إليهم والرحمة بهم والشفقة عليهم باعتبارهم من الضعاف والمعوزين ، ومن ثم ضرورة تأمين حاجاتهم الأساسية ، ثم بدأ إنشاء المدارس والمؤسسات الخاصة بكل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة كفالة لحقوق أفرادها فى التعليم والتدريب من جانب ، وعلى أساس أنهم يختلفون عن العاديين ويعانون القصور والعجز من جانب آخر ، لذا فقد روى أن وضعهم في محيط تعليمى خاص بهم يلائم حالاتهم ، ويقلل من أثر قصورهم وعجزهم على تعلمهم سوف يكون أفضل بالنسبة لنموهم وتوافقهم ، واعتقادا بأن فصل ذوي الاحتياجات الخاصة عن العاديين في مدارس خاصة بهم سوف يقلل من إبراز مظاهر قصورهم ، ومن ثم يحد من تعريضهم لمشاعر الاستنكار والنبذ من قبل العاديين، وما يترتب على ذلك من شعورهم بالدونية ، وآثار سلبية على مفاهيمهم عن ذواتهم .(٥، ص ٩٢)

<u>مميزات نظام العزل :</u>

١ – نظام الرعاية العزلية فى فصول خاصة ، أم في مدارس مستقلة قد يكون شيئا محتماً لا مفر منه بالنسبة لذوى الإعاقات الشديدة والمتعددة ممن يعانون صعوبات حادة يتعذر معها توفير فرص رعايتهم وإشباع احتياجاتهم التربوية والتعليمية فى نطاق المدارس العادية

٢– هذا النظام مناسب لبعض المجتمعات التى لا يمكنها من تهيئة المدارس العادية وتنظيمها ، وتوفير التجهيزات المادية والفنية ، والكفاءات والكوادر البشرية المدربة اللازمة لتربية وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة بدمجهم مع العاديين داخل هذه المدارس.

٣–مراعاة الفروق الفردية في المناهج واللوائح والامتحانات والوسائل التعليمية وطرق التدريس.

٤ – صعوبة تجاهل الاتجاهات الاجتماعية السلبية السائدة فى المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقات الشديدة التي تتطلب جهد كبير في التربية الخاصة) والتى تؤثر بدورها على برامج الرعاية التربوية والتعليمية لهم وتعد هذه الاتجاهات من معوقات تعميم النظام الإدماجي ذوي الاحتياجات الخاصة التلاميذ العاديين ، حيث ميع يقتضى هذا النظام فى جوهره تقبلا غير مشروط لجميع التلاميذ بغض النظر عن إعاقاتهم وقد يضاعف من صعوبة مقاومة تلك الاتجاهات السلبية تفشي ظاهرة الأمية وتدنى المستوى التعليم والثقافى لأفراد المجتمع ، وقصور الخدمات التوجيهية والإرشادية الأسرية عامة ، و كذلك بالنسبة لأسر ذوى الاحتياجات الخاصة .

<u>عيوب نظام العزل:</u> (٥،ص ٧-١٠٠)

تبين مما سبق كيف تطورت حركة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم من طور التجاهل والإهمال ، إلى طور الرعاية الإنسانية ، ثم إلى عزلهم فى مراكز إيوائية ومؤسسات ومدارس داخلية أو نهارية خاصة مغلقة عليهم، وقد ظل نظام الرعاية العزلية سائدا حتى منتصف القرن العشرين تقريبا إلى أن بدأ المتخصصون في إثارة العديد من الانتقادات للآثار السلبية المترتبة على هذا النظام وتبنى استراتيجيات واتجاهات جديدة أكثر إيجابية تعالج عيوب نظام العزل والتى من اهمها:-

١-عزل ذوى الاحتياجات الخاصة عن الحياة الاجتماعية:

حيث ان الرعاية العزلية – التى تقوم على فصل ذوي الاحتياجات الخاصة وتنشئته بمنأى عن البيئة الاجتماعية العادية ، وبمعزل عن مجرى الحياة اليومية لأفراد المجتمع – تؤثر سلبيا على توافقه الاجتماعي، وتحول دون اكتسابه المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع الآخرين ، مما يتعارض مع فلسفة التعليم من حيث هو إعداد الفرد للحياة في المجتمع.

٢-لا يتاح لذوى الاحتياجات الخاصة فرص الحياة اليومية وظروفها العادية مايتاح لأقرانهم العاديين من أفراد المجتمع بحيث يشاركوا في نشاطات الحياة الطبيعية بأقصى ما تسمح به استعداداتهم وإمكاناتهم وهو ما يعرف بالتطبيع نحو العادية.

٣-إن الرعاية العزلية ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة تقوم على وصمهم بمظاهر عجزهم وقصورهم ، وتتجاهل جوانب قوتهم وطاقاتهم الإيجابية الكامنة فيهم ، كما تنبني على إبراز مظاهر الاختلاف بينهم والعاديين أكثر من إبراز أوجه التشابه ، ولا يخفى ما يترتب على هذه النظرة من انعكاسات سلبية سواء على الطفل ذاته أم بالنسبة لأسرته أم بالنسبة للمحيطين به ، فالطفل غالبا ما يمتثل لوصمته بالإعاقة ، والنظرة التشاؤمية والتوقعات المتدنية لاستعدادته ومقدراته ، كما يشعر بعدم القيمة الذاتية ، مما يؤثر سلبيا

على نموه النفسي والتعليمى والاجتماعي ويعوق نمو مفهوم إيجابي عن ذاته

٤-ويؤدى النظام العزلى إلى إشاعة وتأكيد الاتجاهات المجتمعية السلبية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة ، وإلى تعزيز الأحكام القبلية والتوقعات المتدنية عن مستوى أدائهم لدى الآخرين ممايزيد الفجوة والحواجز النفسية بينهم وأقرانهم العاديين.

٥-ارتفاع الكلفة الاقتصادية تستلزم الرعاية العزلية فى مؤسسات ومدارس خاصة لكل فئة من ذوى الاحتياجات الخاصة كلفة اقتصادية باهظة لإقامة المبانى والمرافق والتجهيزات المدرسية وصيانتها وإعداد المعلمين والإخصائيين والفنيين والموظفين الإداريين.

ثانيا : نظام الدمج:

نظرا لعيوب نظام العزل فقد طور الباحثون أساليب ونظم رعاية بديلة تكفل تقديم الرعاية التربوية والتعليمية لذوى الاحتياجات الخاصة فى نطاق البيئة التعليمية العادية أو المجرى التعليمي المعتاد بإدماجهم في مدارس العاديين قدر الإمكان ولأطول وقت ممكن مع اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لإمدادهم بالمساعدات التربوية أو الإضافية المساندة التي تناسب احتياجاتهم الخاصة ، وكذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التعليمية سواء بصورتها العادية أم بعد تعديلها .

ويتخذ إدماج ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس العاديين صورا وأشكالاً شتى من بينها ما يلي :

١ - الدمج الكلى أو الشامل :

بوضع ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول العاديين طوال الوقت ، على أن يتلقى معلم الفصل العادى المساعدة الأكاديمية اللازمة من معلمين إخصائيين استشاريين أو زائرين يفدون إلى

المدارس عدة مرات أسبوعيا لتمكينه من مقابلة الاحتياجات التعليمية الخاصة للتلاميذ . ويحبذ الدمج الكلى بالنسبة لذوى الإعاقات البسيطة أو الخفيفة كضعاف السمع والإبصار ، والمتخلفين عقليا بدرجة بسيطة ، ويفى هذا الشكل من الدمج بكل من الاحتياجات التعليمية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يكفل الحصول على الخدمات اللازمة وسط أقرانهم العاديين طوال الوقت ويوجدعدداً من الخصائص أو المظاهر المميزة لمدرسة الدمج الشامل كما يلى :

- التحاق جميع الطلاب بمدرسة الحى .
- وجود فلسفة الرفض المطلق لحرمان أى طفل ذوي الاحتياجات الخاصة من التربية

المناسبة المجانية .

- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة يمثلون نسبة من أولئك المتواجدين في المجتمع العام
- هناك مدير واحد هو المسئول عن جميع البرامج في تلك المدرسة .
- الاتصال المستمر بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والعاديين .
- وضع الطلاب في فصول مناسبة لأعمارهم
- استفادة جميع الطلاب من مزايا المنهج الخاص بالصف الدراسي.
- وجود الطلاب في مجموعات غير متجانسة .
- وجود دليل على التدريس الفردى ، والتعلم التعاوني ، وتدريس الأقران .
- تقديم الخدمات المساندة في بيئة التدريس الطبيعية .
- الاشتراك في الخبرات والمواد التعليمية .
- وجود دليل على التعاون بين العاملين في المدرسة .
- استخدام نظم الدعم الطبيعية .
- تشجيع المعلمين والطلاب على احترام الفروق بين الأفراد .
- أن تعكس القواعد والتعليمات العدل والمساواة ، وأن يكون الاهتمام باكتساب المهارات الاجتماعية بنفس درجة الاهتمام باكتساب المهارات الأكاديمية . (٥،ص ٦٠-١٠٠)

٢ - الدمج الجزئى : وله عدة اشكال منها:-

الدمج لفترة من الوقت: يوضع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مع العاديين لفترة معينة من الوقت يوميا، بحيث ينفصلون بعد هذه الفترة عنهم في فصل مستقل أو عدة فصول خاصة لتلقى مساعدات تعليمية متخصصة لإشباع احتياجاتهم الأكاديمية الخاصة على يد معلمين إخصائيين سواء فى مواد دراسية معينة أو في موضوعات محددة وذلك عن طريق التعليم الفردى والتعاوني أو داخل غرفة المصادر داخل المدرسة ذاتها أو أن يتلقى ذوي الاحتياجات الخاصة تعليمهم لبعض الوقت على مدار ساعات أو عدة أيام متصلة - فى مدارس خاصة بهم، ويسمح لهم بقضاء بقية الوقت بمدارس عادية في نطاق البيئة المحلية .

الدمج المكاني والاجتماعي: حيث يتم تجميع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة المتماثلة من حيث نوع الإعاقة في فصول دراسية خاصة داخل نطاق المدارس العادية ، بحيث يدرسون فيها وفقا لبرامج دراسية خاصة تناسب احتياجاتهم طوال الوقت، وتقتصر مشاركاتهم مع أقرانهم العاديين على الاحتكاك والتفاعل خلال أوقات الراحة ، وفى الأنشطة الاجتماعية المدرسية والرياضية والفنية والرحلات، ويتسم هذا الشكل من الدمج على الأقل بتقليل البعد المادي بين

ذوى الاحتياجات الخاصة والعاديين ، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي بينهم

مميزات نظام الدمج :

- سهولة تطبيقه بالنسبة لذوى الإعاقات البسيطة أو المتوسطة – كالتخلف العقلي البسيط والاضطرابات الانفعالية الخفيفة وصعوبات التعلم مع توفير المساعدات والخدمات الخاصة المساندة اللازمة لهم.
- له آثاره الإيجابية في تحسين مستوى التحصيل الدراسى لذوى الاحتياجات الخاصة, ومفهومهم عن ذواتهم، كما يؤدى إلى إكسابهم أنماطا سلوكية إيجابية كالضبط الذاتى ، والتزام الهدوء ، والانتباه ، والتفاعل الاجتماعي.
- أقل كلفة من النظام العزلي في التربية الخاصة ، فهو يحد من الحاجة إلى متخصصين على درجة عالية من الخبرة ، ويساعد الدول النامية في تمكين عدد أوفر من الأطفال من فرص التربية والتعليم .
- لا يقتضى سوى إدخال بعض التعديلات البسيطة في البيئة المدرسية الطبيعية للوفاء بالاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كالاستعانة بالمعلمين المستشارين والمتنقلين أو المتجولين ، وإنشاء مصادر المعرفة.
- يراعى مباديء العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع ، والتى تنص على أن لذوى الاحتياجات الخاصة كافة الحقوق الأساسية التى لأقرانه العاديين ممن هم في مثل عمره الزمني مهما كانت وجوه الإعاقة التي لديه ، أو طبيعتها أو درجة خطورتها ، ومنها الحق في تعليم يناسب احتياجاته الفردية ، والحق فى احترام كرامته الانسانية وحمايته من كل استغلال أو إجراء أو معاملة فيها تجاوز أو حط من شأنه ، ومنها حقه فى النمو الطبيعى والتمتع بحياة لائقة طبيعية عادية أو أقرب ما تكون إليها ، وحقه فى اكتساب أكبر قدر من الاستقلالية ، وحقه فى الانتماء للمجتمع والاندماج الاجتماعى، والعيش وسط أفراد أسرته ، وفي المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية ، وعندما تكون إقامته في مؤسسة خاصة أمرا لازما فيجب أن تكون ظروف الحياة في هذه المؤسسة أقرب ما تكون إلى محيط الحياة الطبيعية وظروفها المتاحة لأقرانه العاديين.
- ويعد النظام الإدماجى فى تربية وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة أكثر اتساقا مع هذه الحقوق من النظام العزلي ، حيث يكفل لذوي الاحتياجات الخاصة الحياة الطبيعية مع أسرهم طوال مدة دراستهم ، كما يضمن تقديم الخدمات التعليمية لهم مع أقرانهم العاديين في نطاق أقل قدر ممكن من التمييز بالاختلاف والقصور من جانب ، و التقييدات والمحددات البيئية التي تمنع – أو تحد – من المشاركة والتفاعل الاجتماعى مع أقرانهم

العاديين وتزيد من شعورهم بالعزلة من جانب آخرت)

- ويتيح الاحتكاك المباشر والتواصل بين ذوى الاحتياجات الخاصة وزملائهم العاديين في بيئة اجتماعية واقعية وطبيعية من خلال المشاركة في النشاطات المختلفة داخل الفصل وخارجه ، مما يسهم في زيادة التعارف بينهما ، والفهم الأفضل من قبل كل طرف لظروف وإمكانات الطرف الآخر ، وبلورة أفكار ومفاهيم واقعية صحيحة عن جوانب قوته وضعفه ، كما يؤدى إلى تحسين اتجاهات العاديين نحو ذوى الاحتياجات الخاصة ، وزيادة تقبلهم لهم ، والتخلص من المفاهيم المسبقة الخاطئة عنهم .
- يتيح للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة ملاحظة سلوك أقرانهم العاديين في المواقف الأكاديمية والاجتماعية عن قرب ، وتمكينهم من محاكاتهم وتقليدهم والتعلم منهم ،وييسر لهم فرص معايشة خبرات واقعية متنوعة ، والتعامل مشكلات مختلفة مع ثم تكوين مفاهيم أكثر واقعية عن أنفسهم ، وعن الحياة والعالم الذي يعيشون فيه.(٧،ص ٧٠)

عيوب نظام الدمج: (٥،ص ٩٠-١٠٠)

- قصور الخدمات التربوية والتأهيلية والتفاوت في توزيعها :غالبا ما تقتصر على مناطق معينة كالعواصم والمدن الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية والعمرانية العالية ، كما أنها لاتستوعب سوى عدد محدود من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ، أو فئة منهم دون غيرها ، وهو ما يحول دون التوسع فى الخدمات التربوية والتأهيلية ونشرها بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأطفال ، ويعوق وصول تلك الخدمات إليهم في بيئاتهم المحلية .
- يقلل نظام الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس العادية من دور مراعاة الفروق الفردية في تقديم الرعاية التربوية والخدمات التعليمية الخاصة لهم .
- تعدد عناصر عملية الدمج إن عملية دمج الطفل فى الفصل الدراسي العادى – أو أية خدمات أخرى – تعتمد على عدة عناصر أساسية ، وتحتاج إلى تخطيط وتهيئة كل من المدرسة أو الفصل ؛ وزملاء الطفل ، والكوادر البرنامجية من المعلمين والإخصائيين والمدربين ، والذين يعملون مع الطفل لتعليمه وإعداده وإرشاده وتدريبه وإرشاد أسرته ، كما تحتاج إلى تهيئة الوالدين والأسرة ، والإدارة المدرسية ، أو المؤسسية التي يتعلم فيها الطفل أو يتدرب ، كما يشمل التخطيط والتنفيذ البيئة المحلية ومصادر المجتمع التى يأتي منها الطفل ويعود إليها بعد انتهائه من البرنامج .

<u>خطوات بناء برامج التربية الخاصة:</u>

١- التشخيص والتقييم الشامل لحالة الطفل لتحديد نوع الانحراف ودرجة شدته ، ومن ثم

مدى القصورات التى يعانى منها ، واستعداداته الأدائية الوظيفية ، وخصائصة النفسية والاجتماعية .

٢ – تحديد الاحتياجات التربوية والتعليمية الخاصة للطفل ، وتحديد الأهداف الإجرائية الملائمة لإشباع هذه الاحتياجات

٣– تقييم البرامج والبدائل المتوافرة في نطاق البيئة المحلية والقريبة بالنسبة للطفل ، وتحديد مدى كفاءتها فى مواجهة احتياجاته من حيث مدى توفر المناهج الدراسية والمواد التعليمية المناسبة ، وملاءمة التجهيزات المدرسية والكوادر البشرية من معلمين ومدربين وإخصائيين وغير ذلك .

٤ – اختيار البرنامج المناسب لإشباع احتياجات الطفل وتحقيق أقصى درجة من النمو التعليمي والنفسي والاجتماعى وفى إطار الأهداف المراد تحقيقها وهناك مجموعة من المحددات التى يجب أخذها بعين الاعتبار عند تخطيط برامج التربية الخاصة ، وتنفيذها وهى:–

<u>محددات التخطيط لبرامج التربية الخاصة</u>(٥،ص ٥٠–٩٠)

أ – نوع الانحراف

ب – درجة الانحراف

ج – الحالة الخاصة لكل طفل على حده .

د– المشاركة الجماعية .

أ – نوع الانحراف :

يختلف أفراد الفئات الخاصة فيما بينهم من حيث الخصائص أو جوانب الشخصية التي ينحرفون فيها عن المستوى العادى للأفراد عامة، هناك أنواع متعددة من الانحرافات الحاسية والجسمية ، والعقلية المعرفية ، والانفعالية الاجتماعية ، واضطرابات التواصل ، وصعوبات التعلم . ومن المعلوم أن الآثار التي تتركها هذه الانحرافات على الشخصية ، والاحتياجات التربوية والنفسية الخاصة التي تترتب عليها لدى كل فئة من ذوى الاحتياجات الخاصة ليست واحدة ، وإنما قد تتباين تلك الآثار وهذه الحاجات تبعا لتباين الإنحرافات . أى أن هناك متطلبات نمو وحاجات خاصة ترتبط بكل نوع من هذه الانحرافات وتختلف تبعاً له.

ب – مستوى الانحراف (درجته) :

من بين المحددات الأساسية فى تصميم الخدمات والبرامج التربوية الخاصة مستوى الانحراف" ، ويتراوح هذا الانحراف ما بين المستوى الحاد والمستوى البسيط (الخفيف) وبينهما درجات متفاوتة الشدة . وتختلف الاحتياجات التعليمية الخاصة ومن ثم البرامج والأساليب المشبعة لها تبعا

لتفاوت مستويات الانحراف حادة أم جزئية بسيطة . لذا يلجأ المتخصصون إلى تصنيف الفئات الخاصة إلى جماعات متجانسة الدرجة للتعامل معها كجماعات ذات خصائص مشتركة أساسية ، ولتصميم البرامج والطرق والأساليب التعليمية تبعا لاحتياجاتها بما يحقق لكل جماعة أقصى إفادة ممكنة وعلى أحسن وجه ممكن .

فالاعتماد على الإبصار يعد مدخلا أساسيا لبناء وتنمية طرق التواصل اليدوى والشفهى مع الصم كليا ، بينما يمكن الاعتماد في حالة ضعاف السمع – الصمم الجزئي – على استخدام المعينات السمعية والتركيز على عمليات التدريب السمعي وتمييز الأصوات ، ومعالجة ما قد ينجم عن ضعف السمع من اضطرابات في النطق والكلام كسبل لتنمية مهارات التواصل اللفظى لدى هذه الفئة، كما تختلف درجات التخلف العقلى من تخلف بسيط إلى تخلف معتدل إلى تخلف عقلى شديد وحاد ، ومن ثم تختلف احتياجات كل فئة و البرامج التعليمية التى تقابل هذه الاحتياجات . فبرامج التربية الحركية لذوى المستويات الدنيا من التخلف العقلى تركز على تعليمهم المهارات الحركية الأساسية كالوقوف والمشى باتزان ، والجرى والوثب والتعلق ، مما يساعد على السيطرة على أعضاء الجسم وتحسين الكفاءة الحركية للطفل . بينما تتزايد النشاطات الحركية الأكثر تعقيدا والتى تتطلب مستويات أعلى نسبيا من حيث التآزر والتفكير والتذكر والانتباه في البرامج الخاصة بفئات التخلف العقلى البسيط

ج – تفريد التعليم تبعا للحالة الخاصة لكل طفل :

من الامور المسلم بها في التربية المعاصرة أن كل تلميذ يتمتع بخصائص فريدة تميزه عن غيره من التلاميذ ، كما يعد حالة خاصة ، وأنه لا يتعلم فردان بنفس الطريقة أو الكيفية ، وهو ما يشار إليه بمبدأ الفروق الفردية ؛ من زاوية أخرى فإنه إذا كان بالإمكان تقسيم التلاميذ غير العاديين إلى فئات وجماعات تبعا لما بين أفرادها من خصائص مشتركة من حيث نوع الانحراف ودرجة شدته – كالصم وضعاف السمع مثلا – فإن كل فئة – لاتشكل جماعة متجانسة تماما في خصائصها فالأطفال الصم مثلا لا يتعلمون جميعاً بمعدل واحد..

وقد يتفق طفلان من حيث نوع الإعاقة ودرجتها ، إلا أن ما يترتب على هذه الإعاقة من آثار بالنسبة لأحدهما قد يختلف عن الآخر وذلك تبعا لمتغيرات عديدة كتوقيت اكتشاف الإعاقة ، والبيئة التي يعيش فيها ، واتجاهات أسرته نحو الإعاقة ، والخبرات التي تعرض لها ، ومدى خلوه من الإعاقات الأخرى ، ويؤثر ذلك كله على مستوى توافقه النفسي واستعدادته واعتباره لذاته، ولعل مما يدعم ذلك أن معظم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم مشكلات تختلف من واحد إلى آخر وربما يصعب حصرها في مشكلة واحدة . لذا فإن الوقوف على الفروق داخل الطفل ذاته وأثر الإعاقة على جوانب شخصيته – كحالة فردية – يعد عاملا له قيمته فى تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الملائمة لحالته

د- المشاركة الجماعية :

إن البرنامج التعليمى وما يتضمنه من نشاطات أكاديمية وغير أكاديمية وتأهيلية مهنية يجب أن يكفل في جانب منه الاهتمام بنمو ذوي الاحتياجات الخاصة كعضو في جماعة يدرك التزاماته وواجباته إزاءها ، كما يسعى إلى الحصول على حقوقه سواء بسواء .

إن النشاطات الجماعية التى يشارك فى ممارستها أكثر من فرد واحد كفريق يوزعون الأدوار فيما بينهم، ويدركون مسئولياتهم المشتركة من خلالها ، تكفل لهم فرصا واسعة للتمرس على التعبير ، والأخذ والعطاء ، وتبادل الرأى ، والتعاون وتقبل الآخر ، والامتثال لصالح الجماعة . فضلا عن أنها تهيء الفرصة لظهور بعض المواقف والمشكلات التي ربما لاتظهر من خلال الأعمال والخبرات الفردية ، وتحثهم على مواجهة هذه المشكلات

الفصل الثانى العوامل المسببة للاعاقات

أسباب الاعاقات وطرق الوقاية والعلاج

اسباب الاعاقات

الاعاقة والاوضاع الاسرية

تدنى المستوى الاقتصادى المصحوب بقلة الوعى الصحى تزيد من احتمالية حدوث الإصابة التي يمكن أن تتطور لاحقا كي تؤدي إلى الإعاقة ثم إلى العجز الدائم وكنتيجة حتمية لحدوث الإعاقة يتوقع أن يعاني الفرد من نقص شديد في الدخل بسبب عدم توفر الفرص التأهيلية والتشغيلية في تلك المجتمعات التي لا تتيح الحد الأدنى من تلك الفرص حتى للأفراد العاديين.

ولابد ن نشير الى انه تدنى المستويات الاقتصادية لا يعني بالضرورة حدوث الإعاقة على الرغم من أن الدلائل والتخمينات تشير إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يظهرون أكثر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية المصاحبة لتدنى المستوى الصحى والوقائى في جميع دول العالم بما فيها الدول الصناعية٠

يعاني الطفل الذي يولد من ذوي الاحتياجات الخاصة من التحيز والرفض والحرمان وتعتبر ولادة الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات النامية تلك نوعا من المأساة وعلى الرغم من حاجة هذا المولود إلى الرعاية الصحية الأساسية فانه يترك لمواجهة مصيرة دون توفير الحد الأدنى من الرعاية المطلوبة.

أولا :الأسباب الوراثية:

وتشتمل على مجموعة من العوامل الجينية التي تؤثر في الجنين لحظة الإخصاب ، وتشتمل على حصيلة التفاعل بين الخصائص الوراثية المقدمة من كلا الوالدين ويستدل على هذه العوامل وأثرها على الأطفال من خلال دراسة التاريخ الجينى الأسري للزوجين٠

ثانيا:الأسباب البيئية:

البيئة هي حصيلة المؤثرات الخارجية والظروف والمعطيات التي قد تلعب دورا رئيسا في حدوث حالات الإعاقة منذ ظهور الحمل وحتى ما بعد الولادة٠

١-عوامـل الحمل والولادة :

أ-أمراض الحمل والولادة: مثل إضطرابات التسمم الغذائي ، اختناق الطفل نتيجة نقص الأكسجين ، تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم ، فقر الدم ، النزيف أثناء الحمل ، استعمال العقاقير المختلفة ، ادمان الام على تناول الكحول أوالمخدرات ، التعرض للأشعة ، التعرض للصدمات ، تلوث الهواء أوالماء ، اضطرا بات التمثيل الغذائي ، المرض الكلوي المزمن، إصابة الأم بالسكري ، الإصابة بالحصبة الألمانية، الالتهابات، إضطرابات في الهرمونات ، سوء

التغذية، الكساح ، الحمى القرمزية ، العدوى – الأمراض المعدية الصفراء ، الحصبة،الدفتيريا ، التهابات السحايا ، شلل الأطفال، النكاف .

ب– وضع الجنين بشكل خاطيء في الرحم:

ج– عسر الولادة: الاختناق الناجم عن نقص الأكسجين ، الولادة المبكرة ، الإجهاض المتكرر ٠

د–الالتهابات وتسمم الحمل : تحدث هذه الالتهابات أو تسمم الحمل لدى الأمهات الحوامل أثناء الحمل أو الولادة أو بعدها مباشرة مما قد يسبب آلاما مبرحة في أبسط الحالات أو العقم ، إضافة إلى المشكلات العاطفية أو النفسية بسبب تفكك الحياة الزوجية الناتجة عن حدوث تلك الآلام والالتهابات المزمنة ٠ويعود سبب هذه الالتهابات أو التسمم إلى طول مدة الحمل أكثر من المعدل الطبيعي أو توفر رعاية غير سليمة أو تلوث يحدث أثناء الولادة أو الإجهاض ٠ ويقدر عدد النساء الحوامل اللواتي يصبن بتلك الالتهابات أو التسمم بحوالي ١٠٪٠ وفي حالات نجاة الأم من الالتهابات والتسمم أو التلوث بعد الولادة مباشرة، فقد تصاب فيما بعد بالتهابات فإذا لم يتم التدخل العلاجي بسرعة فان ذلك سيؤدي إلى ألم شديد في منطقة الحوض مما يؤثر بالتالي على حياة الأم نفسها ٠ كما أنه يؤثر أيضا على أعضائها الهامة للحمل، مما قد يتسبب في حدوث حمل خارجي وبالتالي تعريض حياتها وحياة الجنين للخطر والإصابة .

٢–سوء التغذية :

يلعب سوء التغذية الذي يصيب الأم الحامل دورا كبيرا في حدوث حالات الإعاقة ٠ فالنساء الحوامل اللواتي يعانين من سوء التغذية يلدن في الغالب أطفالا تقل أوزانهم عن الوزن الطبيعي ٠ إن مثل هؤلاء الأطفال معرضين لخطر الوفاة في الأسبوع الأول بعد الولادة أكثر من الأطفال الذين يولدون بأوزان طبيعية٠ وتجدر الإشارة هنا إلى أن من ينجو منهم من الوفاة نتيجة للتقدم الطبي الهائل فإنهم يكونون معرضين في العادة للإصابة بالشلل الدماغي أو التشنجات أو صعوبات التعلم الشديدة، أو الإعاقات العقلية أو الحسية .

٣–فقر الدم :

تعاني النساء المصابات بفقر دم من الدرجة الشديدة أو الشديدة جدا من تعب وإرهاق يؤثر على قدرتهن على الإنجاب وعلى صحتهن بشكل عام٠ تقدر منظمة الصحة العالمية حسب البيانات المتوفرة لديها بأن فقر الدم لدى النساء الحوامل في الدول النامية تسبب في عام ٢٠٠٠ في ضعف مقدرة النساء على الإنجاب والخصوبة عدا المضاعفات الصحية ٠ وتقدر الخسائر المادية المترتبة على هذه الإصابة بخسارة قد تصل إلى خمسة مليارات دولار٠ هذا ويعتبر فقر الدم كمرض يصيب نصف النساء الحوامل في العالم بأنه سببا مباشر أو غير مباشر للوفاة أو حدوث إصابات للأم والجنين

٤-**ارتفاع ضغط الدم** :تعاني ٦٪ من النساء الحوامل من ارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي فإنه يتوقع أن يتأثر الجنين بشكل مباشر بهذه الإصابة بسبب عدم حصوله على التغذية المناسبة أو إصابة الجهاز العصبي المركزي أو فشل في الجهاز التنفسي أو التسمم. وبالإضافة إلى هذه المخاطر، فإنه يتوقع أن تتعرض حياة الأم والجنين سويا إلى الخطر أو الإصابة والمعاناة في أفضل الحالات

وعلى الأغلب ، فان إصابة الأم سوف تخلف آثارا سلبية شديدة على أسرتها والمجتمع ككل لما يحدثه ذلك من تغيرات في الأسرة ومسؤولياتها ونفقاتها ووضع الأسرة الاقتصادي ومن هذه الآثار ما يلي :

-تؤثر مصاريف العلاج الطبي للأم على مستوى الاستهلاك الاقتصادي للأسرة وتقلل من مدخرات الأسرة .

-تؤثر عدم قدرة الأم على الإنتاج على مصدر رزق الأسرة مما يستوجب عمل الأطفال ودخولهم سوق عمالة الأطفال.

-يعاني أطفال الأمهات المريضات من سوء في التغذية وتردي الحالة الصحية والنظافة.

-يضطر الأطفال الأكبر سنا وخاصة الفتيات إلى التخلي عن الدراسة للقيام بدور الأم.

-يعاني أفراد من مشكلات نفسية من مثل الإحباط أو الشعور بالعزلة والوحدة . وللتغلب على الآثار المترتبة على إصابة الأم والجنين ، فانه لابد من التفكير الجدي في تفعيل إجراءات التدخل العلاجي والوقائي المبكر لما له من آثار إيجابية في الحد من تأثير تلك المسببات. فتدهور صحة الأم الحامل له آثارا سلبية جمة على الطفل أولا ثم على إنتاجية المرأة وقدرتها على الإنجاب ويشمل التدخل الصحي على سبيل المثال:

-1-إجراء عمليات جراحية ، ونقل دم ، وذلك بهدف التغلب على مضاعفات مثل ارتفاع الضغط وفقر الدم .

-2-توفير طاقم طبي مدرب وأجهزة وتسهيلات ومعدات طبية ونظام إحالة فعال وإشراف جيد.

-3-تيسير نقل الأم الحامل عند حدوث أية مضاعفات إلى مراكز الرعاية الصحية القريبة في أسرع وقت ممكن.

-4-توفير رعاية طبية ملائمة بعد الولادة أو الإجهاض وذلك لحل المشكلات المترتبة على النزيف والالتهابات أو تلف بعض أعضاء الجسم التي تحدث عادة بعد الولادة أو الإجهاض غير الآمن.

-5-تدريب الأمهات الحوامل على الولادة في مرحة مبكرة من الحمل.

-6-تشجيع المرأة الحامل على زيارة الطبيب على الأقل ٤ مرات في الثلاثة أشهر الأولى من

الحمل ٠ وقد تتولى مراكز الرعاية الصحية المجتمعية هذا الدور وتقوم بزيارات منزلية للأمهات الحوامل٠

-7-تثقيف النساء بالعادات الصحية السليمة والغذاء المناسب ، بالإضافة إلى تزويدهن ببعض الفيتامينات ٠ وكذلك توعية الأمهات الحوامل بالمؤشرات التي يجب الانتباه إليها لتفادي أية مضاعفات وكيفية التصرف عند الطوارىء ٠ كما يجدر توجيه المرأة لتناول الأغذية السليمة حتى لو كانت الموارد الأسرية محدودة٠فسوء تغذية المرأة الحامل ونقص الفيتامينات سيقلل من مقاومتها للأمراض والالتهابات وارتفاع الضغط وإصابتها بأمراض أخرى غير محددة ٠

الوقاية من الإعاقات

هي مجموعة من الإجراءات والخدمات المقصودة والمنظمة التي تهدف إلى الإقلال من حدوث الخلل أو القصور المؤدي إلى عجز في الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية، والحد من الآثار المترتبة على حالات العجز، بهدف إتاحة الفرص للفرد لكي يحقق أقصى درجة ممكنة من التفاعل المثمر مع بيئته، وتوفير الفرصة له لتحقيق حياة أخرى أقرب ما تكون من العادية.

مستويات الوقاية والعلاج

تقسم مستويات الوقاية من الإعاقات وعلاجها إلى ثلاثة مستويات هي:

(1)الوقاية الأولية: وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذ قبل حدوث المشكلة، وتعمل على منع حدوثها، وذلك بتوفير الخدمات والرعاية المتكاملة من الناحية الصحية والاجتماعية والثقافية، والتحصين ضد الأمراض المعدية، وتحسين مستوى رعاية الأم الحامل، وتوعيتها بأسباب الإعاقة. وكذلك بوضع برامج التوعية للشباب بخصوص أمن الطرق وتجنب الحوادث و التعرف على أسباب الإعاقة وتوعية المجتمع بها للعمل على منع حدوثها و رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر و التوعية الأسرية من خلال الإرشاد الأسري، والإرشاد الجيني، والإرشاد الصحي.

(2)الوقاية الثانوية: وهي الإجراءات والتدابير التي تكفل التقليل من الاستمرار أو تعمل على شفاء الفرد من بعض الإصابات التي يعاني منها، أي أنها تحول دون تطور الإصابة من خلال التشخيص والعلاج المبكر لذوي الإعاقات.

(3)**الإجراءات العلاجية:** وهي الإجراءات والتدابير الوقائية والأفعال التي تحد من المشكلات المترتبة على الإعاقة، وتعمل على تحسين مستوى الأداء الوظيفي للفرد، وتساعد على التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية عند حدوث الإعاقة، وذلك من خلال تبني برامج التأهيل المختلفة لذوي الإعاقات والعمل على دمجهم في مجتمعاتهم بصورة فعالة تحقق الاستفادة لهم وللمجتمع على السواء.

نماذج هامة برامج يمكن تطبيقها في المجتمعات للوقاية والحد من من الإعاقات:

هناك العديد من البرامج المخصصة للوقاية من الإعاقة ومن أمثلة هذه البرامج:

(1)برامج الإرشاد الوراثي: وتتكون من العديد من البرامج لمساعدة الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقات لتجنب تكرار حدوث مثل هذا الأمر في مرات الحمل التالية، وكذلك تقديم النصح الوراثي للمقبلين على الزواج منهم بإعطائهم المعلومات حول الصفات السائدة والمتنحية والعوامل الوراثية المختلفة وتحديد حاملي المرض ممن لا تظهر عليهم الأعراض. كما يشتمل على برامج الإرشاد الوراثي للمجتمع ككل لرفع الوعي الوراثي وشرح العديد من المسائل الوراثية مثل دور زواج الأقارب في انتشار بعض الأمراض الوراثية المتنحية وخاصة في المجتمعات التي يكثر بها هذا النوع من الزواج.

(2)برنامج العناية الطبية اثناء الحمل وهو برنامج لتوعية الامهات الحوامل بالنسبة للتغذية المناسبة والأمراض المعدية والعناية الطبية وتجنب الأدوية والأشعة والمخدرات والتدخين والراحة النفسية وتوعية الأمهات حول أهمية الولادة بالمستشفيات بدلا من الولادة بالمنزل لتجنب المشاكل التي تحدث أثناء الولادة وتؤدي إلي بعض الإعاقات كالشلل الدماغي.

(3)برنامج المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة وهو برنامج يهدف إلي فحص كافة المواليد للاكتشاف المبكر لبعض الأمراض المسببة للإعاقة بحيث نتمكن من منع حدوثها، مثل نقص هرمون الغدة الدرقية المسبب للتخلف العقلي وكذلك بعض أمراض اضطرابات التمثيل الغذائي.

(4)برامج تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة: كلما تطور مجتمع ما كلما زاد اهتمامه بعملية تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن الجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يعانون من أشكال عجز مختلفة قد يصبحون معوقين فعلا، ليس نتيجة العجز ذاته وإنما بسبب الاتجاهات السلبية غير البناءة والحواجز التي تحول دون مشاركتهم في الحياة العامة للمجتمع أو الاعتماد على أنفسهم. وعلى هذا فقضية تأهيل الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة هي قضية مجتمع ككل تهدف إلى تفعيل الطاقات على صعيد المجتمع لإحداث تغيير في معارف الناس ونظرتهم وسلوكهم وذلك لتمكين أفراد المجتمع من التفهم بشكل أفضل للإعاقة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتقديم بيئة محيطة أفضل مما هي عليه لذوي الإعاقات لتحسين مستوى حياتهم. وتهدف برامج التأهيل بصفة عامة إلي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول بامكاناتهم البدنية والعقلية إلى مستواها الأقصى مما يتيح لهم الاندماج الاجتماعي الكامل في مجتماعتهم. ومن ناحية أخري يعزز حقوق ذوي الإعاقة في الحياة داخل مجتمعاتهم المحلية والتمتع بالصحة والرفاه، والمشاركة الكاملة في الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية.

الفصل الثالث

فئات التربية الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة)

من المنظور التربوي يشير مفهوم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة , إلى ذلك الطفل أو الشخص الذي ينحرف أو يقل عن الفرد العادي أو الفرد المتوسط , في الأمور التالية :

١ – الخصائص العقلية .

٢ – القدرات الحسية .

٣ – قدرات التواصل .

٤ – نمو السلوك الاجتماعي و الإنفعالي .

٥ – الخصائص الجسمية .

و إن هذا الانحراف يجب أن يكون في درجة يحتاج معها الطفل , إلى مواد و وسائل تعليمية خاصة , و استراتيجيات تعليمية خاصة , إلى كل فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة , و إلى كوادر مؤهلة من أجل التعامل مع كل فئة , و عليه تكون فئات التربية الخاصة و لدى ذوي الاحتياجات الخاصة , و التي تشمل على التالي :

١ – الموهبة و التفوق – . Gifiedness

٢ – الإعاقة العقلية – . Mental Impairment

٣ – الإعاقة السمعية – . Hearing Impairment

٤ – الإعاقة البصرية – . Visual Impairment

٥ – صعوبات التعلم – . Learning Disabilities

٦ – اضطراب التوحد – . Autism Disorder

٧ – اضطراب الإنتباه المصحوب في النشاط الحركي المفرط – Learners With Attention Deficit Hyperactivity Disorder .

٨ – اضطرابات اللغة و التواصل – . Communication Disorders

٩ – الإعاقة الجسمية و الصحية – . Physical And Health Impairments

١٠–الاضطرابات الانفعالية السلوكية – . Emotional Impairment

١١–الإصابات الناتجة عن الدماغ – . Traumatic Brain Injury

١ – الموهبة و التفوق :

الطفل الموهوب (المبدع) : خصائصه وأساليب تنميته ورعايته

تاريخ الاهتمام بالموهوبين

إذا كان النصف الأول من القرن العشرين قد شهد اهتماماً واضحاً بالذكاء والقدرات الخاصة، فإن النصف الأخير من القرن نفسه قد شهد الاهتمام بالإبداع وتميز برعاية المبدعين والعناية بهم ، فانكب مئات العلماء والباحثين وعشرات من المؤسسات العامة والخاصة بدراسة المبدعين وخصائصهم، وبدأ العمل بوضع البرامج التربوية لتنمية المواهب والابتكارات لدى الأطفال والتلاميذ منذ المراحل المبكرة من حياتهم ، كما صدرت المؤلفات والكتب والمجلات التي تتناول الإبداع وتعنى بتربية الموهوبين.

وقد سبق هذا التاريخ إرهاصات متعددة منذ الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي دفعت إلى هذا الاهتمام ، وبخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث بدأ التسابق العلمي والتقني بين الدول الصناعية ، وخاصة بين الشرق والغرب إذ واجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحديات كبيرة عندما سبقتها روسيا إلى غزو الفضاء والوصول إلى القمر الأمر الذي دفع بها إلى إعادة النظر في مناهجها ومؤسساتها التربوية والعلمية ، فكان الاهتمام بالمبدعين باعتبارهم ثروة قومية يجب أن توظف في خدمة المجتمع وتقدمه ، وسرعان ما وجهت الجهود حول الظاهرة الإبداعية من قبل العلماء والباحثين والمعلمين ليس على مستوى أمريكا فحسب ، بل على المستوى العالمي طيلة هذه الفترة وتحققت نتائج علمية باهرة وتطبيقات تربوية حول مظاهر العملية الإبداعية وتنمية المبدعين تتمثل في الجوانب الآتية :

١– استكشاف طبيعة العملية الإبداعية ومراحلها ومكوناتها وما يحدث بينها من تفاعل دينامي

٢– التعرف على الخصائص النفسية للمبدعين وما يرتبط بها من سلوك وأنشطة إبداعية .

٣– تنمية قدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال والطلاب عن طريق البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة باستخدام الأساليب العلمية المحكمة ووضع البرامج الإرشادية والأدلة التي تساعد المعلمين والمربين على تهيئة الظروف الملائمة والمشجعة على التفكير الخلاق .

كما إن هذه الفترة قد حققت إنجازات مهمة في تطوير أدوات وأساليب القياس الخاصة بالمبدعين وبالعملية الإبداعية ، حيث صممت مئات الاختبارات وأدوات القياس الموضوعية ، كما تم تقنين وتجريب هذه الاختبارات على نطاق واسع من البيئات والثقافات في العالم ، بدلاً من الاعتماد على اختبارات الذكاء التقليدية التي أظهرت الدراسات التي أجريت منذ عقود مضت أنها لا

يمكنها التنبؤ بحدوث النتاج الإبداعي لأفراد معينين " إذ لوحظ أنه بالرغم من ضرورة وجود حد أدنى للذكاء للأنشطة الإبداعية ، إلا أن هذا الحد الأدنى يختلف من مجال إلى آخر ، كما أن توافر الحد الأعلى من الذكاء لدى بعض الأفراد لا يؤدي بالضرورة إلى نمو الإبداع لديه

وعالجت اختبارات الإبداع التنوع في الذكاء لكي يأخذ التفكير اتجاهات متباينة في حل المشكلات ، ومن هنا كانت اختبارات جيلفورد تؤكد أنماط التفكير التباعدي أو التشعيبي انطلاقاً من التفكير الإبداعي هو تفكير تباعدي .

وهكذا نخلص إلى القول بأن الاهتمام بالعملية الإبداعية لدى الأطفال باتت من الأهداف الأساسية التي ينادي بها الباحثون والمعلمون والمربون بدأ من مراحل الاكتشاف المبكر لمواهبهم وقدراتهم ثم التعرف على خصائصهم ومن ثم العمل على تنمية هذه المواهب أو الابتكارات عن طريق التعليم والتدريب الموجه وتحاول هذه الورقة تسليط الضوء على الموهوبين واقتراح مشروع مبدئي لمحاولة تنمية الأطفال بهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي تمثل ثروة قومية يجب العناية بها على مختلف المستويات الاجتماعية التي يتفاعل معها الطفل بداية من الأسرة والروضة ثم المدرسة والمجتمع بمؤسساته .

الطفل الموهوب المبدع : تعريفه وخصائصه :-

هناك عدة مفاهيم وألفاظ تطلق على الأطفال الموهوبين ، فقد يقال عنهم بأنهم أذكياء ، أو عباقرة أو نوابغ مبتكرين ، وإذا كانت هذه الألفاظ تعبر عن معاني المدح والثناء ، ووصف الموهوب بصفات إيجابية سوية ، فهناك بعض الناس من يصفهم ويصورهم بصورة خاطئة فيرى بأنهم ، غريبي الأطوار ، مخبولين ، وأنهم من ذوي الاضطرابات العصبية وغير مستقرين نفسياً

تعريفات الطفل الموهوب:-

وإذا أردنا أن نمضي قدماً في التعرف على شخصيات الموهوبين وعرض خصائصهم فينبغي أن نشير إلى أهم التعريفات التي وردت في التراث التربوي والنفسي للموهوبين والمبدعين.

فقد عُرف الطفل الموهوب بأنه " كل طفل يتميز بالتفوق العقلي عن مرحلته العمرية في بعض القدرات التي تجعله مساهماً عظيماً وفعالاً في تحقيق الرفاهية للمجتمع .

وتشير الموسوعات النفسية والتربوية إلى وصف الطفل الموهوب المبدع بأنه " الطفل الذي يؤدي أي عمل بكفاءة عالية وبصورة أفضل ممن هم في سنه ، وبأسلوب يبشر بتحقيق إنجازات وإسهامات عالية في المستقبل " .

ومن التعريفات أيضاً تعريف سبيرمان Spearman للتفكير الإبداعي للطفل بأنه قدرة على إدراك العلاقة بين شيئين بطريقة ما ينبثق عنها ظهور شيء ثالث مخالف لشكليهما الأولين " .

وتذهب مدرسة الجشتالت Gestalt في علم النفس إلى أن المبدع الموهوب ، هو ذلك الفرد القادر على إعادة دمج المعارف والأفكار بشكل جديد .

وهناك طائفة أخرى من التعريفات تؤكد على تميز الموهوب بقدرات عقلية عليا ، فالموهوبون المبدعون هم أولئك الأفراد الذين يتحصلون على درجات عالية من الذكاء بنسبة ١٪ من الأطفال حديثي السن.

و فئة العباقرة أو الموهوبين هم ذوي الذكاء المرتفع الذين تصل نسبتهم إلى ١٤٥ درجة ويمثلون حوالي واحد في الألف من الإحصاءات السكانية العامة وأما فئة الأذكياء فتتراوح نسبة ذكائهم ما بين ١٣٠-١٤٥ درجة ويمثلون حوالي ٢٪ تقريباً ويتميزون بالتفوق في التحصيل الدراسي . (٥،ص ٧٣)

وكما يلاحظ على هذه التعريفات أنها اعتمدت أسس ومحكات مختلفة في تعريف الموهوب أو المبدع منها محك القدرات العقلية والسمات الشخصية ومنها ما اعتمد على محك التفكير كما هو في تعريف سبيرمان حيث يصف التفكير المبدع بأنه إدراك العلاقة بين شيئين في حين يذهب تعريف مدرسة الجشتالت إلى محك النتاج الإبداعي ، فهو إعادة دمج المعارف والأفكار بشكل جديد .

وبالطبع فهناك محكات أخرى لجأ إليها العلماء والباحثون في تعريفهم للموهوب والمبدع منها وصف العملية الإبداعية والمراحل التي تمر بها وكذلك محك السمات الانفعالية والاجتماعية والقدرة على الإحساس بالمشكلات وطرح البدائل والحلول لحها فقد جاء في تعريف تورانس وهو من الأعلام المشهورين في دراسة الإبداع : إن الإبداع يعني الإحساس بالمشكلات والقدرة على إيجاد الحلول لها ، فالتفكير الإبداعي يعني الإحساس بالثغرات والعناصر المفقودة (في المشكلة) وتكوين الأفكار ووضع الفروض الخاصة ومحاولة اختبارها والوصول إلى النتائج .

خصائص الأطفال الموهوبين : وفي ضوء التعريفات السابقة ، وما توارث في التراث التربوي والنفسي أنه يمكن أن نستنتج جملة من الخصائص والسمات التي يتميز بها الموهوبون :

١- التفوق العقلي : يتسم الموهوبون بالقدرة العقلية العالية فالموهوب يتربع على قمة السلم الهرمي في استجاباته على اختبارات الذكاء ، وكذلك في اختبارات التفكير الابتكاري .

٢- القدرة على أداء الأعمال بكفاءة عالية ، وذلك بما يمتكله من مهارات متميزة تنبئ بتحقيق إنجازات عظيمة مستقبلاً وبما يمتلكه من طاقة حيوية هائلة يسخرها للسيطرة على الأشياء .

٣- القدرة العالية على الفهم والإدراك في تصور العلاقات بمختلف مستوياتها كالعلاقات الزمانية والمكانية والمجردة بين الأشياء والأفكار والوقائع ، ويظهرون مرونة في التفكير في إنتاج البدائل الجديدة والحلول التي تتصف بالجدية والأصالة والحداثة، فالموهوبون يتعلمون عن طريق الاكتشاف، ويرفضون أساليب الحفظ والتقليد

٤- ولعل من أهم خصائص الموهوبين أيضاً تميزهم بالاستقلالية والثقة بالنفس إلى درجة المخاطرة والمغامرة في القيام بالمهام الصعبة وفي تناول الأشياء وتجريبها ، وتلعب دافعية الموهوب المتزايدة دور في رغبته في التعلم وفي الاكتشاف والفضول المعرفي فهو كثير الأسئلة والتساؤل مما يسبب الإزعاج والقلق لوالديه ومعلميه في أحيان كثيرة .

٥- الحساسية للمشكلات والمواقف : إذ أن الموهوب المبدع أكثر حساسية للمشكلات الاجتماعية والمواقف التعليمية ، فهو غالباً ما يميل إلى اكتشاف التناقض في المواقف ، ويظهر العناصر المفقودة في حل المشكلة .

ونظراً لأهمية هذه الخصائص والمميزات لدى الموهوبين المبدعين فقد كانت الأساس التي اعتمد عليها العلماء في بناء اختبارات التفكير الإبداعي التي تؤكد جميعاً على قياس السمات الأساسية الثلاث وهي : الأصالة والمرونة والطلاقة .

٦-لديهم قدرات عقلية عامة وخاصة تفوق غيرهم من العاديين

٧-وأنهم يهتمون باهتمامات علمية وفنية وأدبية وميول تطبيقية للجوانب النظرية

٨-ويفكرون ملياً في حل المشكلات وقدرة عالية على طرح الحلول والبدائل للمشكلة الواحدة

٩-والأطفال الموهوبون ليسوا جميعاً على وتيرة واحدة في القدرات والاهتمامات ، بل يختلفون عن بعضهم البعض شأنهم في ذلك شأن الأطفال العاديين فمنهم من يمتلك خصائص وقدرات عقلية عالية في مختلف المجالات العلمية والأدبية والفنية والتقنية ، ومنهم من يتميز ببعض هذه الخصائص والميزات فقط ، فيكون موهوباً ومبدعاً في لون واحد أو اثنين من ألوان النشاط أو مظاهر الإبداع

١٠=من الناحية الصحية والعضوية ، فغالباً ما يتسم الأطفال والشباب الموهوب بصحة بدنية عالية وقوة وطاقة جسمية مرتفعة تؤهله للقيام بالعديد من الأنشطة والرياضات ، غير أن ذلك لا يعني أن لا يوجد من بينهم ذوي احتياجات خاصة حركياً أو عضوياً وعادة ما تفسر مثل تلك الظواهر الإبداعية لدى هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة عند علماء النفس بالمواهب التعويضية .

سمات أخرى يستنتجها الطالب من الموضوعات (تكليف هام)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

أساليب وأدوات الكشف عن الموهوبين المبدعين :

تتعدد الأساليب والأدوات المستخدمة في الكشف عن الأطفال والطلاب الموهوبين ، وفي التعرف عليهم ، وبعض هذه الأساليب والأدوات تقليدية معروفة منذ القدم وبعضها الآخر يُعد حديث نسبياً . وفيما يلي إشارة موجزة لهذه الأدوات :-

١- الملاحظة : تُعد الملاحظة العلمية لسلوك الأطفال والطلاب وإنجازاتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية ، وتحصيلهم الدراسي من الأدوات المهمة المستخدمة في التعرف على الموهوبين وتوجيه الانتباه إليهم ، وينبغي أن يكون هذا الاهتمام موجهاً للأطفال منذ مراحل مبكرة لتشمل مرحلة ما قبل المدرسة ثم مرحلة التعليم الأساسي .

٢- الاختبارات والمقاييس النفسية : تعد الاختبارات والمقاييس النفسية من الأدوات الموضوعية التي يلجأ إليها الباحثون والأخصائيون النفسيون في قياس القدرات العامة (الذكاء) والقدرات الخاصة : كالقدرة العددية والقدرة اللفظية ، كما أن اختبارات قدرات التفكير الابتكاري من الأساليب الشائعة الآن في اكتشاف الموهوبين من الأطفال و المراهقين والشباب ، ولعل من أشهر تلك الاختبارات اختبار تورانس للتفكير الابتكاري

٣- التقديرات الذاتية للتلاميذ : إذ يمكن للأطفال والتلاميذ أن يفصحوا عن مواهبهم وإبداعاتهم ، ويكشفوا عن طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية عن طريق المقابلات الشخصية فنتعرف على هواياتهم وأساليب ممارستها وكيفية قضاء أوقات فراغهم ، وجميع الأنشطة المدرسية وغير المدرسية التي يمارسونها.

٤- إقامة المسابقات المتعددة والمعارض المدرسية : ومن الأساليب المتعارف عليها في المدارس حالياً إقامة المسابقات الفكرية والأدبية والفنية والرياضية التي تجرى بين الفصول الدراسية في المدرسة الواحدة أو بين مجموعة من المدارس ، وقد تشمل أيضاً إقامة المعارض المختلفة لإبراز مظاهر النشاط المدرسي وكذلك العروض الموسيقية والمسرحية وإقامة الحفلات وهي لا شك تمثل فرصاُ ثمينة لاكتشاف المواهب والتعرف على شخصيات المبدعين .

وهكذا يمكن للمدرسة أن تلعب دوراً مهماً ليس فقط في اكتشاف الموهوبين ، بل في العناية بهم ورعايتهم بوضع برامج لتنمية مواهب الأطفال والطلاب التي تحترم ثقافتهم، وتعمل على إشباع حاجاتهم وتأكيد نجاحهم في المدرسة والبيت وذلك من خلال مد جسور

التعاون والتنسيق بين أسر الموهوبين والمدرسة بما يحقق تشجيع الموهوبين وحفزهم على الإنتاج الإبداعي وتعزيز مكانتهم في المجتمع .

المشكلات والمعوقات التي تواجه الموهوبين المبدعين :

إذا أردنا أن نستقصي المشكلات والعقبات التي تواجه فئة الموهوبين وتعترض مظاهر نموهم الطبيعي ، وتكون سبباً في إحباطهم وفشلهم أحياناً أو تعثر موهبتهم وإبداعاتهم وتأخرها أحياناً أخرى ، فيمكن إرجاعها إلى المصادر التالية التي يتفاعل معها الموهوب وتشكل شخصيته وهي :-

١- مشكلات ذاتية شخصية تتعلق بالموهوب نفسه :-

أ- قد يعاني الطفل الموهوب من مشكلات نفسية تؤدي به إلى سوء التوافق النفسي والاجتماعي : فالموهوب كما أشرنا يتميز بدافعية عالية نحو التعلم ولديه رغبة في البحث والاستطلاع واستكشاف المعرفة ، فهو يفكر في كل ما يجري من حوله ، فإذا ما مر الطفل بخبرات مؤلمة وبخاصة في مراحل حياته الأولى أو أخفقت البيئة في إشباع حاجاته ، فقد يصاب بالإحباط والفشل وينتابه القلق والتوتر ، وتتحول حياته إلى صراعات نفسية داخلية تدمر ذاته وتقتل الإبداع لديه ، فإما القبول بهذا الواقع الذي لا يتوافق مع ذاته وتطلعاته أو التخلي عن تلك الأنشطة الإبداعية ، ويحدث ذلك في جميع المراحل العمرية للطفل ، وفي كل الأحوال تكون الخسارة فادحة للفرد المبدع وللمجتمع بكامله يفقده مثل هذه المساهمات الفردية والإنجازات الجادة مستقبلاً .

ب- يختار الموهوبون من التلاميذ والطلاب أحياناً مسارات من الدراسة أو أنواع من المهن غير مألوفة: لدى الأسرة أو تتعارض مع رغبات الأباء أو يشعرون بأنها لا تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية ، مما يدفع بالأباء إلى الوقوف في وجه أبناءهم ومنعهم من الالتحاق بذلك النوع من الدراسة أو المهنة ، مما يؤدي بهؤلاء الموهوبين إلى التراجع والتقهقر ومن ثم الإحباط والفشل.

٢- مشكلات تتعلق بالبيئة المنزلية :-

أ- يواجه الأطفال الموهوبين بعض المشكلات أو العقبات التي يكون مصدرها المباشر الأباء أو الأخوة أو الأخوات : ولعل أهمها عدم اكتراث الأسرة بمواهب الطفل العقلية أو

الفنية فتتجاهل نشاطاته ، بل تكرهه أحياناً على عدم ممارسته لها ، ولا توفر له الإمكانات المادية والمعنوية مهما كانت بسيطة ، وهكذا قد تعمل الأسرة على وأد الموهبة في مهدها ، فالأطفال الموهوبون غالباً ما ينسحبون ويتخلون عن مواهبهم وممارسة هواياتهم في حالات الفشل المتكرر ، وبخاصة في المراحل الأولى ، وكذلك في حالات الشعور بالخوف والتهديد من قبل أهلهم وذويهم ، وقد يرجع ذلك إلى أن الموهوبين يتسمون بالعواطف الجياشة من ناحية والحساسية الاجتماعية من ناحية أخرى .

ب- قد تتبع الأسرة أساليب خاطئة في عمليات التربية والتنشئة الاجتماعية : فلا تتقبل الطفل ومواهبه ، وتنظر إليه على أنه مشاكس وجالب للمشاكل ، وتطلق عليه ألفاظاً وعبارات لا يقبلها أو تسخر منه ومن طموحاته ، وفي المقابل هناك أنماطاً أخرى من التنشئة الاجتماعية الخاطئة أيضاً ، كأن تبالغ الأسرة في إطلاق عبارات الشكر والثناء على ابنها وتمنحه من العطف والتدليل أكثر من اللازم ، مما قد يؤدي به إلى الغرور والشعور بالاستعلاء والتكبر .

ج- ومن الأخطاء التي يقع فيها الأباء أيضاً أنهم يوجهون أطفالهم ويلقنونهم مفاهيم خاطئة وقوالب جامدة في التفكير: كالقول بأن حل هذه المشكلة أو تلك لا تتم إلا بطريقة واحدة فقط ، وهي كما يدركونها هم وتعودوا عليها ، وما عداها من الحلول والبدائل فهي خاطئة ، وهذا بطبيعة الحال يقتل روح الإبداع لدى الأطفال الذين يمكنهم اكتشاف حلولاً وبدائل أخرى جديدة ، وغير مألوفة لدى الكبار وأولياء الأمور ، مما يؤدى أحيانا إلى أنه يمكن إحباط كل الوظائف الذهنية (لدى الموهوبين) من خلال المنازل غير اللائقة لحياتهم. (٥،ص ١٢٩)

٣- مشكلات وصعوبات تتعلق بالبيئة المدرسية :-

تحتوي البيئة المدرسية على متغيرات متعددة ووسائط متنوعة تلعب دوراً مهماً في تنمية الإبداع وصقل الموهبة لدى الأطفال ذ ما تم استغلالها لصالح الطفل ، وفي المقابل يمكن أن تكون مصدراً لإثارة المشكلات لدى الموهوب فتعرقل نموه وتحد من مواهبه وإبداعاته ولعل من أهم تلك المشكلات ما يلي :-

أ- تثار الكثير من المشكلات في الفصل الدراسي بين الموهوبين والمعلمين بسبب إن الموهوبين كثيراً ما يبحثون عن فرديتهم الخاصة التي تميزهم عن أندادهم في الفصل: فقد يكثرون من الأسئلة حول القضايا والموضوعات التي يدرسونها أو حول الأفكار والحلول التي يطرحونها لمعالجة المشكلات أو أنهم يطرحون حلولاً وبراهين مختلفة غير مألوفة لدى المعلمين

أو يسألون أسئلة صعبة ومعقدة ، فيضيق المعلمون والمدراء بهم ذرعاً فيلجأون إلى قمعهم أو الاستهزاء بأفكارهم وآرائهم وقد يصفونهم بالمشاكسين والمتخلفين وإنهم يثيرون الفوضى في الفصل الدراسي ، وقد نشرت إحدى الصحف الأمريكية عام ١٩٩٢ احتجاج أباء الأطفال الموهوبين في إحدى المدن على الطريقة التي يعامل بها أطفالهم الموهوبين و المبدعين في المدارس ، بوضع الطلاب المبتكرين في نفس الفصول الدراسية للمتخلفين عقلياً وبسبب المشاكل السلوكية التي تحدث بينهم فإنهم يعاملون معاملة المتخلفين عقلياً .

ب- **لما كان الأطفال الموهوبين لا يميلون إلى الحفظ والتلقين** ، بل ينتجون أساليب في التعلم مثل التعلم الاكتشافي والبحث عن المعلومات والحقائق بأنفسهم ، أي باستخدام أسلوب التعلم الذاتي ، كما أنهم يعتمدون على أنماط التفكير القائمة على الملاحظة والاستنتاج والتحليل والتقويم ، أي تلك المستويات العليا في التفكير ، فإنهم كثيراً ما يشعرون بالملل والضيق عندما يستخدم المعلمون طرائق تقليدية في التدريس تقوم على أساليب التلقين والتفكير النمطي ، كما أن المناخ المدرسي التقليدي وقلة الإمكانات المدرسية وعدم توفر الأنشطة المدرسية المتنوعة كالأنشطة الرياضية والموسيقية والفنية وبرامج الرحلات والزيارات ، كل ذلك يبعث على السأم والملل لدى الأطفال والتلاميذ الموهوبين ويعوق نموهم الطبيعي الحر .

الاتجاهات العامة في تربية الموهوبين

أولاً : دمج الموهوبين في المدرسة العادية,للأسباب التالية :

١. المحافظة على التوزيع الطبيعي للقدرات العقلية في الصف العادي .

٢. المحافظة على التفاعل الاجتماعي في الصف العادي .

ثانياً : فتح مدارس خاصة للموهوبين , للأسباب التالية :

١. اعداد كفاءات متخصصة وقيادات فكرية .

٢. توفير فرص الابداع للموهوبين .

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٢ – الإعاقة العقلية : ومن انواعها:-

اضطراب النمو الذهني

تعريف التخلف الذهني: هو عبارة عن نقص في نسبة ذكاء الطفل مما يؤدي الى عدم قدرته على التكيف مع نفسه والبيئة المحيطة به، وذلك من خلال عدم نجاحه بالعناية بنفسه وعدم قدرته على إنشاء علاقات اجتماعيه مع المحيطين به.

او هو التأخر الذهني هو العجز الموصوف بالقيود في سيرورة الوظيفة الذهنية وفي السلوك التكيفي، حسب ما يعبر عنه في القدرات التكيفية، والمفاهيمية، والاجتماعية والممارساتية، تظهر هذه الأنواع من العجز قبل سن ١٨.

تصنيف التخلف الذهني حسب درجة الصعوبة وذلك طبقاً لاختبارات بينيه ووكسلر وهما أكثر الاختبارات شيوعا في الاستخدام:

١. التخلف البسيط –وتتراوح نسبة الذكاء ما بين ٦٩–٥٥

٢. التخلف العقلي المتوسط–وتتراوح نسبة الذكاء ما بين ٥٤–٣٥

٣. التخلف العقلي الشديد–وتتراوح نسبة الذكاء ما بين ٣٤–٢٠

٤. التخلف العقلي الحاد–وتتراوح نسبة الذكاء ما بين ١٩ فأقل.

المعايير الكشف عن التأخر الذهني: تصاب عدة قدرات مهمة لدى الفرد المصاب، وحسب الحالات، البعض منها أكثر نقصا من الأخرى منها:-

- نقص في القدرات المعرفية العامة، مثل (الاستدلال، حل المشكلات، التخطيط، التفكير المجرد، الحكم، التعلم الأكاديمي، والتعلم بالخبرة)
- نقص في الوظيفة التكيفية للفرد حسب سنه وجماعته الثقافية. الوظيفة التكيفية ترجع إلى قدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات الاستقلالية والمسؤولية الاجتماعية في ميدان أو عدة ميادين الحياة اليومية، مثل التواصل، الشراكة الاجتماعية، الأداء المدرسي أو في الشغل والحياة الجماعية. هذه القيود تستتبع حاجة متواصلة للدعم في المدرسة، في العمل أو للاستقلال الوظيفي أثناء الفترة النمائية.
- نقص فى القدرات المفاهيمية: اللغة، الكتابة، القراءة، مفهوم النقود، الاستقلالية.

- نقص فى القدرات الاجتماعية: العلاقات البينشخصية، تحمل مسؤوليات، تقدير الذات، سذاجة، تتبع التعليمات، الخضوع للقوانين.
- نقص فى القدرات العملية: في نشاطات الحياة اليومية (أكل، تنقل، نظافة، ملبس)، نشاطات مساعدة للحياة اليومية (تحضير الطعام، الاعتناء بنظافة البيت، النقل، تناول الأدوية).
- خلل في التمييز الإدراكي، الحفظ والاستئناف، التخيل، التفكير وحل المشكلات.
- هيمنة الوظائف التنفيذية الأولية على الوظائف العليا والرمزية.
- نقص في اندماج بين السرعة والدقة في أداء المهام.
- عدم التناسق النمائي.
- أقل اتصالا بالعين.
- يتمركزون حول أنفسهم ما يؤثر في علاقاتهم بالغير.
- صعوبة في التصور والتعبير عن أفكارهم الشخصية .
- زيادة الأخطاء التربوية واضطرابات العلاقات المبكرة، الحماية الزائدة للأولياء والمحيطين قد شجعت على التبعية الزائدة للآخرين لا يفضي إلى تطوير شبكته الاجتماعية.
- كثير من الباحثين لاحظوا بأن الأطفال المتأخرين عقليا يُظهرون سلوكيات لا اجتماعية والانسحاب وهو على وشك خطر إظهار مشكلات سلوكية سواء في البيت أو في المدرسة. من بين اضطرابات السلوك للأفراد المتأخرين عقليا يوجد سلوكيات إيذاء الذات بشدة متغيرة، الناتجة عن أسباب عضوية، نمائية، أو سلوكيات متعلمة.
- مشاركة اجتماعية صعبة وغير مستقرة
- صعوبات التكيف مع أقرانهم.
- فالأفراد المتأخرون عقليا يكونون عرضة لتنمية إدراك ذات سلبي.
- المراهقون والشباب المتأخرون ذهنيا يواجهون صعوبات في نمو هويتهم، إدراك الذات، وبصفة أخص عند الانتقال إلى سن الرشد، والدخول في أدوار اجتماعية جديدة، هذه الصعوبات مرتبطة بوضعهم الصعب في العلاقات الاجتماعية، واستقلاليتهم، وتبعيتهم العاطفية وتناقضاتهم الداخلية الهامة عن الأطفال الآخرين.

مـسـبـبـات التأخر الذهني:

١- عوامل وراثية: من بين العوامل الوراثية يوجد تشوهات صبغية للعدد أو البنية الصبغيات او أمراض ذات أصل وراثى .

٢- عوامل بيئية: مثل العوامل العضوية تتدخل قبل، أثناء أو بعد الميلاد الإصابة المعدية، تسمم، مرض ولادة المبكرة، الولادة العسرة، جروح وكدمات وتعب عصبي، اختلاف فصيلة الدم جروح وإصابات عصبية بعد الولادة مثل الإصابة بالالتهابات جرثومية، تسمم، صدمات، النقص العاطفي والتربوي والاجتماعي والثقافي، أحداث تتسبب في الانقطاع في الرباط العاطفي، سياق اجتماعي أسري غبر تربوى مثل إبعاد الطفل عن الأسرة، طلاق، أسرة غير تامة أو مغتربة أو مجحفة اجتماعيا.

حاجات الأفراد ذوي التأخر العقلي، نحو حاجات الدعم:

- حاجات مرتبطة بالبيئة المعيشة والسكن.
- حاجات مرتبطة بصحتهم الجسدية.
- حاجات مرتبطة بصحتهم العقلية وراحتهم النفسية.
- حاجات الانشغال بنشاطات مرتبطة بالعمل، والشغل والترفيه.
- حاجات مرتبطة بالوضع في البيئة والمجتمع.
- الحاجة إلى المعرفة والتربية والتعلم,
- الحاجات إلى تكوين البنية الفضائية المكانية، الزمانية والنشاط فيها.
- حاجات الحياة الاجتماعية والعلاقات الشخصية.
- الحاجات إلى الاحترام والحماية بالقوانين.

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٣-الاعاقة السمعية

الخصائص السلوكية لذوي الاحتياجات الخاصة **سمعياً:**

يعد النمو اللغوي اكثر مظاهر النمو تأثراً بالاعاقة السمعية، وهنالك علاقة طردية واضحة بين درجة الإعاقة السمعية من جهة ومظاهر النمو اللغوي من جهة اخرى، ومما يدل على أثر الاعاقة السمعية على النمو اللغوي وفيما يلى مظاهر الاعاقة السمعية:-

مظاهر الاعاقة السمعية:-

١. الطفل الاصم لا يتلقى اي رد فعل سمعي اوتعزيز لفظي من الآخرين، عندما يصدر اي صوت من الاصوات.
٢. صعوبات في سماع الاصوات وتميزها وبالتالي مشكلات في التعبير اللغوي.
٣. صعوبات في التعبير عن بعض المفاهيم وخاصة المجردة منها.
٤. الذكاء افراد هذه الفئة لا يتأثر بالاعاقة السمعية ولا تتأثر قابليتهم في التعليم ما لم يكن لديهم مشاكل اخرى في الدماغ وان قصورهم في اختبارات الذكاء تعود للمشاكل اللغوية التي يواجهونها لذلك هناك انخفاض اداء ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية على اختبارات الذكاء اللفظية، مقارنة مع أدائهم على اختبارات الذكاء الادائية .
٥. ادراك المفاهيم لديهم ضعيفة وخاصة اللفظية.
٦. تؤثر الاعاقة السمعية بشكل كبير وواضح على النمو اللغوي للطفل ولما كانت جوانب التحصيل الاكاديمي والمدرسي مرتبطة بشكل واضح بالنمو اللغوي، فان من الطبيعي ان تتأثر جوانب التحصيل المدرسي للطفل الاصم وبشكل خاص في مجالات، القراءة، الكتابة، والحساب، وذلك بسبب اعتماد هذه الجوانب التحصيلية اعتماداً اساسياً على النمو اللغوي حيث ان مستوى التحصيل الاكاديمي للطفل يتأثر بعدد من العوامل، ومن أهمها: درجة السمع- دافعية الطفل الاصم للتعلم- طريقة التعليم- نسبة الذكاء.
٧. ان التحصيل الاكاديمي لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً يزداد ضعفاً مع ازدياد المتطلبات اللغوية ومستوى تعقيدها خاصة في غياب فاعلية اساليب جديدة في التعليم، و ان التأخر الدراسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية يتركز في فهم معاني الكلمات، والمصطلحات، والفقرات، ويقل هذا التأخر في مواد الحساب والتهجي .
٨. صعوبة فهم الآخرين، سواء على المستوى الاجتماعي ومجال العمل او بالاشخاص المحيطين بهم.

٩. ويعتمدون على الآخرين وانهم اكثر خوفاً وقلقاً من الاطفال الاسوياء.
١٠. البنات الصم في عمر الطفولة الأولى متمركزات حول ذواتهن او مترددات، وان عوامل التحكم بالسلوك غالباً ما تكون خارجية.
١١. قليل التبادل العاطفي والتخاطب مع الوالدين.
١٢. وان ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة السمعية كثيراً ما يتجاهلون مشاعر الآخرين ويسيئون فهم تصرفاتهم، ويتمركزون حول الذات .
١٣. لدى الاطفال الصم مشكلات سلوكية تفوق المشكلات المماثلة لدى الاطفال الاسوياء ممن هم في سنهم.
١٤. ارتفاع درجاتهم فى اختبارات الانطوائية والعصبية.
١٥. انخفاض درجاتهم فى اختبارات القدرة على تحمل المسؤولية.
١٦. انخفاض درجاتهم فى اختبارات النضج الاجتماعي و التكيف الاجتماعي و النضج العاطفي.
١٧. تظهر مخاوف لدى البنات الصم اكثر منها لدى الذكور.
١٨. يميلوا الى الاعمال التي ليس لها اتصال كبير مع الآخرين.
١٩. مشكلات فى التوازن في مختلف الوضعيات عند التنقلات والسير.
٢٠. يعانون من قصور بدرجة كبيرة في المهارات الاجتماعية.
٢١. يتفوقون عند تفاعلهم مع أقرانهم الصم مقارنة بتفاعلهم مع العاديين أو حتى بتفاعل العاديين مع بعضهم البعض.
٢٢. يلجؤون إلى التلامس الجسدي للفت الانتباه إليهم.

ملاحظة هامة: على ان الصمم لا يقود بالضرورة الى سوء التوافق النفسي، ولا يعني ايضاً ان الصفات السلوكية النفسية المذكورة تنطبق على الجميع، فالاعاقة السمعية قد لا تقود الى سوء التوافق النفسي، وعلى الرغم من اعتقاد البعض ان لفاقدي السمع سمات نفسية وفاعلية مميزة وفريدة.

تشخيص وقياس الإعاقة السمعية

ان موضوع تشخيص وقياس الاطفال ضعاف السمع وفاقدي السمع السمع يهدف الى تحقيق الى الاهداف الآتية:

١. تحديد العتبة السمعية: وهو المستوى الذي يستطيع معه المفحوص سماع الصوت (شدة الصوت).

٢. تحديد الخدمة اللازمة للفرد (خدمات تربوية او مدرسية).

٣. تحديد نوع السماعة المناسبة والملائمة.

٤. تحديد حالة ضعف السمع لدى الفرد، هل هي توصيلية ام حسية عصبية.

٥. تحديد التطور في الاعاقة السمعية حيثا ما اجرى الفحص بين فترة واخرى.

٦. تحديد نوع البرنامج التربوي الفردي أو العام المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً.

ان عملية القياس تمكن الاخصائي من الحصول على معلومات كمية عن ظاهرة الاعاقة السمعية، ولو كشفت حالات ضعف السمع في سن مبكرة (اقل من ثلاث سنوات) لايمكن انقاذ ٨٥٪ منهم من الصم هنالك عدة طرائق واساليب لتشخيص وقياس القدرة السمعية، وبشكل عام يمكن تقسيمها الى مجموعتين:

المجموعة الاولى: وتمثل الطرائق التقليدية في قياس وتشخيص القدرة السمعية ومنها:

أ. اختبار الهمس (Whispering Test): وفيه ينطق القائم بالاختيار بمجموعة من الكلمات همساً بغير ما ترتيب، على ان يقف خلف الطفل أو بجانبه حتى لا يقرأ ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية شفاهه، ويكون الهمس باتجاه أحدى اذني الطفل، ثم الأخرى.

اختبار الساعة الدقاقة (Watch-tick Test): تجرى هذه التجربة على بعد مناسب من الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة السمعية ثم تقرب منه الى أن يسمعها (أو لا).

ب. اختبار الصوت الطبيعي للأنسان (The Spoken Voice Test): وفيه تسد احدى الاذنين بقطعة من المطاط او القطن ويقف الفرد بجانب الطفل من على مسافة ٦م ثم يوجه له عدة اسئلة، فاذا لم يسمع الطفل الصوت يتقرب الطفل نحو الفرد الى ان يصبح اخيراً على بعد سنتيمترات منه (فهمي، ١٩٧٧، ص١١٤).

المجموعة الثانية: وتمثل الطرائق العلمية الحديثة في قياس وتشخيص القدرة السمعية، وغالباً ما يقوم باجراء تلك الطرائق، اخصائي في قياس وتشخيص القدرة السمعية ويطلق عليه مصطلح وهي:

أ. طريقة القياس السمعي الدقيق (Pure-Toue Audiometry) وفي هذه الطريقة يحدد اخصائي السمع درجة/ عتبة القدرة السمعية بوحدات تسمى هيرتز (Hertz) والتي تمثل عدد الذبذبات الصوتية في كل وحدة زمنية، وبوحدات أخرى تعبر عن شدة الصوت تسمى ديسبل (dB) حيث يقوم الاخصائي بقياس القدرة السمعية للفرد بعرض على المفحوص اصواتاً ذات ذبذبات تتراوح ما بين (٨.٠٠٠-١٢٥) وحدة هيرتز وذات شدة تتراوح ما بين (صفر-١١٠)

وحدة ديسبل. وعلى ضوء ذلك بقرر الفاحص مدى النقاط/ سماع المفحوص للاصوات ذات الذبذبات والشدة المتدرجة، لكل اذن.

جدول درجات القدرة السمعية لدى كل فئة من فئات القدرة السمعية

مقاسة بوحدات ديسبل

درجات القدرة السمعية	وحدة ديسبل
السمع السوي	٠-٢٠
الاعاقة السمعية البسيطة	٢٠-٤٠
الاعاقة السمعية المتوسطة	٤٠-٧٠
الاعاقة السمعية الشديدة	٧٠-٩٠
الاعاقة السمعية الشديدة جداً	اكثر من ٩٠

ب. طريقة استقبال الكلام وفهمه (Speech Audiometry):

وهي الطريقة العلمية الحديثة الثانية التي يستخدمها الاخصائيون في قياس وتشخيص القدرة السمعية، وفيها يعرض الفاحص امام المفحوص اصواتاً ذات شدة متدرجة ويطلب منه أن يعبر عن مدى سماعه وفهمه للأصوات المعروضة عليه

جـ. الاختبارات التربوية المقننة (مقياس ويب مان للتمييز السمعي) الطريقة الثالثة العلمية الحديثة التي يستخدمها الاخصائي في قياس وتشخيص القدرة السمعية فهي اختبارات التمييز السمعي المقننة، ومنها مقياس ويب مان للتمييز السمعي ومقياس جولدمان فرستو ودكوك للتمييز السمعي

تهدف هذه المقاييس الى تقييم المفحوص على التمييز السمعي وخاصة بين الاصوات المتجانسة، ويصلح للاطفال ماقبل المدرسة الابتدائية ويمكن تطبيقه من قبل المعلم أو الام أو اخصائي السمع، ويعطي عند تطبيق هذه الاختيارات درجة درجات تقديرية تمثل أداء المفحوص على الاختبار، ويستغرق تطبيقه حوالي ١٠-١٥ دقيقة وتصحيحه من ٥-١٠ دقائق، وتعد من المقاييس المقننة الفردية .

أسباب الإعاقة السمعية

يميل معظم التربويين الى تقسيم اسباب الاعاقة السمعية الى مجموعتين رئيستين ومن هذه الاسباب ما يأتي:

الاولى: مجموعة الاسباب الخاصة بالعوامل الوراثية (الجينية): كثيراً ما تحدث حالات الاعاقة السمعية الكلية ام الجزئية نتيجة انتقال بعض الصفات الحيوية او الحالات المرضية من الوالد عن طريق الوراثة او من خلال الكروموسومات الحاملة لهذه الصفات كضعف الخلايا السمعية او العصب السمعي، ويقوي احتمال الزواج من الاقارب ممن يحملون تلك الصفات وتظهر الاصابة بالصمم الوراثي منذ الولادة (صمم او ضعف سمع ولادي) حتى سن الثلاثين أو الاربعين كما هو الحال في مرض تصلب عظيمة الركاب لدى الكبار ممن يتعذر معه انتقال الموجات الصوتية نتيجة التكوين غير السليم او الاتصال الخاطئ لهذه العظيمة بنافذة الاذن الداخلية، وكذلك مرض ضمور العصب السمعي (٢ ، ص٩).

الثانية: مجموعة الاسباب الخاصة بالعوامل البيئية والتي تحدث بعد عملية الاخصاب، أي قبل مرحلة الولادة، وخلالها، وبعدها، وهنا يمكن ذكر مجموعة من الاسباب التي تؤدي الى الصمم منها: سوء تغذية الام الحامل التعرض للاشعة السينية، وخاصة في الاشهر الاولى الثلاثة من الحمل، وتعاطي الام الحامل الادوية والعقاقير دون مشورة طبيب، واصابة الام الحامل بالحصبة الالمانية، ومرض الزهري، ونقص الأوكسجين خلال عملية الولادة، والتهابات الاذن، والحوادث التي تصيب الاذن....الخ.

كما يمكن تقسيم اسباب الاعاقة السمعية حسب مكان الإصابة في الاذن وهنا يمكن ان تميز ثلاث مجموعات من الإصابة:

١. اصابة طرائق الاتصال السمعي (Conductive Hearing Loss):

وتمثل الاصابة هنا خللاً في طرائق الاتصال السمعي وغالباً ما تؤدي الاسباب هنا الى اصابة الاذن الخارجية والوسطى، مثل الحالة المسماة (Atresia) القناة المغلقة ولادياً، والتي تبدو في صعوبة تشكيل قناة الاذن الخارجية او الالتهابات التي تصب قناة الاذن الخارجية، وكذلك الحالة المسماة (Otitis Media) والتي تبدو في التهاب الاذن الوسطى والتي قد تنتج بسبب التهاب قناة استاكيوس (Eustachian Tube) او بسبب الحساسية (Allergy)، وغالباً ما تكون نسبة الخسارة السمعية نتيجة لهذه الاسباب أقل من ٦٠ وحدة ديسبل.

٢. إصابة طرائق الاتصال الحسي العصبي (Sensor neural):

وتمثل الاصابة هنا خللاً في طرائق الاتصال الحسي العصبي، وغالباً ما تؤدي الاسباب هنا الى اصابة الاذن الداخلية، والتي تشكل مشكلة رئيسة لدى الاطباء والمدربين على حد سواء، وتمثل الحالة في اصابة الاذن الداخلية، وتبدو اعراض الحالة في صعوبة فهم الكلام او اللغة المنطوقة لدى الفرد، وكذلك في الحالة التي تظهر اعراضها في طنين الاذن، وغالباً ما تكون نسبة الخسارة السمعية نتيجية لهذه الاسباب اكثر من ٦٠ وحدة ديسبل (٣، ص١٤٣).

تصنيف الاعاقة السمعية

تصنيف الاعاقة السمعية وفق بعدين رئيسيين:

أولاً: العمر الذي حدثت فيه الاعاقة السمعية: وتصنف الاعاقة السمعية وفقاً لهذا البعد الى:

أ. صمم ما قبل تعلم اللغة: ويطلق هذا التصنيف على تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية من الذين فقدوا قدرتهم السمعية قبل اكتساب اللغة، اي قبل سن الثالثة، وتتميز هذه المجموعة بعدم قدرتها على الكلام لانها لم تسمع اللغة.

ب. صمم ما بعد تعلم اللغة: ويطلق هذا التصنيف على تلك الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية الذين فقدوا قدرتهم على السماع كلياً أو جزئياً بعد اكتساب اللغة، وتتميز هذه الفئة بقدرتها على الكلام، لانها سمعت وتعلمت اللغة

ثانيا – محور الخسارة السمعية تصنف الاعاقة السمعية حسب مقدار ما فقده الفرد من القدرة السمعية بالديسبل وكما يأتي:

- **الاعاقة السمعية البسيطة:** ومقدار الخسارة السمعية عند هذه المجموعة من ٢٠–٣٩ ديسبل وهؤلاء يواجهون صعوبات بسيطة في السمع، ويستطيعون التعلم ضمن مدارس الاسوياء.
- **الاعاقة السمعية المتوسطة** ومقدار الخسارة السمعية عند افراد هذه المجموعة ٤٠–٦٩ ديسبل، ويواجه هؤلاء صعوبة اكبر من الفئة السابقة في السمع وفهم الكلام، ويستطيعون التعلم في المدارس السوية حيث ما استخدموا المعينات السمعية.
- **الاعاقة السمعية القوية** ومقدار الخسارة عند هذه المجموعة ٧٠–٨٩ ديسبل، وهؤلاء يحتاجون الى خدمات خاصة.

- **الاعاقة السمعية الشديدة جداً** : الخسارة السمعية عند هؤلاء تزيد عن ٩٠ ديسبل، ويحتاجون الى خدمات خاصة، وهم لا يستطيعون الكلام بشكل مفهوم حيث ان حدثت الاعاقة قبل تعلم الكلام .

اهداف تعليم الطفل الاصم

قبل ان ندخل الى موضوع البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً لا بد لنا من معرفة الاهداف التربوية والسلوكية من تعليم الطفل الاصم، كما هو الحال عليه مع الاطفال الاسوياء، وهنا يمكن ان نحدد الاهداف الاتية لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية ومن اهمها:

١. اعداد الطفل الاصم للتعايش مع مجتمعه وبيئته.
٢. اعداد الطفل الاصم الاعتماد على نفسه، وان لا يعتمد على الاخرين.
٣. تعليم الطفل الاصم القراءة والكتابة والمحادثة ضمن قدراته وامكانياته.
٤. تزويد الطفل الاصم بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعده على الاستمرار في تعليمه وفهم بيئته.
٥. مساعدة الطفل الاصم على النمو السوي جسمياً وعقلياً واجتماعياً.
٦. تهيأة الطفل الاصم مهنياً ضمن قدراته وامكاناته.
٧. تنمية مهارات الاتصال مع الآخرين بالطريقة الشفوية قدر الامكان.
٨. فهم البيئة المحيطة والاستفادة من امكانياتها في الاستغلال الذاتي وخدمة المجتمع

البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة **سمعياً:**

يقصد بالبرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً، طرائق تنظيم تعليم وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية ، ويمكن ان تميز في هذا المجال اكثر من طريقة من طرائق تنظيم البرامج التربوية ومنها:

١. **مراكز الاقامة الكاملة** لذوي الاحتياجات الخاصة **سمعياً:** وتعد مراكز الاقامة الكاملة (الدائمة) من اقدم البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً، ويميل الاتجاه التربوي الحديث الى الاستغناء عن هذه الطريقة ويفضل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية في الصفوف الخاصة الملحقة بالمدارس السوية او حتى في الصفوف السوية المخصصة للاطفال الاسوياء، لكون التفاعل والاختلاط واكتساب العادات هو جزء من عملية

العلاج والنمو العقلي والاجتماعي للاطفال ولكن هذه الطريقة مازالت قائمة حيثا كان هنالك عوق مصاحب للاعاقة، وفي معظم دول العالم الثالث.

٢. **مراكز التربية الخاصة النهارية** لذوي الاحتياجات الخاصة **سمعياً:** وهي مدارس او صفوف منفصلة عن مدارس التعليم العام، ينظم الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً اليها في الصباح وبعد ان يتلقى التربية والتعليم فيها ليوم دراسي كامل، يرجع الى البيت

٣. **دمج ذوي الاحتياجات الخاصة** أصحاب الاعاقة السمعية **في صفوف خاصة ملحقة في المدرسة السوية:** تعد هذه الطريقة في الوقت الحاضر من اكثر الطرائق انتشاراً وفائدة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية ، وقد طورت هذه الطريقة بحيث اصبح الطفل يستطيع حضور الحصص غير الاساسية في الصفوف الاعتيادية (الرسم، الرياضة، الفنون، النشيد.....الخ) ويبقى في صفه الخاص في مواد (القراءة، الحساب، الهجاء).

٤. **دمج ذوي الاحتياجات الخاصة** أصحاب الاعاقة السمعية **في الصفوف السوية في المدارس السوية:** وهذه الطريقة من احدث الطرائق في تعليم وتربية اللاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية ، الاّ انها تحتاج الى تهيأة عوامل النجاح كالمعلم المدرب وصف مزود ببعض التقنيات السمعية المساعدة

ومهما كان شكل تنظيم البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً ومبرراته فلابد من ان تتضمن البرامج التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً تعليم وتدريب عدد **من المهارات الاساسية في تعليمهم مثل:**

- مهارة التدريب السمعي (Adutiry Turning Skill).
- مهارة قراءة الشفاه (لغة الشفاه) (Seach or lip reading skill).
- مهارة لغة الاشارة والاصابع (Sign language and finger spilling skill).
- مهارة الاتصال الكلي (Total communication skill).

مهارة التدريب السمعي

ويقصد بذلك تدريب الافراد ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية وعلى مختلف مستوياتهم السمعية على مهارة الاستماع والتعبير عن الاصوات، او الكلمات، ويحتاج الفرد الى هذه المهارة كلما قلت درجة السمع لديه، ومهمة المدرب تنمية تلك المهارة واستخدام الدلائل البصرية والمعينات السمعية وطريق تدريس مختلفة والمعينات السمعية لانجاح المهمة، وهناك ثلاثة اهداف لمهارة التدريب السمعي:

١. تنمية وعي الطفل الاصم للاصوات.

٢. تنمية مهارة التمييز الصوتي لدى الطفل الاصم وخاصة بين الاصوات العامة غير الدقيقة.

٣. تنمية مهارة التعبير الصوتي لدى الطفل الاصم وخاصة بين الاصوات المتشابهة الدقيقة.

ويستخدم بعض المدربين الاضاءة للمساعدة على الاحساس بالصوت والتسجيل الصوتي او الطرائق على اجسام مختلفة مع التنوع بالاحساس وتكرر هذه العملية حتى تتحقق الاهداف.

- **مهارة قراءة الشفاه (لغة الشفاه)**

وهي وسيلة من وسائل تنمية مهارة ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية على ملاحظة الشفاه وقرائتها وفهمها، ويعني ان يفك الاصم الرموز البصرية بحركة الفم والشفاه خلال الكلام من قبل الآخرين، ويذكر ساندارس طريقتين لتنمية هذه المهارة هي:

١. الطريقة التحليلية: وفيها يركز ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية على كل حركة من حركات شفتي المتكلم، ثم ينظمها معاً لتشكل المعنى المقصود.

٢. الطريقة التهذيبة وفيها يركز ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية على معنى الكلام اكثر من تركيزه على حركة شفتي المتكلم لكل مقطع من مقاطع الكلام. وتعتمد هذه الطريقة في نجاحها على مدى فهم ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية للمثيرات البصرية المصاحبة للكلام الموجودة في بيئة الطفل الاصم، كتعبيرات الوجه، وحركة العينين، ومدى سرعة المتحدث ومدى الفة موضوع الحديث، ومدى مواجهة المتحدث لذوي الاحتياجات الخاصة سمعياً والقدرة العقلية للاصم، وارتفاع او انخفاض صوت المتحدث.

- **تطبيق :- كيفية تعليم كلمة لقراءة الشفاه:**

يمكنك البدأ في تعليم الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الاعاقة السمعية قراءة الشفاه (الكلام) بعد عمر سنتين، الجلوس امام الطفل ونعرض عليه شيئاً (كرة) ثم ننطق لفظ كلمة (كرة) مع تحريك الشفتين بكل وضوح عن طريق النطق ببطأ وندع الطفل يدرك حركة الشفتين باصابعه ومراقبة تعبيرات وجهه، نكرر نطق الكلمة عدة مرات، وندع الطفل يلمس شفتي المتحدث ويراقب وجه المتحدث ثم ترك الطفل يقلد المتحدث، مع وضع اصابعه على فمه حتى يمكنه الاحساس بشفتيه هو، نجعله يكرر الكلمة عدة مرات مع الاشارة الى الـ(الكرة).

- **مهارة لغة الاشارة والاصابع وتوقيت تعلمها:**

تعرف لغة الاشارات على انها نظام حسي بصري يدوي يقوم على اساس الربط بين الاشارة والمعنى، وهي على ثلاثة انواع:

١. الاشارات الوصفية: وهي الاشارات اليدوية التي تصف فكرة معينة، وقد يستخدمها الاسوياء في تعبيراتهم، وتكون موافقة مع الكلام، كرفع اليد للتعبير عن الطول، او فتح الذراعيين للتعبير عن الكثرة، او تضييق المسافة بين الابهام والسبابة للدلالة على الصغر، ويستخدمها عادةً السويون والصم

٢. الاشارات غير الوصفية: وهي الاشارات التي تدل على فعل او صفة او ضمير، وتعد هذه الاشارات بمثابة لغة خاصة بالصم، مثل الاشارة للاعلى تدل على احسن وافضل، او رفع الابهام للدلالة على ((عمل صح)) او ((جيد)) او انزاله للدلالة على عمل سيء، وتوجد ادلة خاصة بكل دولة للاشارات المتعلقة بلغة الصم كالبريطانية والامركية والفرنسية والعربية

٣. لغة الاصابع: وهي اشارات حسية مرئية يدوية للحروف الهجائية بطريقة متفق عليها في مجتمع معين فهناك لغة الاصابع الامريكية والبريطانية والسويدية، وفي المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم والمنعقدة في عمان ١٩٨٦ قدمت بعض الدول العربية (سوريا والاردن والكويت وليبيا) مشروعات للارقام والحروف العربية .(٥، ص)

توقيت تعلم استراتيجيات لغة الاشارة

ان تعلم لغة الاشارات بوقت مبكر له فوائد كبيرة كما هو الحال مع اللغة المنطوقة، حيث تسهم في النضج المعرفي والفكري للاصم، فسلوك الاشارة يتصل بالسلوك البدائي لجسم الطفل، ويرى الباحثون ان هنالك ستراتيجيات لتعلم لغة الاشارة، (٦ ، ص٤٥).

١. التهيئة وتكون في عمر اقل من ثلاث سنوات وهي استغلال الاشارات والايماءات الطبيعية لدى الطفل الاصم الناتجة من الحالة الداخلية لديه، ومن هذه الاشارات التعبير عن الجوع، العطش، طلب المساعدة تصاحبها تعبيرات لفظية وحركية.

٢. الاتفاق ويبدأ بعد سن ثلاث سنوات، تتصل هذه المرحلة بتعلم اشارات تدل على معنى القبول والرفض والموافقة، ويرى الباحثون ان هذه الاشارات موجودة اصلا لدى الفرد ودور الاسرة هو تهذيب هذه الاشارات والاتفاق مع الطفل عليها.

٣. الانتقال: وتكون في سن خمس سنوات، حيث ينتقل الطفل الاصم للمشاركة مع الاطفال الآخرين والاختلاط بينهم، وهنا يكون بحاجة الى تحمل مسؤولية الاعتماد على قدراته بان يتعلم اشارات اكثر صعوبة كاشارات الحركة، والملكية والشكوى.... الخ.

٤. الاثراء: وتبدأ من سن ست سنوات، وتشمل تعلم كل معلومات السنوات السابقة مع محاولة اضافة الحصيلة اللغوية التي يستطيع من خلالها التكيف مع البيئة كأشارات انواع العمل، والبيئة، والحياة.

٥. الاستقلال: وتكون بعد سن ست سنوات وفيها يكون الطفل قادراً على الفهم والتعامل بلغة الاشارة ويحتاج الى القدرة الشخصية لتنفيذ ما تعلمه والاستفادة منه في المعرفة التربوية والمهنية.

مهارة الاتصال الكلي:

ظهرت هذه الطريقة في الاتصال بين الصم او معهم نتيجة للانتقادات التي وجهت لكل من طريقة قراءة الشفاه، وطريقة التدريب السمعي، والذي يطلق عليه الاتجاه الشفوي (Oral Approach) وطريقة لغة الاشارات وابجدية الاصابع، والذي يطلق عليه اسم الاتجاه اليدوي (Manual Approach) وتعني تعليم الطفل الاصم في نظام تعليمي واحد يدعى الاتصال الكلي واهم الانتقادات الموجهة للانظمة السابقة هي:

١. صعوبة فهم الطفل الاصم للمتحدث بطريقة لغة الشفاه بسبب السرعة او صعوبة الموضوع او مدى مواجهته للاصم.

٢. صعوبة فهم الطفل الاصم للمتكلم بطريقة التدري السمعي، بسبب القدرة السمعية المتبقية للاصم، ومدى فاعلية الوسائل السمعية لديه.

٣. صعوبة نشر اللغة الاشارية او ابجدية الاصابع بين كل الناس ويعني ذلك اعتماد فهم الطفل الاصم للآخرين على مدى نشر تلك اللغة بين الناس، وهو ليس بالامر السهل، بل قد يقتصر فهم الاصم على الآخرين الذين يتقنون لغة الاشارة او ابجدية الاصابع، وبسبب تلك الانتقادات مجتمعة ظهرت الطريقة الجديدة وهي الطريقة التي تجمع بين كل تلك الطرائق في الوقت نفسه، ففي هذه الطريقة يتحدث المتكلم بصوت واضح ومسموع وبسرعة عادية لحركة الشفاه، وفي الوقت نفسه، يعبر عن ما يتكلم بلغة الاشارة والاصابع معاً.

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٤-الاعاقة البصرية

مفهوم الإعاقة البصرية:

الشخص الكفيف من وجهة نظر الأطباء هو ذلك الشخص الذي لا تزيد حدة إبصاره عن ٢٠٠/٢٠ قدم (٦٠/٦ متر) في أحسن العينين أو حتى في استعمال النظارة الطبية، وتفسير ذلك أن الجسم الذي يراه الشخص العادي في إبصاره على مسافة ٦٠ مترا، يجب أن يقرب إلى مسافة ٦ أمتار حتى يراه الشخص الذي يعتبر كفيفا حسب هذا التعريف.

والكفيف من الناحية التعليمية هو الذي تبلغ إعاقته البصرية من الحدة تحتم عليه القراءة بطريقة برايل.

تصنيف الإعاقة البصرية: التصنيف من حيث العجز الكلي والعجز الجزئي، فالأول يخص المجموعة التي ينطبق عليها التعريف القانوني والتربوي للإعاقة البصرية؛ وأما الثاني فيعني تلك المجموعة التي تستطيع أن تقرأ الكلمات المكتوبة بحروف كبيرة أو باستخدام النظارة الطبية أو أية وسيلة تكبير. وتتراوح حدة الإبصار لدى هذه المجموعة ما بين ٧٠/٢٠ إلى ٢٠٠/٢٠ قدم أي بين ٢١/٦ إلى ٦٠/٦ متر في أحسن العينين أو حتى في استعمال النظارة الطبية.

مظاهر الإعاقة البصرية:

- طول النظر: يعاني المصاب من صعوبة في رؤية الأجسام القريبة.

- قصر النظر: وهو عكس طول النظر، حيث أن الفرد يواجه صعوبة في رؤية الأجسام البعيدة بوضوح.

- حالة صعوبة تركيز النظر (اللابؤرية): وتبدو مظاهر هذه الحالة في صعوبة رؤية الأشياء بشكل مركز.

- الحول: وهو عبارة عن اختلال وضع العينين أو إحداهما مما يعيق وظيفة الإبصار عن الأداء الطبيعي.

أسباب الإعاقة البصرية:

- أسباب ما قبل الولادة: وتشمل العوامل الوراثية والبيئية وإصابة الأم الحامل ببعض الأمراض.

– انفصال الشبكية: ينجم انفصال الشبكية عن جدار مقلة العين عن ثقب في الشبكية مما يسمح للسائل بالتجمع الأمر الذي ينتهي بانفصال الشبكية عن الأجزاء التي تتصل بها، ومن أهم أعراض انفصال الشبكية لعدة أسباب منها إصابات الرأس وقصر النظر الانتكاسي والسكري.

– انتكاس النقطة المركزية: اضطراب في الشبكية يحدث فيه تلف في الأوعية الدموية في النقطة المركزية يواجه الشخص فيه صعوبة في رؤية الأشياء البعيدة القريبة معا، وهذا المرض يصيب الكبار في السن ويصيب الإناث أكثر من الذكور، ويؤدي هذا الاضطراب إلى فقدان البصر المركزي والبصر المحيطي المتبقي لا يكفي لتأدية الأعمال القريبة من العين كالكتابة والقراءة والأعمال اليدوية.

– الخلع العدسي: اضطراب تصبح فيه عدسة العين مزاحة عن موقعها التشريحي الطبيعي مما يقود إلى ضعف بصري واحمرار في العين.

خصائص ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الإعاقة البصرية:

١. احمرار العين المستمر.
٢. كثرة الإدماع ووجود إفرازات غير طبيعية في العين.
٣. وضع غير طبيعي للرأس عند ملاحظة شيء أو القراءة أو الكتابة.
٤. تقريب أو إبعاد الأشياء أو المادة المقروءة بشكل واضح.
٥. التعثر والاصطدام بالأشياء أثناء المشي أو الحذر الشديد.
٦. صعوبة التمييز بين الألوان المختلفة.
٧. إغلاق أو حجب إحدى العينين وفتح الأخرى بشكل متكرر.
٨. حرقان شديد ومستمر في العينين يؤدي إلى فركهما.
٩. يوجد هناك قصور في مهارات التناسق الحركي والتآزر العضلي نتيجة قلة فرص النشاط الحركي المتاح من جهة، ونتيجة الحرمان من فرص التقليد لكثير من المهارات الحركية.
١٠. غالبا ما يتصف أغلب لذوي الاحتياجات الخاصة بصريا بلازمات حركية نمطية تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف درجة الإعاقة، وهي حركات نمطية متكررة؛ إلا أن ذلك لا يخص بالضرورة المكفوفين فحسب وإنما يتعدى إلى المتخلفين ذهنيا والمضطربين سلوكيا.
١١. لا تؤثر الإعاقة البصرية في النمو المعرفي في الأشهر الأولى من العمر، لكن عند بداية الحاجة إلى التعامل مع البيئة التي من خلالها يكتسب كثيرا من الخبرات نجده لا يقوى على ذلك مما يجعله يعاني من صعوبات في عمليتي التمثيل والمواءمة، بسبب محدودية هذه

الخبرات البيئية، وكذلك صعوبات في مفهوم اللون والعلاقات المكانية ومفهوم الوقت والأبعاد والمسافات.

١٢. وبالنسبة للقدرة العقلية، رغم أن القدرة العقلية تكون سليمة من الناحية الفيزيولوجية (وظائف الاعضاء)، إلا أنه لديهم مشكلات في إدراك واستيعاب المفاهيم والتصنيف للموضوعات المجردة والتخيل.

١٣. مشكلة الوضعية: يصعب على المكفوف أن يتموضع في الفضاء حسب الاتجاهات المكانية لعدم إدراكه لهذه الفضاءات التي تحيط به.

١٤. مشكلات التنقل: لا يتحرك الطفل الكفيف تلقائيا، وهنا نعني الفقر في الحركة التلقائية. فحركاته ليست ذات دافعية وليست موجهة نحو هدف معين، نظرا لنقص المثيرات البصرية التي تخبره بوجود أشياء، ومظاهر مهمة في البيئة التي تمنحه الرغبة في الحصول على هذه الأشياء أو هذه البيئة.

١٥. يكون تطور المشي بطيئا وصعبا عن الطفل المبصر. فالمشي الاستقلالي يكون ما بين ١٥ شهرا و٣ سنوات، أي في المتوسط بحوالي ١٥ شهرا. نظرا لنقص المعلومات البصرية التي تغير المرجعية للفضاء، يعاني الطفل الصغير المكفوف من صعوبات استباق، تسيير وتوجيه خطواته.

١٦. مشكلة بناء التصور الجسدي والوعي الجزئي للجسد: إن غياب دخول التدفق البصري يجعل بناء تصورات الصورة الجسدية أو تعيين الأحداث في الفضاء القريب للطفل المكفوف أمرا صعبا للغاية إذن ينمو التصور الجسدي ببطء واضح فمن خلال لمس الجسد، وجه الشخص الآخر ولوجهه يتمكن من بناء تصوره الجسدي.

١٧. البدائل الحسية منه التمييز السمعي واللمسي الشم والذوق مرتفع لديهم فعن عن طريق اللمس يكتشف وجهي الوالدين، توجه الرأس، المحاولة من أجل الوصول إلى الأشخاص والأشياء، أو ردود أفعال انتباهية وعاطفية إيجابية أو سلبية حيث تتكوّن لديهم مكتبة صوتية من خلال إدراك الفروق الدقيقة في الصوت، الاستدعاءات الحركية، واللفظية والسمعية التي ينبغي أن تكمّل هي أيضا هذه المعلومات لبناء تصورات ذهنية كما ان الإدراك الشمي والسمعي يمكن أن تقدم له معلومات حول مواقع أو طبيعة الأشياء، المسافة التي يمكن له أن يتنقل فيها. حتى وإن كانت هذه البدائل تأثيرات إيجابية، فلا يمكنها أن تعوض وظيفة حاسة البصر

١٨. تظهر الابتسامة البكرة عند بعض الرضع المكفوفين في وقت متأخر بصفة أقل تعبيرا وغالبا ما تكون صامتة، مقارنة بالرضع المبصرين؛ يتم ظهورها (الابتسامة) عن طريق استثارة الجسد.

١٩. هؤلاء الرضع المكفوفون لا يستطيعون تكوين اتصال بصري فالعلاقة بين الأم والطفل المكفوف تصبح صعبة بدون هذا الأسلوب في الاتصال رغم أن الطفل الصغير يرد الفعل ويستجيب لما يسمع ويلمس عن طريق الابتسامات الا انه يمكن أن توجد أخطار لنقص الاستثارة أو الاستثارة الزائدة وكذا مشكلات الضبط العاطفي لديه دون ان تلاحظ الام ذلك.

٢٠. بالنسبة لضبط الانفعالات، الأطفال ضعاف البصر لديهم صعوبات لتنظيم وتعديل استجاباتهم الوجهية، والصوتية التي تترجم انفعالاتهم مثل الأطفال المبصرين من نفس العمر، لآنهم لا يعرفون كيف يحاكون التعابير الانفعالية.

٢١. يمكن أن يُظهروا سلوكيات غير متوافقة استجابة للمثيرات البيئية منذ الطفولة الصغرى إلى عمر ما قبل المدرسة.

٢٢. يظهر أن الأطفال الصغار المكفوفين يعانون من صعوبات للانخراط في التفاعلات الاجتماعية مع الأطفال الآخرين، واللعب معهم، وقليل ما يستجيبون لاهتمامات أقرانهم، ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود فرصة مشاهدة كيف ينخرط الأطفال الآخرون في لَعِبِ الجماعة ويستمرون في المشاركة في تفاعلات الجماعة وهم أقل استعدادا لتكوين صداقات.

٢٣. الراشدين يعانون غالبا من الوحدة، ويُتركون لوحدهم في الأعمال الجماعية أو في المجموعات، ولديهم صعوبة في إنشاء علاقات اجتماعية أكثر انتظاما، وكذا علاقات مع الجنس الآخر.

٢٤. لديهم خصوصيات في مفهوم الذات لان هؤلاء الأطفال المكفوفون ليس لهم إمكانية مشاهدة حتى وجوههم، وشكل جسدهم من اجل البناء التدريجي لتصورهم الجسدي.

٢٥. نظرا للتبعية الغير عادية للطفل المكفوف، مقارنة بالأشخاص المبصرين كوسطاء ومصادر لمساعدته على الاكتشاف والاندماج في بيئته و نظرا لقلة تحكّمه في بيئته، يمكن أن ينعزل عن الآخرين، وتزيد المقارنة الاجتماعية مع الآخرين ، ويمكن لذلك أن يؤثر في إدراك الذات من مختلف الأبعاد و لكن تطور نمو مفهوم الذات يتبع نفس المراحل كالأطفال المبصرين.

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٥-صعوبات التعلم

مفهوم صعوبات التعلم

إن الأطفال ذوي صعوبات التعلّم هم أولئك الأطفال الذين يعانون من اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات السيكولوجية الأساسية المتضمنة فيفهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة ، وهذا الاضطراب قد يتضح في ضعف القدرة على الاستماع ، أو التفكير أو التكلم ، أو الكتابة ، أو والتهجئة ، أو الحساب . وهذا الاضطراب يشمل حالات الإعاقة الإدراكية والتلف الدماغي ، والخلل الدماغي ، والخلل الدماغي البسيط ، وعسر الكلام ، والحبسة الكلامية النمائية . وهذا المصطلح لا يشمل الأطفال الذين يواجهون مشكلات تعلميه ترجع أساساً إلى الإعاقات البصرية أو السمعية أو الحركية أو الاضطراب الانفعالي أو الحرمان البيئي أو الاقتصادي أو الثقافي .

نسبة انتشار صعوبات التعلّم :

" تختلف التقديرات حول أعداد أو نسب الأطفال ذوي الصعوبات التعلمية اختلافاً كبيراً جداً ، وذلك بسبب عدم وضوح التعريف من جهة ، وبسبب عدم توفر اختبارات متفق عليها للتشخيص ، ففي حين يعتقد بعضهم أن نسبة حدوث صعوبات التعلّم لا تصل إلى ١ % ، يعتقد آخرون أن النسبة قد تصل إلى ٢٠ % ، إلا أن النسبة المعتمدة عموماً هي ٢ % . ٣ % . " (١ : ص ٨٠)

الأسباب المؤدية لصعوبات التعلّم :

التعرف إلى الأسباب المؤدية إلى صعوبات التعلّم قد تتمثل في:

العوامل العضوية والبيولوجية :

إصابات الدماغ: يشير الأطباء إلى أهمية الأسباب البيولوجية لظاهرة صعوبات التعلّم ، وتحدث إصابة الدماغ هذه والتي تعني التلف في عصب الخلايا الدماغية إلى عدد من العوامل البيولوجية أهمها التهاب السحايا ، والتسمم أو التهاب الخلايا الدماغية والحصبة الألمانية ونقص الأكسجين أو صعوبات الولادة ، أو الولادة المبكرة ، أو تعاطي العقاقير ، ولهذا يعتقد الأطباء أن هذه السباب قد تؤدي إلى إصابة الخلايا الدماغية .

العوامل الجينية :

تشير الدراسات الحديثة في موضوع أسباب صعوبات التعلّم إلى أثر العوامل الجينية الوراثية .

العوامل البيئية :

تعتبر العوامل البيئية من العوامل المساعدة في موضوع أسباب صعوبات التعلّم ، وتتمثل في نقص الخبرات التعليمية وسوء التغذية الاضطرابات الانفعالية او نقص الخبرة ، أو سوء الحالة الطبية أو قلة التدريب أو إجبار الطفل على الكتابة بيد معينة ، وبالطبع لابد من ذكر نقص الخبرات البيئية والحرمان من المثيرات البيئية المناسبة . "(٣ ، ص ٢٠٩- ٢١٠)

<u>أنواع صعوبات التعلّم :</u>

من الممكن تصنيف صعوبات التعلّم إلى :

١ . صعوبات تعلم نمائية :

وهي تتعلق بنمو القدرات العقلية والعمليات المسئولة عن التوافق الدراسي للطالب وتوافقه الشخصي والاجتماعي والمهني وتشمل صعوبات (الانتباه . الإدراك . التفكير . التذكر . حل المشكلة) ومن الملاحظ أن الانتباه هو أولى خطوات التعلم وبدونه لا يحدث الإدراك وما يتبعه من عمليات عقلية مؤداها في النهاية التعلم وما يترتب على الاضطراب في إحدى تلك العمليات من انخفاض مستوى التلميذ في المواد الدراسية المرتبطة بالقراءة والكتابة وغيرها.

٢ . صعوبات تعلم أكاديمية :

وهي تشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب وهي نتيجة ومحصلة لصعوبات التعلم النمائية أو أن عدم قدرة التلميذ على تعلم تلك المواد يؤثر على اكتسابه التعلم في المراحل التعليمية التالية .

الخصائص النفسية والسلوكية لذوي صعوبات التعلّم والتي يمكن استخدامها كمحكات للاستدلال على وجود صعوبات التعلّم :

"يتفق معظم الباحثين على أن هؤلاء الأطفال / الأفراد يتمتعون بقدرات عقلية عادية ، إلا أن ذلك لا يمنع حدوث مشكلات في التفكير والذاكرة والانتباه لديهم ، وبالنسبة للتحصيل الأكاديمي فهو يعتبر جانب الضعف الرئيس لديهم . مع أن الأخصائيين لا يجمعون على معيار محدد لتدني التحصيل بهدف تشخيص صعوبات التعلّم ، إلا أن الأدبيات تنوه عادة إلى ضرورة أن يكون التدني في التحصيل بمستوى سنتين دراسيتين كحد أدنى وبمعنى اخر أن تحصيل الطفل لا

يتناسب مع عمره أو مستوى قدرته في واحدة أو أكثر من المجالات التالية (الفشل الأكاديمي)، عندما تقدم الخبرات التربوية المناسبة لعمره ومستوى قدرته ، **وهذه المجالات هي :**

- التعبير الشفوي.
- الفهم المبني على الاستماع.
- التعبير الكتابي.
- مهارات القراءة الأساسية.
- الفهم القرائي.
- العمليات الحسابية.
- الاستدلال الرياضي.

مع ملاحظة انه لا نحكم أن لدى الطفل صعوبة في التعلّم ، إذا كان التباعد الكبير بين القدرة والتحصيل ناتجاً في الأساس عن :

أ- إعاقة بصرية ، سمعية ، حركية.

ب- تخلف عقلي.

ت- اضطراب انفعالي.

ث- حرمان بيئي ، ثقافي أو اقتصادي.

ومن الممكن أن نحدد عدداً من الخصائص النفسية والسلوكية التي يظهرها ذوي صعوبات التعلّم : (١ ، ص ٨٢)

١. النشاط الزائد.

٢. الضعف الادراكي – الحركي.

٣. التقلبات الشديدة في المزاج.

٤. ضعف عام في التآزر.

٥. اضطرابات الانتباه.

٦. التهور.

٧. اضطرابات الذاكرة والتفكير.

٨. مشكلات أكاديمية محددة في الكتابة ، القراءة ، الحساب ، والتهجئة.

٩. مشكلات في الكلام والسمع (مشكلات لغوية).

١٠.علامات عصبية غير مطمئنة .

١١.أن نسبة ذكاء الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلّم عادية أو أعلى من المتوسط ، وذلك هو سبب التباين بين التحصيل المتوقع والتحصيل الحقيقي.

١٢.تتدرج صعوبات التعلّم من حيث الشدة من البسيطة إلى الشديدة.
١٣.تظهر على مدى حياة الفرد ، فليست مقصورة على مرحلة الطفولة أو الشباب.
١٤.قد تؤثر على النواحي الهامة لحياة الفرد كالاجتماعية والنفسية والمهنية وأنشطة الحياة .
١٥.قد تكون مصاحبة لأي إعاقة أخرى ، وقد توجد لدى المتفوقين والموهوبين.
١٦.قد تظهر بين الأوساط المختلفة ثقافياً واقتصادياً واجتماعيا .(٢ ، ص ١٧– ١٨)

ومن الممكن زيادة الاطلاع على هذه السلوكيات والمظاهر ، والتعرف عليها بشكل أكبر ، وذلك على النحو التالي :

المظاهر العامة لذوي صعوبات التعلم

يتميز ذوي صعوبات التعلم عادة، بمجموعة من السلوكيات التي تتكرر في العديد من المواقف التعليمية والاجتماعية، والتي يمكن للمعلم أو الأهل ملاحظتها بدقة عند مراقبتهم في الواقف المتنوعة والمتكررة. ومن أهم هذه الصفات ما يلي:

١. **اضطرابات في الإصغاء تعتبر ظاهرة شرود الذهن**، والعجز عن الانتباه، والميل للتشتت نحو المثيرات الخارجية، من أكثر الصفات البارزة لهؤلاء الأفراد. إذ أنّهم لا يميّزون بين المثير الرئيس والثانوي. حيث يملّ الطفل من متابعة الانتباه لنفس المثير بعد وقت قصير جداً، وعادة لا يتجاوز أكثر من عدة دقائق. فهؤلاء الأولاد يبذلون القليل من الجهد في متابعة أي أمر، أو انهم يميلون بشكل تلقائي للتوجه نحو مثيرات خارجية ممتعة بسهولة، مثل النظر عبر نافذة الصف، أو مراقبة حركات الأولاد الآخرين. بشكل عام، نجدهم يلاقون صعوبات كبيرة في التركيز بشكل دقيق في المهمات والتخطيط المسبق لكيفية إنهائها، وبسبب ذلك يلاقون صعوبات في تعلم مهارات جديدة (٦،ص ٤٤)

٢. **الحركة الزائدة:** تميّز بشكل عام الأطفال الذين يعانون من صعوبات مركبة من ضعف الإصغاء والتركيز، وكثرة النشاط، والاندفاعية، ويطلق على تلك الظاهرة باضطرابات الإصغاء والتركيز والحركة الزائدة (ADHD). وتلك الظاهرة مركبة من مجموعة صعوبات، تتعلق بالقدرة على التركيز، وبالسيطرة على الدوافع وبدرجة النشاط وعرِّفت حسب الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين كدرجات تطورية غير ملائمة من عدم الإصغاء، والاندفاعية والحركة الزائدة. عادة، تكون هذه الظاهرة قائمة بحد ذاتها كإعاقة تطورية مرتبطة بأداء الجهاز العصبي، ولكنها كثيراً ما

تترافق مع الصعوبات التعلمية. وليس بالضرورة أن كل من لديه تلك الظاهرة يعاني من صعوبات تعلميه ظاهرة . (٦،ص ٤٤)

٣. **الاندفاعية والتهور:** قسم من هؤلاء الأطفال يتميزون بالتسرع في إجاباتهم، وردود فعلهم، وسلوكياتهم العامة. مثلاً، قد يميل الطفل إلى اللعب بالنار، أو القفز إلى الشارع دون التفكير في العواقب المترتبة على ذلك. وقد يتسرع في الإجابة على أسئلة المعلم الشفوية، أو الكتابية قبل الاستماع إلى السؤال أو قراءته. كما وأن البعض منهم يخطئون بالإجابة على أسئلة قد عرفوها من قبل، أو يرتجلون في إعطاء الحلول السريعة لمشاكلهم، بشكل قد يوقعهم بالخطأ، وكل هذا بسبب الاندفاعية والتهور (Levine and Reed, 1999; Lerner, 1993).

٤. **صعوبات لغوية مختلفة:** لدى البعض منهم صعوبات في النطق، أو في الصوت ومخارج الأصوات، أو في فهم اللغة المحكية. حيث تعتبر الدسلكسيا (صعوبات شديدة في القراءة)، وظاهرة الديسغرافيا (صعوبات شديدة في الكتابة)، من مؤشرات الإعاقات اللغوية. كما ويعد التأخر اللغوي عند الأطفال من ظواهر الصعوبات اللغوية، حيث يتأخر استخدام الطفل للكلمة الأولى لغاية عمر الثالثة بالتقريب، علماً بأن العمر الطبيعي لبداية الكلام هو في عمر السنة الأولى.

٥. **صعوبات في التعبير اللفظي (الشفوي):** يتحدث الطفل بجمل غير مفهومة، أو مبنية بطريقة خاطئة وغير سليمة من ناحية التركيب القواعدي. هؤلاء الأطفال يستصعبون كثيراً في التعبير اللغوي الشفوي. إذ نجدهم يتعثرون في اختيار الكلمات المناسبة، ويكررون الكثير من الكلمات، ويستخدمون جملاً متقطعة، وأحياناً دون معنى؛ عندما يطلب منهم التحدث عن تجربة معينة، أو استرجاع أحداث قصة قد سمعوها سابقا. وقد تطول قصتهم دون إعطاء الإجابة المطلوبة أو الوافية. إن العديد منهم يعانون من ظاهرة يطلق عليها بعجز التسمية (Dysnomia)، أي صعوبة في استخراج الكلمات أو إعطاء الأسماء أو الاصطلاحات الصحيحة للمعاني المطلوبة. فالأمر الذي يحصل لنا عدة مرات في اليوم الواحد، عندما نعجز عن تذكر بعض الأسماء أو الأحداث، نلاحظه يحدث عشرات، بل مئات المرات لذوي صعوبات التعلم.

٦. **صعوبات في الذاكرة:** يوجد لدى كل فرد ثلاثة أقسام رئيسة للذاكرة، وهي الذاكرة القصيرة، والذاكرة العاملة، والذاكرة البعيدة. حيث تتفاعل تلك الأجزاء مع بعضها البعض لتخزين واستخراج المعلومات والمثيرات الخارجية عند الحاجة إليها. الأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلميّة، عادة، يفقدون القدرة على توظيف تلك الأقسام أو بعضها بالشكل المطلوب، وبالتالي يفقدون الكثير من المعلومات؛ مما يدفع المعلم إلى تكرار التعليمات والعمل على تنويع طرق عرضها.

٧. **صعوبات في التفكير:** هؤلاء الأطفال يواجهون مشكلة في توظيف الاستراتيجيات الملائمة لحل المشاكل التعليمية المختلفة. فقد يقومون بتوظيف استراتيجيات بدائية وضعيفة لحل مسائل الحساب وفهم المقروء، وكذلك عند الحديث والتعبير الكتابي. ويعود جزء كبير من تلك الصعوبات إلى افتقار عمليات التنظيم. لكي يتمكن الإنسان من اكتساب العديد من الخبرات والتجارب، فهو بحاجة إلى القيام بعملية تنظيم تلك الخبرات بطريقة ناجحة، تضمن له الحصول عليها واستخدامها عند الحاجة. ولكن الأولاد الذين يعانون من الصعوبات التعلمية وفي العديد من المواقف يستصعبون بشكل ملحوظ في تلك المهمة. إذ يستغرقهم الكثير من الوقت للبدء بحل الواجبات وإخراج الكراسات من الحقيبة، والقيام بحل مسائل حسابية متواصلة، أو ترتيب جملهم أثناء الحديث أو الكتابة .

٨. **صعوبات في فهم التعليمات:** التعليمات التي تعطى لفظياً ولمرة واحدة من قبل المعلم تشكل عقبة أمام هؤلاء الطلاب، بسبب مشاكل التركيز والذاكرة. لذلك نجدهم يسألون المعلم تكراراً عن المهمات أو الأسئلة التي يوجهها للطلاب. كما وأنّ البعض منهم لا يفهمون التعليمات المطلوبة منهم كتابياً، لذا يلجئون إلى سؤال المعلم أو تنفيذ التعليمات حسب فهمهم الجزئي، أو حتى التوقف عن التنفيذ حتى يتوجه إليهم المعلم ويرشدهم فردياً .

٩. **صعوبات في الإدراك العام واضطراب المفاهيم:** يعني صعوبات في إدراك المفاهيم الأساسية مثل: الشكل والاتجاهات والزمان والمكان، والمفاهيم المتجانسة والمتقاربة والأشكال الهندسية الأساسية وأيام الأسبوع..الخ

١٠. **صعوبات في التآزر الحسي – الحركي** (Visual– Motor Coordination): عندما يبدأ الطفل برسم الأحرف أو الأشكال التي يراها بالشكل المناسب أمامه، ولكنه يفسرها بشكل عكسي، فإن ذلك يؤدي إلى كتابة غير صحيحة مثل كلمات معكوسة، أو كتابة من اليسار لليمين أو نقل أشكال بطريقة عكسية. هذا التمرين أشبه بالنظر إلى المرآة ومحاولة تقليد شكل أو القيام بنقل صورة تراها العين بالشكل المقلوب. فالعين توجه اليد نحو الشيء الذي تراه بينما يأمرها العقل بغير ذلك ويوجه اليد للاتجاه المغاير. هذه الظاهرة تميز الأطفال الذين يستصعبون في عمليات الخط والكتابة، وتنفيذ المهارات المركبة التي تتطلب تلاؤم عين–يد، مثل القص والتلوين والرسم، والمهارات الحركية والرياضية، وضعف القدرة على توظيف الأصابع أثناء متابعة العين بالشكل المطلوب.

١١. **صعوبات في العضلات الدقيقة:** مسكة القلم تكون غير دقيقة وقد تكون ضعيفة، أو أنهم لا يستطيعون تنفيذ تمارين بسيطة تتطلب معالجة الأصابع.

١٢. **ضعف في التوازن الحركي العام:** صعوبات كتلك تؤثر على مشية الطفل وحركاته في الفراغ، وتضر بقدراته في الوقوف أو المشي على خشبة التوازن، والركض بالاتجاهات الصحيحة في الملعب.

١٣. **اضطرابات عصبية- مركبة:** مشاكل متعلقة بأداء الجهاز العصبي المركزي. وقد تظهر بعض هذه الاضطرابات في أداء الحركات العضلية الدقيقة، مثل الرسم والكتابة.

١٤. **صعوبات تعلميه خاصة في القراءة، الكتابة، والحساب:** تظهر تلك الصعوبات بشكل خاص في المدرسة الابتدائية، وقد ينجح الأطفال الأكثر قدرة على الذكاء والاتصال والمحادثة، في تخطي المرحلة الدنيا بنجاح نسبي، دون لفت نظر المعلمين حديثي الخبرة أو غير المتعمقين في تلك الظاهرة؛ ولكنهم سرعان ما يبدؤون بالتراجع عندما تكبر المهمات وتبدأ المسائل الكلامية في الحساب تأخذ حيزاً من المنهاج. وهنا يمكن للمعلمين غير المتمرسين ملاحظة ذلك بسهولة.

١٥. **البطء الشديد في إتمام المهمات:** تظهر تلك المشكلة في معظم المهمات التعليمية التي تتطلب تركيزاً متواصلاً وجهداً عضلياً وذهنياً في نفس الوقت، مثل الكتابة، وتنفيذ الواجبات البيتية.

١٦. **عدم ثبات السلوك:** أحياناً يكون الطالب مستمتعاً ومتواصلاً في أداء المهمة، أو في التجاوب والتفاعل مع الآخرين؛ وأحياناً لا يستجيب للمتطلبات بنفس الطريقة التي ظهر بها سلوكه سابقاً .

١٧. **عدم المجازفة وتجنب أداء المهام خوفا من الفشل:** هذا النوع من الأطفال لا يجازف ولا يخاطر في الإجابة على أسئلة المعلم المفاجئة والجديدة. فهو يبغض المفاجآت ولا يريد أن يكون في مركز الانتباه دون معرفة النتيجة لذلك. فمن خلال تجاربه تعلم أنّ المعلم لا يكافئه على أجوبته الصحيحة، وقد يحرجه ويوجه له اللوم أو السخرية إذا أخطأ. لذلك نجده مستمعاً أغلب الوقت أو محجباً عن المشاركة؛ لأنه لا يضمن ردة فعل المعلم أو النتيجة.

١٨. **صعوبات في تكوين علاقات اجتماعية سليمة:** إنّ أي نقص في المهارات الاجتماعية للفرد قد تؤثر على جميع جوانب الحياة، بسبب عدم قدرة الفرد لأن يكون حساساً للآخرين، وأن يدرك كبقية زملائه، قراءة صورة الوضع المحيط به. لذلك نجد هؤلاء الأطفال يخفقون في بناء علاقات اجتماعية سليمة، قد تنبع من صعوباتهم في التعبير وانتقاء السلوك المناسب في الوقت الملائم..الخ , وقد أشارت الدراسات إلى أنّ ما نسبته ٣٤٪ إلى ٥٩٪ من الطلاب الذين يعانون

من الصعوبات التعلمية، معرضون للمشاكل الاجتماعية. كما وأن هؤلاء الأفراد الذين لا يتمكنون من تكوين علاقات اجتماعية سليمة، صنِّفوا كمنعزلين، ومكتئبين.

١٩. الانسحاب المفرط: مشاكلهم الجمة في عملية التأقلم لمتطلبات المدرسة، تحبطهم بشكل كبير وقد تؤدي إلى عدم رغبتهم في الظهور والاندماج مع الآخرين، فيعزفون عن المشاركة في الإجابات عن الأسئلة، أو المشاركة في النشاطات الصفية الداخلية، وأحياناً الخارجية .

جدير بالذكر هنا، أنّ هذه الصفات لا تجتمع، بالضرورة، عند نفس الطفل، بل تشكل أهم المميزات للاضطرابات غير المتجانسة كما تم التطرق إليها بالتعريف. كما وقد تحظى الصفات التي تميز ذوي صعوبات التعلم، بتسميات عدة في أعمار مختلة. مثلاً، قد يعاني الطفل من صعوبات في النطق في الطفولة المبكرة، ويطلق عليها بالتأخر اللغوي؛ بينما يطلق على المشكلة بصعوبات قرائية في المرحلة الابتدائية، وفي المرحلة الثانوية يطلق عليها بالصعوبات الكتابية .

مظاهر الصعوبات الأكاديمية لذوي صعوبات التعلم :

" وبالطبع الغاية من بحثنا هذا تربوية ، وخدمة هؤلاء الطلاب ومساعدتهم في هذا المجال ، فلذلك لابد من أن يكون اهتمامنا منصب على شكل هذه الصعوبات من الناحية الأكاديمية ، والتوسع في شرح وتفصيل هذه الصعوبات ، والتي تتمثل بالمظاهر الخمس التالية ، وهي :

١ – صعوبات في التحصيل الدراسي :

التخلف الدراسي هو السمة الرئيسة للطلبة ، الذين يعانون من صعوبات في التعلم ، فلا وجود لصعوبات التعلم بغير وجود لمشكلة دراسية . بعض الطلبة قد يعانون من قصور في جميع مواضيع الدراسة ، والبعض الآخر قد يعاني من قصور في موضوع واحد أو في موضوعين

هذا ويمكن الإشارة إلى أبرز جوانب القصور في المواضيع الدراسية كما يلي :

أ) الصعوبات الخاصة بالقراءة :

تعد صعوبات القراءة من أكثر الموضوعات انتشاراً بين الطلبة ذوي صعوبات التعلم، حيث تتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :

– حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة المقروءة ، فمثلاً عبارة (سافرت بالطائرة) قد يقرأها الطالب (سافر بالطائرة) .

– إضافة بعض الكلمات غير الموجودة في النص الأصلي إلى الجملة ، أو بعض المقاطع أو الأحرف إلى الكلمة المقروءة فمثلاً كلمة (سافرت بالطائرة) قد يقرأها (سافرت بالطائرة إلى أمريكا) .

– إبدال بعض الكلمات بأخرى قد تحمل بعضاً من معناها ، فمثلاً قد يقرأ كلمة (العالية) بدلاً من (المرتفعة) أو (الطلاب) بدلاً من (التلاميذ) وهكذا .

– إعادة بعض الكلمات أكثر من مرة بدون أي مبرر فمثلاً قد يقرأ (غسلت الأم الثياب) فيقول(غسلت الأم ... غسلت الأم الثياب) .

– قلب الأحرف وتبديلها ، وهي من أهم الأخطاء الشائعة في صعوبات القراءة ، حيث يقرأ الطالب الكلمات أو المقاطع معكوسة ، وكأنه يراها في المرآة : فقد يقرأ كلمة (برد) فيقول (درب) وهكذا .

– ضعف في التمييز بين الأحرف المتشابهة رسماً ، والمختلفة لفظاً مثل:(ع و غ) أو (ج و ح و خ) وهكذا .

– ضعف في التمييز بين الأحرف المتشابهة لفظاً والمختلفة رسماً مثل : (ك و ق) أو (ت و د و ظ ض) أو (س و ز) وهكذا ، وهذا الضعف في تميز الأحرف ينعكس بطبيعة الحال على قراءته للكلمات أو الجمل التي تتضمن مثل هذه الأحرف ، فهو قد يقرأ (توت) فيقول (دود) مثلاً وهكذا.

– ضعف في التمييز بين أحرف العلة فقد يقرأ كلمة (فول) فيقول (فيل) .

– صعوبة في تتبع مكان الوصول في القراءة وازدياد حيرته ، وارتباكه عند الانتقال من نهاية السطر إلى بداية السطر الذي يليه أثناء القراءة .

– قراءة الجملة بطريقة سريعة وغير واضحة .

– قراءة الجملة بطريقة بطيئة كلمة كلمة .

ب) الصعوبات الخاصة بالكتابة :

وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :

* يعكس الحروف والأعداد بحيث تكون كما تبدو له في المرآة فالحرف (خ) مثلاً قد يكتبه معكوس والرقم (٣) يكتبه بشكل معكوس وأحياناً قد يقوم بكتابة المقاطع والكلمات والجمل بأكملها بصورة معكوسة من اليسار إلى اليمين فتكون كما تكون في مرآة .

* يخلط في الاتجاهات ، فهو قد بدأ كتابة الكلمات والمقاطع من اليسار بدلاً من كتابتها كالمعتاد من اليمين ، والفرق هنا عما سبق أن الكلمات هنا تبدو صحيحة بعد كتابتها ، ولا تبدو معكوسة كالسابق .

* ترتيب أحرف الكلمات والمقاطع بصورة غير صحيحة ، عند الكتابة ، فكلمة (ربيع) قد يكتبها (ريبع) وأحياناً قد يعكس ترتيب الأحرف فكلمة(دار) قد يكتبها (راد) وهكذا .

* يخلط في الكتابة بين الأحرف المتشابهة فقد يرى كلمة (باب) ولكنه يكتبها (ناب) وهكذا .

* يحذف بعض الحروف من الكلمة أو كلمة من الجملة أثناء الكتابة الإملائية .

* يضيف حرف إلى الكلمة غير ضرورية أو إضافة كلمة إلى الجملة غير ضرورية أثناء الكتابة الإملائية.

* يبدل حرف في الكلمة بحرف آخر مثلاً (غ - ع) أو (ب - ن) ..

* قد يجد الطالب صعوبة الالتزام بالكتابة على نفس الخط من الورقة .

* وأخيراً فإن خط هذا الطالب عادةً ما يكون رديئاً بحيث تصعب قراءته .

ج) الصعوبة الخاصة بالحساب :

وتتمثل هذه الصعوبات فيما يلي :

· صعوبة في الربط بين الرقم ورمزه ، فقد تطلب منه أن يكتب الرقم ثلاثة فيكتب (٤) .

· صعوبة في تمييز الأرقام ذات الاتجاهات المتعاكسة مثل (٦ . ٢) ، (٧ . ٨) ، حيث قد يقرأ أو يكتب الرقم (٦) عل أنه (٢) وبالعكس وهكذا بالنسبة للرقمين ٧ و ٨ وما شابه .

· صعوبة في كتابة الأرقام التي تحتاج إلى اتجاه معين ، مثل الرقم (٣) و الرقم (٤) و (٩) ويعكس الأرقام الموجودة في الخانات المختلفة ، فالرقم (٢٥) قد يقرأه أو يكتبه (٥٢) وهكذا.

· صعوبة في إتقان بعض المفاهيم الخاصة بالعمليات الحسابية الأساسية كالجمع، والطرح ، والضرب ، والقسمة . فالطالب هنا قد يكون متمكناً من عملية الجمع أو الضرب البسيط مثلاً ،

ولكنه مع ذلك يقع في أخطاء تتعلق ببعض المفاهيم الأخرى المتعلقة بالقيمة المكانية للرقم (آحاد . عشرات) مثلاً وما شابه ذلك ، وعلى سبيل المثال ، فقد قام أحد الطلبة بجمع ٢٥+١٢+=٠١ وعند الاستفسار منه تبين أنه قام بجمع الأرقام ٥+٢+٢+١ فكان الجواب ١٠ ولكنه قام بكتابة هذا الرقم بالعكس فكتب ٠١ .

فالطالب هنا يقوم بالجمع بطريقة صحيحة ، لكنه يخلط بين منزلتي الآحاد و العشرات مثلاً.

وأحياناً قد يقرأ أو يكتب الأرقام بطريقة معكوسة فتكون النتيجة خطأ على الرغم من أن عملية الجمع قام بها هو كانت صحيحة مثل :

٣٧

+

٩١

٢١٨

مما سبق نستطيع أن ندرك أن الارتباك في تمييز الاتجاهات هو إحدى الصعوبات الهامة ، التي يواجهها الطالب ، الذي يعاني من صعوبات تعلم ، وقد يكون هذا الاضطراب وراء معظم الأخطاء الشائعة والغريبة التي سبق الإشارة إليها .

٢ – صعوبة في الإدراك الحسي والحركة :

وتنقسم هذه الصعوبات إلى ثلاثة مجالات رئيسية ، هي :

أ–صعوبات في الإدراك البصري :

بعض الطلبة الذين يعانون من مشكلات في الإدراك البصري يصعب عليهم ترجمة ما يرون ، وقد لا يميزون العلاقة بين الأشياء ، وعلاقتها بأنفسهم بطريقة ثابتة ، وقابلة للتنبؤ ، فالطالب هنا لا يستطيع تقدير المسافة والزمن اللازم لقطع الشار بطريقة آمنة ، قبل أن تصدمه سيارة ، ويرى الأشياء بصورة مزدوجة و مشوشة ، وقد يعاني من مشكلات في الحكم في حجم الأشياء.

ويعاني هؤلاء الطلبة أيضاً من ضعف الذاكرة البصرية ، فهم قد لا يستطيعون أن يتذكروا الكلمات التي سبق أن شاهدوها ، وعندما ينسخون شيئا فهم يكررون النظر إلى النموذج الذي

يقومون بنسخها ، إضافة إلى ذلك يعاني كثير من الطلبة من مشكلات في تمييز الشكل عن الأرضية ، او في أن يرتبوا الصور التي تحكي قصة معينة ترتيباً متسلسلاً ، أو في عقد مقارنة بصرية ، أوفي إيجاد الشيء المختلف الذي لا ينتمي إلى المجموعة ، كما أنهم يستجيبون للتعليمات اللفظية ، بصورة أفضل من التعليمات البصرية .

ب–صعوبات في الإدراك السمعي :

في هذا المجال يعاني الطلبة من مشكلات في فهم ما يسمعونه وفي استيعابه وبالتالي فإن استجابتهم قد تتأخر ، وقد تحدث بطريقة لا تتناسب مع موضوع الحديث ، أو السؤال ، وقد يخلط الطالب بين بعض الكلمات التي لها نفس الأصوات مثل : جبل . جمل . أو: لحم لحن ، إضافة إلى ذلك ، فإنه قد لا يربط بين الأصوات البيئية ومصادرها ، وقد يعاني من صعوبات في تعرف الأضداد (عكس الكلمة)، وقد يعاني من مشكلات في تعرف المشكلات المتشابهة ، وقد يشتكي كثير من تداخل الأصوات ، حيث يقوم بتغطية أذنيه باستمرار ، ومن السهل تشتيت انتباهه بالأصوات .

فضلا عن ذلك ، فهو قد لا يستطيع أن يعرف الكلمة إذا سمع جزءاً منها ، ويجد صعوبات في فهم ما يقال له همساً أو بسرعة ، ويعاني من مشكلات في التذكر السمعي ، وإعادة سلسلة من الكلمات أو الأصوات في تتابعها ، كما قد يجد صعوبات في تعلم أيام الأسبوع و الفصول والشهور والعناوين و أرقام الهواتف تهجئة الأسماء .

ج–صعوبات في الإدراك الحركي والتآزر العام :

فهو يرتطم بالأشياء ، وقد يبدو مختل التو زان ، ويعاني من صعوبات في المشي ، أو ركوب الدراجة ، أو لعب الكرة .وقد يجد صعوبة في استخدام أقلام التلوين ، أو المقص ، من ناحية ، أخرى قد يخلط هذا الطالب بين اتجاه اليمين واتجاه اليسار ويعاني من عدم الثبات في استخدام يد معينة ، أو قدم معينة ،وقد يعاني من ارتعاش بسيط في اليدين ، أو الأصابع أو الأقدام ، فضلا عن ذلك ، فقد يضطرب الإدراك عند بعض الطلبة ، بخصوص الاتجاهات الستة : فوق . تحت . يمين . يسار أمام . خلف .

٣ . اضطرابات اللغة الكلام :

يعاني كثير من ذوي صعوبات التعلم من واحدة أو اكثر من مشكلات الكلام واللغة ، فقد يقع هؤلاء الطلبة في أخطاء تركيبية ونحوية ، حيث قد تقتصر إجاباتهم على الأسئلة بكلمة واحدة لعدم قدرتهم على الإجابة بجملة كاملة .وقد يقومون بحذف بعض الكلمات من الجملة ، أو

إضافة كلمات غير مطلوبة ، وقد لا يكون تسلسل الجملة دقيقاً ، وقد يجدون صعوبة في بناء جملة مفيدة ، على قواعد لغوية سليمة .

من ناحية أخرى ، فإنهم قد يكثرون من الإطالة و الالتفاف حول الفكرة ، عند الحديث ، أو رواية القصة ، وقد يعانون من التعلثم ، أو البطء الشديد في الكلام الشفهي ، أو القصور في وصف الأشياء ، أو الصورة ، أو الخبرات ، وبالتالي عدم القدرة على الاشتراك في محادثات ، حول موضوعات مألوفة ، واستخدام الإشارات بصورة متكررة للإشارات على الإجابة الصحيحة فضلاً عن ذلك ، فقد يعاني هؤلاء الطلبة من عدم الكلام ، (حذف أو إضافة بعض الأصوات) وتكرار الأصوات بصورة مشوهة أو محرفة .

٤ – صعوبات في عمليات التفكير :

لاحظ الباحثون أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلم ، تظهر لديهم دلالات ، تشير إلى وجود صعوبات ، في عمليات التفكير لديهم ، فهؤلاء الطلبة قد يحتاجون إلى وقت طويل ، لتنظيم أفكارهم قبل أن يقوموا بالاستجابة ، وقد يكون لديهم القدرة على التفكير الحسي ، في حين قد يعانون من ضعف في التفكير المجرد ، وقد يعاني هؤلاء الطلبة من الاعتماد الزائد على المدرس ، وعدم القدر على التركيز ، والصلابة ،وعدم المرونة ، وعدم إعطاء الاهتمام الكافي للتفاصيل ، أو لمعاني الكلمات ، والقصور في تنظيم أوقات العمل ، وعدم اتباع التعليمات ، وعدم تذكرها . كما أنهم قد يعانون من صعوبات في تطبيق ما يتعلمونه .

٥ – خصائص سلوكية :

كثير من الطلبة المصابين بصعوبات في التعلم يعانون من نشاط حركي زائد ، فالطالب ـ هنا يبقى متململاً مشحوناً بالحركة ، ويحوم كثيراً . وبالتالي فإن من الصعب السيطرة عليه . هذا الطالب لا يستطيع مقاومة الإثارات الغريبة عن الموقف ، فإذا سمع صوتاً خارج الصف كأن يكون صوت سيارة ، او صوت طائرة ، يهرع إلى النافذة .

والمشكلة هنا أن هذا الطالب يجد صعوبة في التركيز على ما هو مهم من المثيرات ، كما أنه يجد صعوبة في المحافظة على تركيز انتباهه لفترة كافية من الوقت ، وهذا يحد من قدرته على التعلم ، و على العكس من هذا الطالب ، نجد طلاباً آخرين يعانون من الخمول، وقلة النشاط . وهؤلاء الطلبة يبدون طيبين ، ومسايرين . ونادراً ما ينفلت منهم زمام غضبهم ، وهؤلاء تجدهم بليدين ، فاتري الشعور ، ولا يتسمون بالفضول ، أو اللهفة ، أو الاستقلالية : كما أنهم يتسمون بنشاط منخفض . بشكل عام فالدافعية عندهم منخفضة ، ومدة انتباهم قصيرة ، لأن من العسير

شد انتباههم . وهذا النوع من صعوبات التعلم : (الخمول في النشاط)هو شكل أقل شيوعاً من حالت النشاط الحركي الزائد . " (القحطاني ، ١٤٢١ : ص ٢ . ٨)

أساليب تشخيص ذوي صعوبات التعلّم ؛

كيف تعرف ان الطفل او التلميذ لديه صعوبة في التعلم ؟؟؟....

ولذلك فإنه يمكن الحذر من صعوبات التعلم، بطريقة غير مباشرة، عن طريق ملاحظة أي تأخر ملحوظ في نمو مهارات الطفل. فمثلاً يعتبر وجود تأخر يعادل مرحلتين دراسيتين اثنين (كأن يكون الطفل في الصف الرابع الابتدائي، لكنه يقرأ مثلاً في مستوى طلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسته) يُعد تأخراً كبيراً.

وبينما يمكن اعتبار وسيلة الملاحظة إحدى العلامات المنبهة الا ان، التشخيص الفعلي لصعوبات التعلم يكون باستخدام الاختبارات القياسية العامة ليتم مقارنه مستوى الطفل بالمستوى المعتاد لأقرانه في العمر والذكاء حيث لا تعتمد نتائج الاختبار على مجرد قدرات الطفل الفعلية، بل كذلك على مدى دقة هذه الاختبارات، وقدرة الطفل على الانتباه، وفهم الأسئلة.

<u>أساليب تشخيص ذوي صعوبات التعلّم كبداية للبرامج العلاجية:</u>

وتشمل على أدوات بعضها يعتمد على القياس الكمي والبعض الآخر يعتمد على الوصف الكيفي ، وذلك على النحو التالي :

١ . أدوات القياس الكمي :

اختبارات القدرات واختبارات التحصيل المقننة وغير المقننة ، واختبارات الشخصية وقوائم التقدير والبطاقات المدرسية واختبارات الاتجاهات والميول واختبارات القدرات الحسية .

٢ . أدوات الوصف الكيفي :

مثل الملاحظة والمقابلة ودراسة الحالة وتحليل محتوى إنتاج الطالب وتصنيفه بصورة تمكّن من تحديد نوعية المشكلات الدراسية التي يعاني منها .

ويفضل عند تشخيص هذه حالات صعوبات التعلم استخدام تشخيص متعدد المعايير ، والذي يأخذ في الحسبان :

- القدرات العقلية كما يقيسها اختبار الذكاء.

- مستوى التحصيل الأكاديمي ، ويقاس بوساطة اختبارات التحصيل المقننة ، وفي حال عدم توافرها نلجأ إلى الاختبارات المدرسية.
- رصد السمات السلوكية أو تحديد السمات السلوكية بوساطة قوائم الرصد أو مقاييس السمات .

التفريق بين صعوبات التعلم وبعض المصطلحات :

للتفريق بين صعوبة التعلّم والتأخر الدراسي ، وصعوبة التعلّم وبطيء التعلّم، مع ملاحظة أن صعوبة التعلّم قد يعاني منها كذلك الطلبة الموهوبين ويطلق عليهم موهوبين من ذوي صعوبات التعلّم، بالإضافة للطلبة العاديين من ذوي صعوبات العلّم ، وإن اختلفت الأسباب في كلٍ من الحالتين ، فالعمر المناسب للتدخل لملاحظة واكتشاف الطلبة من ذوي صعوبات التعلّم الإنسان ، في بداية مراحل ظهور الأعراض على الطفل / الطالب ، ويجب أن يكون في بداية دخوله المدرسة ، وغالباً ما يكون ذلك عند سن التاسعة ، أي ما يوافق الصف الثالث من المرحلة الابتدائية ، حيث يوصي الباحثين باستخدامها عند هذا السن لسببين ، وهما :

١. أن أدوات القياس والتشخيص تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات عند هذا العمر ؛

٢. أن هذا العمر يمثل مرحلة العملات العقلية ، كما أشار إليها جان بياجيه Jean Piaget)) وهي التي يكون فيها الطفل قادر على القراءة والكتابة والحساب .

نماذج من الاختبارات التشخيصية:

قائمة السمات / العلامات المبكرة الدالة على صعوبات التعلّم.

١. السلوك الاندفاعي المتهور
٢. النشاط الزائد
٣. الخمول المفرط
٤. الافتقار إلى مهارات التنظيم أو إدارة الوقت
٥. عدم الالتزام والمثابرة
٦. التشتت وضعف الانتباه
٧. تدني مستوى التحصيل
٨. ضعف القدرة على حل المشكلات
٩. ضعف مهارات القراءة
١٠. قلب الحروف والأرقام والخلط بينهما

١١. تدني مستوى التحصيل في الحساب
١٢. ضعف القدرة على استيعاب التعليمات
١٣. تدني مستوى الأداء في المهارات الدقيقة (مثل الكتابة بالقلم و تناول الطعام و التمزيق، والقص، والتلوين، والرسم ....)
١٤. التأخر في الكلام أي التأخر اللغوي
١٥. وجود مشاكل عند الطفل في اكتساب الأصوات الكلامية أو إنقاص أو زيادة أحرف أثناء الكلام
١٦. ضعف التركيز
١٧. صعوبة الحفظ
١٨. صعوبة التعبير باستخدام صيغ لغوية مناسبة
١٩. صعوبة في مهارات الرواية
٢٠. استخدام الطفل لمستوى لغوي أقل من عمره الزمني مقارنة بأقرانه
٢١. صعوبة إتمام نشاط معين وإكماله حتى النهاية
٢٢. صعوبة المثابرة والتحمل لوقت مستمر (غير متقطع)
٢٣. سهولة التشتت أو الشرود، أي ما نسميه السرحان
٢٤. ضعف القدرة على التذكر / صعوبة تذكر ما يُطلب منه (ذاكرته قصيرة المدى)
٢٥. تضييع الأشياء ونسيانها.
٢٦. قلة التنظيم.
٢٧. الانتقال من نشاط لآخر دون إكمال الأول.
٢٨. عند تعلم الكتابة يميل الطفل للمسح (الإمحاء) باستمرار.

و قد تتحقق جميع تلك السمات ، أو بعضها .

ولزيادة التأكد من الحالة نقوم بقياس مستوى الذكاء لهذا الطفل ، وكما سبق ووضحنا فيجب أن لا يكون مستوى الذكاء منخفض ، بل يجب أن يكون مستوى الذكاء طبيعي وما فوق ٨٨ درجة .

ثم هناك المؤشر الأخير ، وهو اختبارات التحصيل الدراسي المقننة أو المدرسية ، والنتائج الضعيفة التي يحرزها الطالب فيها .

فتدلل هذه المؤشرات جميعها على وجود هذه المشكلة ، ووجوب التدخل السريع والمبكر لحلها ، وذلك لزيادة فاعلية هذا العلاج والتقويم ، فكلما كان التدخل ، كلما كان العلاج أسرع وأفضل .

البرامج العلاجية:

الكشف المبكر ، تعتبر الخطوة الأولى في العلاج ، وقد تندرج كوسيلة من وسائل العلاج في بداياته ، والكشف هذه في مراحل عمرية مبكرة ، فإعاقة صعوبات التعلّم لا تكتشف كبعض الإعاقات منذ الولادة ، أو عند بداية نمو الحواس ، أو الاستعداد للحركة ، ولكنها قد تكون من الإعاقات الصعبة ، الخفية ، التي لا تظهر في البدايات المبكرة من عمر الإنسان ، وإن كانت نتائجها تستمر مع الإنسان طوال حياته سواءاً كان طالباً أو موظفاً يشغل مسؤوليةً في الحياة تستمر معه هذه الإعاقة إذا لم يتم علاجها وتقويمها باكراً ، ولا تظهر هذه الصعوبات بشكل واضح وصريح وتحتاج لجهد ومعرفة تامة من قبل فريق التشخيص ،وتكمن أهمية برنامج الكشف المبكر في تنفيذ الخطوات التي يتكون منها هذا البرنامج ، من حيث الترتيب ، ثم التنفيذ بفاعلية واجتهاد، أما خطوات هذا البرنامج فتكون كما يلي :

١. تحديد ذوي الاحتياجات الخاصة .

٢. أهلية الطفل لبرامج التربية الخاصة .

٣. توفير الخدمات والبرامج التربوية الخاصة بهذا الطفل .

٤. وضع الخطط والبرامج الواجب اتباعها .

٥. تقويم تقدم / فاعلية البرنامج / المؤسسة من حيث مستوى تقدم الطفل ، مدى نجاح معلم ومعلمة التربية الخاصة ، فاعلية البرنامج ، مدى نجاح برنامج / مؤسسة التربية الخاصة ، أي بمعنى آخر وضع ما يعرف بالصفحة النفسية البروفايل Profile يفضل استخدام آلية

أنواع برامج علاج صعوبات التعلم

١. مراكز (العزل)التربية الخاصة للأطفال ذوي صعوبات التعلّم.

٢. الصفوف الخاصة للأطفال ذوي صعوبات التعلّم في المدرسة العادية.

٣. دمج الأطفال ذوي صعوبات التعلّم في الصفوف العادية في المدرسة العادية .

أولاً : المراكز (المدارس) الخاصة بصعوبات التعلّم :

وهي مختصة بمن يعانون من مشاكل تعليمية أو انفعالية شديدة ويجدون صعوبة في التفاعل مع المدرسة العادية بالتالي من الممكن لهم أن يحضروا إلى هذه المراكز أو المدارس الخاصة بشكل جزئي أو كامل .

ثانياً : الصفوف الخاصة للأطفال ذوي صعوبات التعلّم في المدارس العادية :

يجب أن يكون هذا البرنامج عالي التنظيم يكاد يخلو من المشتتات يحتوي عدد قليل من الطلاب ما بين ٨ – ١٢ طالب حيث يقوم معلم مؤهل للتعليم الخاص ومساعد معلم بالتدريس ويقضي هؤلاء الطلاب معظم وقتهم في هذا الصف ، ويجب أن يكون هذا البديل لذوي الصعوبات الشديدة ، وقد أثبتت الدراسات أن نتائج ذوي صعوبات التعلّم في هذا الصف أفضل مما كانت عليه في الصفوف العادية

ثالثاً : دمج الأطفال ذوي صعوبات التعلّم في الصفوف العادية في المدرسة العادية :

حيث يتعلم هنا الأطفال ذوي صعوبات التعلّم مع العاديين في الصفوف العادية ، وهذا البديل هو من أحدث البدائل التي يتم التوجه له ، حيث أنه الأقل تقيداً من بين البدائل الأخرى . ومهما كان شكل البديل التربوي لذوي صعوبات التعلّم ، فإن إعداد البرامج التربوية هي الأساس الأول في تلك البدائل (٣ ، ص٢٢٣ – ٢٢٤)

أساليب تدريس ذوي صعوبات التعلّم

(القراءة / الكتابة / الحساب) :

"قد تحد الإعاقة من قدرة الطالب على التعلّم من خلال طرائق التدريس العادية ، مما يستوجب تزويده ببرامج تربوية خاصة تتضمن توظيف وسائل تعليمية وأدوات وأساليب مكيفة ومعدلة . " (الخطيب ، ١٩٩٤ : ص ١٢٤)

استراتيجيات التعليم العلاجي

١. التدريس المباشر :-

ويقوم على الخطوات التالية :

- وضع أهداف محددة واضحة ليعمل الطلاب على تحقيقها .
- صياغة وترتيب الأنشطة التربوية في خطوات متسلسلة .

· إتاحة الفرص لاكتساب المهارات الجديدة .

· تقويم وتقديم التغذية المرتدة الفورية لتصحيح المسار التعليمي للتلميذ أولاً بأول.

٢. التعلم الإيجابي أو الفعال :-

ويستند إلى الإجراءات التالية :

· تشجيع التعلم التفاعلي بين التلميذ والبيئة ومادة التعلم .

· الاستناد إلى الخبرات السابقة للتلميذ عند تقديم المادة التعليمية الجديدة .

· إعداد الطالب ذهنياً وفكرياً ودافعياً في عملية التعلم .

· تشجيع التلميذ على الاندماج في عملية التعلم .

٣ . أسلوب النظم :-

وهو نشاط تعليمي يشكل نطاقا له مكوناته وعناصره وعلاقاته وعملياته التي تسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة وهو يتألف من أربعة أجزاء :

· المدخلات

· العمليات

· المخرجات

· التغذية المرتدة

أمثلة لبعض الاستراتيجيات الهامة للتكيّف وعلاج مع صعوبات التعلم

وفيما يلي سنركز على الجوانب الثلاث المهمة التي يظهر بها أطفال ذوي صعوبات التعلّم مشاكل ، وهي الجوانب التي يركز عليها التعريف التربوي لفئة صعوبات التعلّم ، وهي : القراءة ، الكتابة ، الحساب .

أولاً : أساليب تدريس القراءة

أمثلة لبعض الاستراتيجيات الهامة للتكيّف مع صعوبات القراءة من خلال بعض مهام معلّمي غرفة المصادر

١- طريقة تعدد الوسائط أو الحواس VAKT

تعتمد هذه الطريقة على التعليم المتعدد الحواس أو الوسائط أي الاعتماد على الحواس الأربع السمع ، اللمس ، البصر ، و الحاسة الحس حركية في تعليم القراءة . إن استخدام الوسائط أو الحواس المتعددة يحسّن ويعزز تعلم الطفل للمادة المراد تعلمها ، ويعالج القصور المترتب على الاعتماد على بعض الحواس دون الآخر .

٢- طريقة فرنالد Fernald Method

تقوم طريقة فرنالد على استخدام المدخل المتعدد الحواس في عملية القراءة ٠ وتختلف هذه الطريقة عن طريقة VAKT في نقطتين :

· تعتمد هذه الطريقة على أعمال الخبرة اللغوية للطفل في اختياره للكلمات والنصوص .

· اختيار الطفل للكلمات مما يجعله أكثر إيجابية و نشاطا و إقبالا على موقف القراءة .

٣. طريقة اورتون- جلنجهام Orton-Gillingham

تركز هذه الطريقة على تعدد الحواس و التنظيم أو التصنيف و التراكيب اللغوية المتعلقة بالقراءة والتشفير أو الترميز و تعليم التهجي ،وتقوم على :

· ربط الرمز البصري المكتوب للحرف مع اسم الحرف .

· ربط الرمز البصري للحرف مع نطق أو صوت الحرف .

· ربط أعضاء الكلام لدى الطفل مع مسميات الحروف و أصواتها عند سماعه لنفسه أو غيره .

برنامج القراءة العلاجية

يستخدم البرنامج مع تلاميذ الصف الأول الذين يحتلون أدنى مستوى بالنسبة لأقرانهم في نفس الفصل و يقدم لهم تعليم فردي مباشر . ومن أهم ما يميز البرنامج هو التعجيل بالتدخل المبكر خلال الصف الأول .

خطوات برنامج القراءة العلاجية :

١- قراءة المألوف Familiar Reading . يحتاج التلاميذ إلى مواد قرائية مألوفة لتنمية الطلاقة التعبيرية لديهم .

٢- تسجيلات فورية موقفيه Running Records . يتم ملاحظة التلاميذ خلال قراءاتهم ، وتسجيل هذه الملاحظات في ضوء واحد أو أكثر من الأهداف التدريسية التي تحدد أو تختار بناءا على هذه الملاحظات .

٣- الكتابة Writing . تقدم فرصا متعددة للكتبة و يطلب من التلاميذ سماع أصوات الكلمات و تعميم الكلمات الجديدة ، وتنمية العلاقة من خلال الكلمات المعروفة وممارسة الوعي الفونولوجي للأصوات .

٤- تقديم كتب جديدة للقراءة الأولى Introduce New Books For . First Reading . يختار الطلاب كتب جديدة بهدف استثارة تحديات جديدة لهم ، ويقرأ كل من المدرس و التلميذ بصوت مسموع من الكتاب الجديد.

برنامج علاج ضعف الفهم القرائي

يستهدف البرنامج تحسين الفهم القرائي لتلاميذ الصف الرابع وما فوق ، من خلال الخطوات التالية :

· استخدام القاموس للبحث عن معاني المفردات أو الكلمات التي يصعب عليهم فهمها و فهم مفرداتها .

· إكساب الأطفال العديد من المفاهيم و الخصائص المتعلقة بكل مفهوم و استخداماته و إعداد أو عمل صياغات لفظية أو لغوية لاستخدام هذه المفاهيم و معانيها .

· استثارة التلاميذ لطرح بعض الأفكار ثم يطلب منهم القراءة حولها ثم كتابة ملخصات لقراءاتهم حول هذه الأفكار .

ثانياً : أساليب تدريس الكتابة

"يجب الاهتمام بمهارات الاستعداد للكتابة ، حيث تتطلب سيطرة عقلية وتوافق بصري وعددي وتميز بصري ، بالتالي على المعلم مساعدة الطالب لتطوير هذه المهارات قبل البدء بتدريس الكتابة العقلية ، ويتم تطوير التوافق العصبي البصري عن طريق الرسم بالأصابع ، التلوين ، أما التوافق بين العين واليد فعن طريق رسم دوائر ثم نقلها وكذلك تطوير التميز البصري للأحجام والأشكال والتفاصيل ، وهذا ينمي الإدراك البصري للحروف وتكوينها عند الطالب ، ويمكن تدريب الحركات الكتابية بالكتابة على الصلصال أو الكتابة على الرمل .

١. طريقة فرنالد :

والتي أشرنا لها ، والتي تعتمد أسلوب متعدد الحواس لتعلم القراءة والكتابة والإملاء .

٢. أسلوب أمنير :

وهو أسلوبان لتعليم الإملاء والأول يستخدم اختبار قبلي في بداية الأسبوع ثم يدرس الطالب الكلمات التي أخفق بها للاختبار البعدي ، وهو يفضل مع الطلبة الكبار الذين لديهم مهارات إملائية جيدة ، والطريقة الثانية تناسب الأصغر سناً .

٣. علاج تشكيل الحروف :

هناك عدد من الإجراءات لتدريس تشكيل الحروف ، ومنها :

- النمذجة
- ملاحظة العوامل المشتركة الهامة
- المنبهات الجسمية
- التتبع
- النسخ
- التعبير اللفظي
- الكتابة من الذاكرة
- التكرار
- تصحيح الذات والتغذية الراجعة .

ثالثاً : أساليب تدريس الرياضيات

هناك مبادئ عامة لتعليم الرياضيات بطريقة علاجية ، وهذه مبادئ مرنة لا تقتصر على مستوى معين في الرياضيات بل يمكن تطبيقها في أي موضوع متسلسل فيه :

أولاً : الاهتمام بتوفير الاستعداد لتعليم الرياضيات :

حيث سيوفر القاعدة لتدريس الرياضيات والتعلّم قبل الرقمي مهم وأساسي للتعلّم اللاحق ويجب تعليمه للأطفال إن كانوا يفتقرون لمثل هذه المهارات ، ومن هذه المهارات :

- المطابقة
- ملاحظة إدراك مجموعة من الأشياء معاً

- العد الآلي
- تسمية الرقم الذي يأتي بعد أو قبل رقم ما .

ثانياً:استخدام التسلسل الرياضي أو مبدأ الانتقال من المحسوس (المادي) إلى شبه المحسوس إلى المجرد.

ثالثا: إتاحة الفرصة للطالب للتدريب والمراجعة .

رابعاً: مراقبة أداء الطالب وتوفير التغذية الراجعة .

خامسا: تعليم التصميم . (١، ص ١٢٨ – ١٣٨)

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٦-التوحد

إن مصطلح التوحد هو ترجمة للكلمة الإغريقية (autos) أي الذات الأنا التي تشير إلى الانطواء والتوحد مع الذات وقد استعمل العالم (بلولير ايغون) وهو عالم وطبيب سويسري ولد في زيورخ ١٨٥٧-١٩٣٩م - مفهوم السلوك التوحدي لأول مرة عام ١٩١١م كدالة على الانفصام الشخصي بالرغم من الاختلافات الشديدة بين الاضطرابيين .(٨، ص٥٥)

معنى التوحد

يظهر التوحد بوضوح في السنوات الثلاث الأولى من الحياة ، ويعرف التوحد بأنه عجز يعيق تطوير المهارات الاجتماعية والتواصل اللفظي وغير اللفظي واللعب التخيلي والابداعي وهو نتيجة اضطراب عصبي يؤثر على الطريقة التي يتم من خلالها جمع المعلومات ومعالجتها بواسطة الدماغ مسببة مشكلات في المهارات الاجتماعية تتمثل في عدم القدرة على الارتباط وخلق علاقات مع الأفراد ، وعدم القدرة على اللعب واستخدام وقت الفراغ , وعدم القدرة على التصور البناء والملائمة التخيلية ومشكلات في مهارات التواصل فهي تكمن في عدم القدرة على التعبير عن الذات تلقائيا وبطريقة وظيفية ملائمة ، و عدم القدرة على فهم مايقوله الآخرون ،عدم القدرة على استخدام مهارات أخرى بجانب المهارات اللفظية لمساعدة الفرد في القدرة على التواصل .

أمّا مشاكل التأقلم مع البيئة فهي تكمن في عدم القدرة على القيام بعمل وأداء وظيفي بفاعلية في البيئة ، وعدم القدرة على مسايرة وتحمل التغييرات في البيئة والتعامل معها بالإضافة الى عدم القدرة على تحمل تدخلات الأفراد الآخرين .

تعريف الجمعية الأمريكية للتوحد

التوحد نوع من الاضطرابات التطورية (النمائية) و الذي يظهر خلال الثلاث سنوات الأولي من عمر الطفل حيث ينتج هذا الاضطراب عن خلل في الجهاز العصبي يؤثر بدوره علي وظائف المخ و بالتالي يؤثر علي مختلف نواحي النمو.

فيؤدي إلى:

١. قصور في التفاعل الاجتماعي.
٢. قصور في الاتصال سواء كان لفظيا ام غير لفظيا.

٣. و هؤلاء الأطفال يستجيبون دائما إلى الأشياء أكثر من استجابتهم إلى الأشخاص ويضطرب هؤلاء الأطفال من اي تغيير يحدث في بيئتهم و دائما يكررون حركات بدنية او مقاطع من الكلمات بطريقة اليه متكررة.

الأعراض السلوكية الشائعة للتوحد

إن الطفل المصاب بالتوحد هو طفل تصعب إدارته وذلك بسبب سلوكياته ذات التحدي وبالرغم من هذا فإن السلوكيات الصعبة التي يبديها الطفل التوحدي هي عقبة ثانوية للتوحد والتوحد ليس فقط مجموعة من السلوكيات الغير هادفة والغريبة والفوضوية ولكنه مجموعة من نواقص خطيرة تجعل الطفل قلق ، غاضبا ، محبطا مربكا ، خائفا ومفرط الحساسية , وتحدث السلوكيات الصعبة لأنها هي الطريق الوحيدة التي يستجيب عبرها الطفل للأحاسيس الغير السارة وهي نفس النواقص التي تجعل تلك الأحاسيس تمنع الطفل أيضا من التعبير والتعامل معها بطريقة مناسبة . وتحدث السلوكيات بسبب إن الطفل يحاول إيصال رسالة ما إلى الآخرين فيستخدم هذه السلوكيات الشاذة ليصل إلى احتياجاته ورغباته أو بما يحسه وما يطلبه من تغيير فيما حوله أو كطريقة للمسايرة والتعامل مع الإحباط . وتتلخص بعض هذه السلوكيات في- :

- مقاومة التغير
- السلوك الاستحواذي والنمطي .
- السلوك العدواني وإيذاء الذات.
- سلوك العزلة والمقاطعة .
- نوبات الغضب .
- المناورة مع الأفراد والبيئة المحيطة .
- الضحك والقهقهة دون سبب .
- الاستثارة الذاتية.
- عدم إدراك المخاطر.

ما الفئات التي يمكن أن تصاب بالتوحد(الأوتيزم)؟

التوحد(الأوتيزم) أحد الاضطرابات النمائية واسعة الانتشار والتي يشار إليها الآن باستخدام توصيف جديد هو اضطرابات التوحد واسع النطاق أو واسع المجال يمكن أن يصيب الأفراد من مختلف الجنسيات والخلفيات العرقية والمستويات الاقتصادية الاجتماعية، وتزيد الإصابة به في الذكور عن الإناث ويحدث التوحد (الأوتيزم) لدى كل الأفراد على مختلف مستويات الذكاء فنجد

أن حوالي ٧٥٪ من الأطفال التوحديين يمتلكون ذكاءً منخفضاً أقل من المتوسط، بينما يوجد حوالي ١٠٪ منهم يظهرون ذكاء نوعياً مرتفعاً في مجال محدد كالرياضيات مثلاً.

كيف تنمو اللغة والكلام لدى الأطفال التوحديين(الأوتيزم)؟

تعد الثلاث سنوات الأولى من حياة الطفل هي أكثر سنوات الحياة تأثيراً في نمو اللغة والكلام وهي فترة تعرف بسرعة نمو الدماغ ونضجه، فيكتسب الطفل مهارات اللغة والكلام والتي تتمثل من خلال العالم الغني من حوله بالأصوات والمناظر، كما تنمو هذه المهارات أيضاً نتيجة الاستماع إلى اللغة والكلام من الآخرين. ويستهدف نمو وتطور مهارات اللغة والكلام في هذه المرحلة تحقيق التواصل أو التفاعل مع العالم الخارجي .

وتظهر أولى العلامات الدالة على التواصل بعد أيام قليلة من حياة الطفل عندما يتعلم الطفل أن بكاءه يجعل الآخرين يسرعون لإطعامه، أو لإراحته، أو لمرافقته. ويبدأ الأطفال الرضع في التعرف على الأصوات الهامة مثل أصوات أمهاتهم. ويبدؤون في ترتيب الأصوات أو(الفونيمات)" أو تجميعها لتكوين كلمات لغتهم وقد أظهرت الأبحاث أن بحلول الـ ٦ شهور الأولى من العمر يستطيع معظم الأطفال التعرف على الأصوات الأساسية في لغتهم .

كما تتضح مكانيزمات أو الأجزاء المسئولة عن الكلام مثل (الفكّ، الشفاه، اللسان، والحنجرة) كما ينضح الصوت، ويصبح الرضيع قادراً على السيطرة على الأصوات. وهذا السلوك يبدأ في الشهور القليلة الأولى من حياة الأطفال في الفترة المعروفة بفترة المناغاة أو الهديل كما يشعر الطفل بالسرور والسعادة في هذه الفترة عندما يكرر الأصوات. وبحلول الشهور الـ٦ الأولى من العمر يبدأ الأطفال في تكرار المقاطع الصوتية مثل (با، با) وسرعان ما تتحول إلى أصوات عديمة المعني يغلب عليها إيقاع الكلام الطبيعي ونغمته بيد أنها لا تحتوى على كلمات ذات معنى حقيقي. وعند نهاية سَنَتهم الأولى، يكون معظم الأطفال قادرين على نطق بعض الكلمات. بالرغم من أنهم لا يفهمون معنى هذه الكلمات لكنهم قد يفهمون معناه فيما بعد نتيجة استجابة المحيطين لهذه الكلمات .

وبوصول الطفل سن الـ ١٨ شهراً يكون معظمهم قادرين على نطق ما يقرب من ٨-١٠ كلمات وبوصولهم سن سنتين يكون لديهم القدرة على وضع الكلمات معاً لتكون جملاً مثل وخلال هذه الفترة سرعان ما يتعلم الأطفال ان الكلمات هي رموز أو تمثيل للموضوعات، والأحداث، والأفكار. وفي هذه السن أيضاً يظهرون القدرة على التمثيل أو اللعب الادعائي، وبوصولهم لسن

٣، ٤، ٥ سنوات تزداد الحصيلة اللغوية لديهم، ويبدأ الطفل أو الطفلة في إتقان والتمكن من قواعد لغته الأصلية.

<u>وفيما مؤشرات الإصابة بالتوحد والتي من أهمها الاضطرابات الكلامية واللغوية:</u>(٨،ص) (٩،ص ٨٩)

١. شيوع المشكلات اللغوية.
٢. تأخر النطق أو انعدامه.
٣. فقد المكتسبات اللغوية.
٤. تكرار الكلام الترديد لما يقوله الآخرون كالببغاء توصف لغة التواصل لديهم بأنها تكرارية أو نمطية مثل تكرار كلمات أو جمل مرتبطة بالمعنى
٥. سوء التعبير الحركي اللفظي.
٦. شيوع كلمات وجمل بدون معنى.
٧. عدم القدرة على تسمية الأشياء.
٨. إعادة الكلمة أو الجملة عدة مرات .
٩. عدم نمو لغة مفهومة حتى لو استطاع النطق.
١٠. عدم القدرة على التواصل اللغوي مع الآخرين
١١. الإسقاط : وهي نطق الجمل والعبارات ناقصة.
١٢. عدم القدرة على التعلم والتدريب اللفظي.
١٣. بعض الأطفال يكون لديهم عكس الضمائر (أنت بدلاً من أنا).
١٤. التحدث بنبرة بطيئة ثابتة بدون تغير حدة الصوت أو إظهار أي انفعالات.
١٥. الحديث المتقطع.
١٦. ضعف فهم اللغة
١٧. اضطراب الإدراك اللغوي
١٨. لدى هؤلاء الأطفال فيه بدرجات مختلفة
١٩. كمية ضئيلة من اللغة المفهومة.
٢٠. الذين لديهم اضطراب أقل قد يتابعون التعليمات المصحوبة بالإشارة
٢١. صعوبة في الاختصارات واللغة الدقيقة
٢٢. لا يستطيعون فهم تعبيرات المزاح والسخرية.
٢٣. مشكلات في تذكر تسلسل الكلمات

٢٤. اذا تتطور الكلام لديهم فإن الخصائص الكلامية مثل طبقة الصوت ؛ والتنغيم؛ ومعدل الصوت ؛ وإيقاع ونبرة الصوت تكون غير عادية.
٢٥. يتميزون بأن لغتهم لها خصوصية غريبة لا يفهم لغتهم إلا الأشخاص الذين يألفون أسلوب تواصلهم فقط
٢٦. غير قادرين على فهم الأسئلة البسيطة
٢٧. غير قادرين على دمج الكلمات مع الإيماءات لفهم الحديث.
٢٨. ففي الطفولة المبكرة ، قد يشيرون للآخرين أو يجذبونهم باليد إلى الأشياء التي يرغبونها بدون أي تعبيرات على الوجه
٢٩. قد يحركون رؤوسهم أو أيديهم عند الحديث
٣٠. عادة لا يشاركون في الألعاب التي تحتاج إلى تقليد ومحاكاة
٣١. كما أنهم لا يقلدون ما يعمله والديهم كأقرانهم.
٣٢. وفي المرحلة الوسطى والمتأخرة : لا يستخدم هؤلاء الأطفال عادة الإشارة حتى عندما يفهمون إشارة الآخرين ، البعض منهم قد يستخدم الإشارة ولكن عادة ما تكون متكررة.
٣٣. عادة ما يظهرون المتعة والخوف أو الغضب ، ولكن قد لا يظهرون سوى الانفعالات المتطرفة، كما أنهم لا يظهرون التعبيرات الانفعالية على الوجه التي تظهر الانفعالات الدقيقة.
٣٤. الصمت الاختياري هي حالة نادرة جداً ، حيث يكون الطفل التوحدي كالأصم الأبكم ، فهو لا يعير الآخرين والأصوات أي انتباه ،ولا ينطق بأي كلمة في أي وقت ، قياس السمع لديه طبيعي ، ولكنه لا يرغب في التواصل مع الآخرين.
٣٥. الحبسة الكلامية
٣٦. اضطرابات اللفظ وتشمل الإبدال والإضافة والحذف والتشويه .
٣٧. اضطرابات الطلاقة أو الانسياب الكلامي وتشمل التأتأة أو الكلام بسرعة فائقة .
٣٨. اضطرابات الصوت وتشمل الخنة الانفية والبحة الشديدة او التكلم من الأنف أو بحة الصوت وغير ذلك.
٣٩. إظهار الطفل لأنماط جسمية غير عادية عندما يتكلم كأن يحرك بطرق ملفته للنظر فمه أو لسانه أو يديه أو رأسه .
٤٠. ظهور بعض الملامح على أن الطفل يشعر بالحرج وعدم الارتياح عندما يتكلم .

الأسباب :

وثمة أسباب عديدة لاضطرابات التواصل ومنها :

أ. الأسباب البيولوجية: (عصبية أو جينية أو كروموسومية) .

ب. الأسباب النمائية : وتتمثل في أشكال مختلفة من التأخر في نضج الجهاز العصبي

ج. الأسباب البيئية : وتتمثل في العوامل البيئية والثقافية والأسرية المضطربة مثل الحرمان وعدم توفر الإثارة الكافية والتسمم

د. الأسباب النفسية والتعليمة : وتتمثل في التعلم الخاطئ وفي توقع الفشل وأنماط التواصل غير السليمة والاضطرابات النفسية الداخلية

هـ. الأسباب الوظيفية : وتتمثل في الاستخدام الخاطئ للحبال الصوتية والأجهزة الداعمة للكلام .

الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغوية

يمثل استخدام الطفل اليومي للغة لأغراض التواصل والتفاعل الاجتماعي أفضل معيار للحكم على كلامه ولغته

وعليه فإن المعلمين وأولياء الأمور يستطيعون القيام بأدوار بالغة الأهمية في الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغوية لدى الأطفال . وفي المدارس ، يمكن تنفيذ إجراءات كشفية منظمة ودورية على أيدي اختصاصي اضطرابات الكلام . فإن الكشف المبكر عن الاضطرابات الكلامية واللغة مسؤولية المعلم والاختصاصيون. ولا يعني ذلك أن يقوم المعلم بدور التشخيص ، فما هو مطلوب منه طلب مساعدة أهل الاختصاص أو تحويل الأطفال إليهم في حالة توقع مشكلات كلامية أو لغوية لديهم .

- كيف يمكن علاج اضطرابات اللغة والكلام في التوحد؟

عندما يشك الطبيب في وجود التوحد أو أي عجز نمائي آخر عند الطفل فإنه يحيله إلى فريق من المتخصصين؛ يتضمن أخصائي علاج اضطرابات اللغة والكلام، والذي يقوم بعمل تقييم شامل لقدرة الطفل على التواصل ويقومك بتصميم وإدارة برنامج علاج خاص بهذا الطفل.

لا توجد طريقة علاج يمكن ان تحسن بنجاح التواصل لدى كل الأفراد التوحديين. ومن الأفضل ان يبدأ التدخل مبكراً أثناء سنوات ما قبل المدرسة، كما يجب أن يكون البرنامج مخطط ومصمم

بصورة فردية، ويجب أن يستهدف كلاً من السلوك والتواصل، ويتضمن كذلك الآباء أو مقدمي الرعاية الأساسيين. ويجب أن يستهدف العلاج تحسين التواصل الوظيفي، فبالنسبة للبعض، قد يكون التركيز على التواصل في مواقف واقعية بينما يمكن ان نركز مع آخرين على التواصل الإشاري، بينما يمكن ان نستخدم مع آخرين نظام التواصل الرمزي مثل لوحة الصور. كما يجب أن تتضمن الخطة العلاجية فترات تقييم دقيق ومتعمق من قبل متخصص في تقييم وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، كما قد يشترك المعالجون الآخرون لتدريب الفرد على خفض السلوك غير المرغوب فيه الذي قد يؤثر على تطور مهارات التواصل.

وفيما يتعلق بالبرامج العلاجية التي يجب أن تقدم للأطفال التوحديين نجد أن هناك بعض المتخصصين يرحبون بتنظيم برامج علاجية سلوكية تقوم على تعديل السلوك ، بينما يرى آخرون أن العلاج المنزلي أو بالمنزل يجب ان يكون هو القاعدة أو الأساس لأنه يعتمد على تدريب هؤلاء الأطفال على التصرف في مواقف حقيقية. بينما يؤيد البعض المداخل الأخرى كالعلاج بالموسيقى والعلاج المعتمد على التكامل الحسي، والذي يعمل على تحسين قدرة الطفل على الاستجابة للمثيرات الحسية وهو يبدو مفيد جداً لبعض الأطفال التوحديين لتنمية قدرتهم على الاستجابة للمثيرات الخارجية.(**٨، ص ٣١**)

كما أن استخدام بعض الأدوية قد يحسن من قدرة الطفل على الانتباه لفترات أطول أو قد تساعد على خفض بعض السلوكيات غير المرغوب فيها ، لكن الاستعمال طويل المدى لهذه الأدوية قد يكون له آثار جانبية خطيرة لذا يجب ان تعطى هذه الأدوية تحت إشراف مباشر من قبل الطبيب المختص. ولا توجد أدوية حتى الآن يمكنها أن تعمل على تحسين التواصل لدى هؤلاء الأفراد كما يمكن استخدام الفيتامينات والأطعمة الخاصة وكذلك العلاج بالتحليل النفسي لكن حتى الآن لم يثبت البحث مدى فعاليتها.

التدخل العلاجي والتربوي :

اعتمد التدخل العلاجي والتربوي أساساً على وجهة النظر التي كانت سائدة حول أسباب التوحد ، وحيث أن التوحد كان يعتقد سابقاً بأنه اضطراب انفعالي يساهم الوالدين فيه مساهمة أساسية ، فقد كان العلاج عن طريق التحليل النفسي هو الأسلوب السائد سابقا ، أن أحد الأهداف الأساسية للتحليل النفسي هو إنشاء علاقة قوية مع نموذج يمثل الأم المتساهلة المحبة علاقة لم تستطع أم الطفل التوحدي أن تزوده بها ، وأن هذه العلاقة قد تأخذ سنوات حتى تتطور خلال عملية العلاج النفسي ٠

يتضمن التدخل العلاجى مرحلتان :

في الأولى : يزود المعالج الطفل بأكبر كمية ممكنة من الدعم وتقديم الإشباع وتجنب الإحباط مع التفهم والثبات الانفعالي من قبل المعالج ٠

وفي الثانية : تركز على تطوير المهارات الاجتماعية وتتضمن تأجيل الإشباع والإرضاء٠

إن معظم برامج المعالجين النفسانيين للأطفال كانت تأخذ شكل جلسات للمريض الذي يجب أن يقيم في المستشفى وتقديم بيئة بناءة وصحية من الناحية الانفعالية ٠

كما تستخدم طريقة العلاج البيئي وتتضمن تقديم برامج للطفل تعتمد على الجانب الاجتماعي عن طريق التشجيع والتعلم على إقامة علاقات شخصية ٠

أما التدخل التربوي :

فإنه يقوم في الأساس على استخدام إجراءات تعديل السلوك ذلك أن إجراءات تعديل السلوك تقوم على أسس موضوعية وليس على انطباعات ذاتية ،كما أنه أسلوب لا يضع اللوم على الوالدين ، وعلى العكس من ذلك فإنه يشرك الوالدين في عملية العلاج ، كذلك فإن إجراءات تعديل السلوك تعتمد على مبادئ وقوانين التعلم التي يمكن أن يتقنها المعلمون بسهولة مقارنة بالأساليب الأخرى ، وبالإضافة إلى إجراءات تعديل السلوك ، فإن البرامج التربوية يجب أن تتضمن تركيزاً على الجوانب اللغوية النطقية عند الطفل التوحدي وذلك بإجراءات تهدف إلى تحسين التواصل اللغوي الذي يفتقده الأطفال التوحديين ، بالإضافة إلى إجراءات التعليم المباشر على مهارات أساسية ضرورية في الجوانب الأكاديمية ومهارات الحياة اليومية ٠**(٩، ص ٦٦)**

دور الأسرة في معالجة اضطرابات التواصل عند أطفال التوحد

إن تواصلنا مع المحيطين بنا يتم من خلال الكلام وهو ما يعرف بالتواصل اللفظي والذي يصاحب بحركات وإيماءات الجسد، والاتصال البصري وتعبيرات الوجه، بالإضافة إلى التنغيم الصوتي وهو ما يعرف بالتواصل غير اللفظي.

ومن الجدير بالذكر أننا نستخدم مزيجاً من النمطين اللفظي وغير اللفظي للتواصل مع من حولنا، ومن هنا تبرز أهمية مساعدة الطفل التوحدي (المصاب بمرض التوحد) على التواصل بشكل فعال مع من حوله والذي يأتي في قمة أولويات برامج التأهيل المختلفة. وذلك لأن قصور المهارات التواصلية بشقيه اللفظي وغير اللفظي من السمات التشخيصية الأساسية لاضطرابات طيف التوحد. يعرف التوحد بأنه اضطراب في النمو العصبي يؤثر على التطور في ثلاثة مجالات أساسية منها، قصور في نمو وتطور المهارات التواصلية بالإضافة إلى صعوبة التفاعل الاجتماعي وهو ما يعتبر ذا علاقة وثيقة بالمهارات التواصلية أيضا ، والمجال الثالث يتمثل في

التعلق الشديد بالأعمال الروتينية والمحافظة على أنماط وأداء الأفعال على وتيرة واحدة وصعوبة القدرة على اللعب ، ومن الجدير بالذكر أن الفقد التدريجي للمهارات التواصلية والاجتماعية بعد النمو الطبيعي حتى سن ١٨ شهرا لا يمثل أكثر من ٣٠٪ من أطفال التوحد، في حين أن التأخر منذ البداية يمثل أكثر من ٧٠٪ من الأطفال التوحديين، حيث يشترط ظهور نمط الأعراض قبل سن ٣٦ شهرا ، ومن هنا تتضح لنا الأهمية القصوى للقصور في النواحي التواصلية، حيث إنها لا تعتبر معيارا تشخيصيا مهما فقط ، بل تعتبر التحدي الأكبر للمختصين وأسر الأطفال التوحديين ، مؤشرات أساسية ، إن المؤشرات الأساسية والأولية التي تساعد المختصين من النواحي التواصلية في تشخيص التوحد ، تتمثل في أن المصاب:

- لا يناغي حتى سن ١٢ شهر.
- لا يستخدم الإشارة (الإشارة إلى الأشياء وهز اليدين) حتى سن ١٢ شهرا.
- لا يستخدم كلمات مفردة حتى سن ١٦ شهرا.
- ضعف مهارات الاتصال البصري.
- تجاوب ضعيف مع الآخرين أثناء اللعب.
- لا يستخدم عبارات مكونة من كلمتين حتى سن ٢٤ شهرا.
- تكرار الكلمات، فعند سؤال الطفل: ما اسمك؟ فيقول «ما اسمك» بدل من أن يقول «أحمد» مثلا.
- فقد واضح لأي مهارات لغوية أو اجتماعية قد يكون اكتسبها قبل سن السنتين. دور الأسرة

وحين يولد الطفل، فإن أول ما يراه في الوجود هو والداه، حيث يبدأ هذا الطفل في النمو والتطور وتبدأ حركاته الأولى وابتساماته وانفعالاته واستجاباته لما حوله داخل منزله مع والديه ، فالمنزل والوالدان هما البيئة الأولى التي يعيش بها الطفل ويتعلم وينشأ فيها فيكتسب من خلال هذه البيئة ويتعلم المهارات المختلفة والتي يأتي على رأسها القدرة على الحوار والتواصل مع من حوله ، وهنا تكمن أهمية الوالدين في حياة الطفل ، ولكن في بعض الأحيان قد يعتري هذه المهارات التي يكتسبها عادة الطفل بشكل تلقائي بعض الخلل كما هو الحال في الطفل التوحدي ، مما يكون له أكبر الأثر في تطورها بشكل سليم وهنا يحتار الوالدان في الطريقة المثلى لمواجهة وإصلاح هذا الخلل ، فيلجآن للمتخصصين في هذا المجال لمساعدتهما وتوجيههما لإيجاد الحل المناسب.

ومع الأهمية الكبيرة للتدخل العلاجي، فلا يمكن أبدا أن يقلل من شأن دور أولياء أمر الطفل التوحدي وبيئته في علاج هذا الاضطراب ، فالدور الذي تلعبه أسرة الطفل التوحدي ومشاركتهم في البرنامج العلاجي له بالغ الأثر الإيجابي في تطوير هذه المهارات بشكل فعال أكثر ، وبالتالي فإن إعطاء الوالدين المعلومات والنصح والتوجيه والأساليب والاستراتيجيات المناسبة الخاصة باضطراب طفلهم التوحدي سيساعدهم في تطوير المهارات المناسبة لدى هذا الطفل ،

إن أفضل علاقة تربط بين أخصائي النطق واللغة كمتخصص في تشخيص وعلاج الاضطرابات التواصلية وبين الوالدين كخبراء بطفلهم ومعرفتهم ببيئته الطبيعية وحياته اليومية والخبرات المختلفة التي يتعرض لها بالإضافة لاحتياجاته الخاصة وطباعه ، هي علاقة الشراكة وذلك للوصول لأفضل طريقة للتدخل لعلاج مشكلة الطفل ، والخطوة الأولى في تطبيق هذه الشراكة تكون بتدريب الوالدين وإعطائهما الأدوات المناسبة التي ستساعدهما في تطوير مهارات الطفل حيث يعتبر تدريب الوالدين وخصوصاً أثناء المراحل المبكرة لحياة الطفل عنصرا مهما في أي برنامج علاجي. (٩،ص ٧٣)

وكان تدريب الوالدين ومدى تأثيره على تقدم مهارات الطفل التواصلية ومهاراته الأخرى ، محور وتركيز العديد من الأبحاث العلمية حيث أثبتت الدراسات الحديثة أهمية دور آباء وأمهات الأطفال التوحديين في تنمية المهارات التواصلية لدى أطفالهم، وذلك لأن الآباء والأمهات يمثلون الجزء الأكبر في عالم الطفل والذي تتضاءل أمامه كل الأدوار الأخرى من الناحية الكمية، حيث يقضي الطفل عددا كبيرا من الساعات مع والديه في حين أنه يقضي عددا محدودا من الساعات مع اختصاصي أمراض النطق واللغة ، ومن هنا تتبلور أهمية تدريب الآباء والأمهات بهدف موازنة المعادلة ، بحيث يصاحب التفوق الكمي جودة نوعية تساعد الآباء والأمهات على تنمية مهارات الطفل التوحدي التواصلية والذي سينعكس على مستوى استخدامه للمهارات التواصلية كطلب الأشياء وجذب الانتباه والرفض والتعبير عن المشاعر وغيرها من الصعوبات التي يعانيها أطفال التوحد على مستوى التواصل بشقية اللفظي وغير اللفظي ، إن دور الأسرة يتمثل في ضرورة أن تتدرب بشكل مكثف حتى تتمكن من إتقان الأساليب والطرق المناسبة لتعليم طفلهم التوحدي أكاديميا والتعامل معه من الناحية النفسية . كما يجب هنا أن لا نغفل ضرورة أن يتدرب الأهل على الطرق والأساليب التي تمكنهم من التواصل الاجتماعي مع الطفل التوحدي كل تبعا لمستوى أدائه ، أما دور المجتمع فيتجلى بشكل كبير في بذل الكثير من الجهود حتى يزداد الوعي باضطرابات طيف التوحد والذي سينعكس بشكل كبير على نمط التقبل الاجتماعي لفئات التوحديين وأسرهم من خلال العمل الجاد منذ البداية وبشكل مستمر على كل الأصعدة بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والاعتماد على الذات للأشخاص التوحديين بالإضافة للعمل على سن القوانين التي من شأنها أن تدعم توفير البرامج والخدمات ذات العلاقة باحتياجات التوحديين المتنامية تبعا للمراحل العمرية ومستوى الأداء.(٩ ص ٨٤)

نصائح لآباء ومعلمي الأشخاص المصابين بالتوحد :

١- يفكر كثير من الأشخاص المصابين بالتوحد باستخدام التفكير المرئي ،حيث يفكرون باستخدام الصور ، بدلاً من اللغة أو الكلمات لذا ينصح المعلمة أو المعلم بعرض الكلمات بصورة واضحة للطفل ، وذلك باستخدام الألعاب مثلاً .

٢- تجنب استخدام كلمات كثيرة وأوامر أو تعليمات طويلة .حيث يواجه الأشخاص المصابين بالتوحد مشكلات في تذكر تسلسل الكلمات وذلك يمكن كتابة التعليمات على الورق إذا كان الطفل أو الشخص يستطيع القراءة .

٣- لدى كثير من الأطفال المصابين بالتوحد موهبة في الرسم، والفن، أو الكمبيوتر حاول تشجيع هذه المواهب وتطويرها .

٤- قد يركز الأطفال المصابين بالتوحد على شيء ما يرفضون التخلي عنه ، كلعب القطارات أو الخرائط ٠ وأفضل طريقة للتعامل مع ذلك هي استغلال ذلك من أجل الدراسة ، حيث يمكن استخدام القطارات ، مثلاً ، لتعليم القراءة والحساب ٠ أو يمكن قراءة كتاب عن القطارات والقيام بحل بعض المسائل الحسابية استخدام القطارات ، كعد مثلاً كم كيلومتر يفصل بين محطة وأخرى .

٥- استخدم طرق مرئية واضحة لتعليم مفهوم الأرقام .

٦- يواجه كثير من الأطفال المصابين بالتوحد صعوبات في الكتابة ، بسبب صعوبات في التحكم بحركة اليد للتغلب على شعور الطفل بالإحباط بسبب سوء خطه،شجعه على الاستمتاع بالكتابة ، واستخدم الكمبيوتر في الطباعة إذا أمكن ذلك .

٧- بعض الأطفال المصابين بالتوحد يتعلمون القراءة بسهولة أكبر إذا استخدموا طريقة تعلم الحروف أولاً ، بينما يتعلم البعض الآخر باستخدام الكلمات دون تعلم الحروف أولاً .

٨- بعض الأطفال لديهم حساسية ضد الأصوات المرتفعة، ولذلك يجب حمايتهم من الأصوات المرتفعة (كصوت جرس المدرسة مثلاً)، أو صوت تحريك الكراسي بحكها في الأرضية ويمكن التقليل من صوت تحريك الكراسي بوضع سجادة فوق أرضية الفصل .

٩- تسبب الأضواء العاكسة (الوهاجة) بعض الإزعاج لبعض الأطفال المصابين بالتوحد . ولتجنب هذه المشكلة ، تجنب استخدام الأضواء العاكسة .

١٠- بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون من فرط الحركة أيضاً ، حيث يتحركون كثيراً ، ويمكن التغلب على ذلك من خلال توزيع المقاعد .

١١- يستجيب بعض الأطفال المصابين بالتوحد بشكل أفضل ويتحسن الكلام عندهم إذا تواصل المعلم معهم بينما هم يلعبون على أرجوحة مثلا قد يساعد على تحسين الحديث لكن دون اجبار.

١٢- بعض الأطفال والكبار المصابين بالتوحد ، ممن يستخدمون التواصل غير اللفظي، لا يستطيعون معالجة المعلومات الداخلة عن طريق الرؤية والسمع في نفس الوقت ، وذلك لا يستطيعون الرؤية والسمع في نفس الوقت ، ولذلك يجب ألا يطلب منهم أن ينظروا وينصتوا في نفس الوقت .

١٣- تعتبر حاسة اللمس ، عند كثير من الأشخاص المصابين بالتوحد ممن يستخدمون التواصل غير اللفظي أكثر الحواس فاعلية ولذلك يمكن تعليمهم الحروف بتعويدهم على لمس الأحرف المصنوعة من البلاستيك كما يمكن أن يتعلموا جدولهم اليومي بلمس الأشياء الموجودة على الجدول قبل بضع دقائق من موعد النشاط.

١٤- في حال استخدام الحاسوب في التعليم ، حاول وضع لوحة المفاتيح في أقرب مكان إلى الشاشة ، حيث إن بعضهم قد لا يدرك أن عليه أن ينظر إلى الشاشة بعد الضغط على أحد المفاتيح .

١٥- من السهل بالنسبة لبعض الأشخاص ممن يستخدمون التواصل غير اللفظي الربط بين الكلمات والصور إذا رأوا الكلمة مطبوعة تحت الصورة التي تمثلها ٠ وقد يجد بعض الأشخاص صعوبة في فهم الرسومات ، حيث يفضلون استخدام الأشياء الحقيقية والصور في البداية .

١٦- قد لا يدرك بعض الأشخاص المصابين بالتوحد أن الكلام يستخدم كوسيلة للتواصل وذلك فإن تعلم اللغة يجب أن يركز على تعزيز التواصل فإذا طلب الطفل كوباً فأعطه كوباً ، وإذا طلب طبقاً بينما هو يريد كوباً ، أعطه طبقاً حيث يحتاج الطفل أن يتعلم أنه حينما ينطق بكلامٍ ما ، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث شيء ما .

١٧- قد يجد كثير من الأشخاص المصابين بالتوحد صعوبة في استخدام فأرة الحاسوب، ولذا حاول استخدام أداة أخرى لها زر منفصل للضغط ، كالكرة الدائرية حيث يجد بعض الأطفال المصابين بالتوحد ، ممن يواجهون مشاكل في التحكم العضلي ، صعوبة في الضغط على الفأرة أثناء مسكها. (٨،ص)

الفرق بين التوحد وبعض الاضطرابات الاخرى

التوحد واضطرابات السمع والبصر :

الانسحاب الاجتماعي ، والانزعاج من تغيير الروتين ، وسلوكيات أخرى يمكن أن تظهر من قبل أطفال صم وهو يشبه السلوك الذي يظهره الأطفال المتوحديين ، هذه السلوك تعتبر ثانوية بالنسبة للصم ، ونتيجة لاضطرابهم ولكنها أولية وأساسية في حالة الأطفال المتوحديين ، معظم المتوحدون ليسوا صماً ، وإذا شك بالطفل بأنه يعاني من التوحد فإنه يجب أن يتم فحص سمعه لاستبعاد إصابته بالصمم ٠

الأطفال المكفوفون أو ضعاف البصر يمكن أن يظهروا استثارة ذاتية وحركات نمطية تشبه ما يقوم به الأطفال التوحديين ، وأكثر من ذلك فإن اضطراب التوحد في الاستجابة إلى المثيرات البصرية يمكن أن تشير إلى التوحد في أول انطباع ٠

م	اضطراب التوحد	الإعاقة السمعية
١	لا يستطيع الطفل التوحدي تكوين صداقات وعلاقات اجتماعية.	يستطيع المعاق سمعيا تكوين صداقات وعلاقات اجتماعية.
٢	يعتبر الانسحاب الاجتماعي ومقاومة التغيير في الروتين من السلوكيات الأولية للطفل التوحدي.	يعتبر الانسحاب الاجتماعي ومقاومة التغيير من السلوكيات الثانوية للطفل الأصم.
٣	الطفل التوحدي لا يستجيب لمشاعر الآخرين ولا يفهم هذه المشاعر.	الطفل الأصم يستطيع أن يتعرف على تعبيرات الوجه.
٤	توجد صعوبة في تشخيص حالات التوحد لعدم توفر أدوات مقننة.	يسهل تشخيص حالات الصم والبكم بالفحص الطبي من خلال أجهزة السمع والكلام.
٥	الأطفال المتوحدون نادرا ما يمرون بمرحلة المناغاة بصورة واضحة	الأطفال الصم يكون لديهم تاريخ من المناغاة والأصوات العادية والتي تتوقف بعد ٦ شهور من العمر.
٦	الطفل التوحدي يقوم بسلوكيات متكررة كالهز والدوران والتأرجح والتصفيق وتشبيك الأيدي.	الطفل الأصم لا يقوم بمثل هذه السلوكيات إلا عندما يتم تجاهل حاجاته لفترة طويلة.
٧	نسبة الذكاء لدى التوحديين اقل من المعاقين سمعيا.	نسبة الذكاء لدى المعاقين سمعيا اعلي من التوحديين.

التوحد واضطراب التواصل :

حيث أن اضطرابات اللغة والكلام والجوانب المعرفية مظاهر أساسية في التوحد ، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تشابه بين التوحد والاضطرابات اللغوية ، وبسبب هذا التشابه فإنه يتم الخلط أحياناً بين التوحد وهذه الاضطرابات ٠

اضطرابات اللغة الاستقبالية وجد أنها تتشابه مع اضطرابات اللغة التي يظهرها الأطفال التوحديين ، نتائج الدراسات في هذا المجال أشارت إلى انه مع وجود تشابه بين التوحد واضطرابات اللغة الاستقبالية فإنه يمكن التمييز بين الاضطرابيين

الأطفال من ذوي الاضطرابات اللغوية الاستقبالية يحاولون التواصل بالإيماءات وبتعبيرات الوجه للتعويض عن مشكلة الكلام ، بينما الأطفال التوحديين فإنهم لا يظهرون تعبيرات انفعالية مناسبة أو رسائل غير لفظية مصاحبة ،قد تظهر المجموعتان إعادة الكلام ولكن الأطفال التوحديين يظهرون إعادة كلام وخاصة إعادة الكلام المتأخر أكثر ،يفشل الأطفال التوحديين في استخدام اللغة كوسيلة اتصال ولكن الأطفال في اضطرابات اللغة يتعلمون فهم مفاهيم اللغة الأساسية والرموز غير المحكية ويحاولون التواصل مع الآخرين ،وبناءً عليه فإن القدرة أو القابلية على التعلم والتعامل مع الرموز تعتبر الفارق الرئيسي بين المجموعتين.(٩)

التوحد وفصام الطفولة

م	اضطراب التوحد	فصام الطفولة
١	لا يوجد لدى التوحديين هلاوس وهذيان.	يكثر وجود الهلاوس والهذيان لدى الأفراد المصابين بفصام الطفولة.
٢	الأطفال المتوحدون لا يستطيعون استخدام الرموز.	الفصاميون قادرون على استخدام الرموز.
٣	المتوحدون لا يطورون علاقات اجتماعية مع الآخرين ويرفضون الاستجابة للأشخاص والبيئة.	الفصاميون ممكن أن يطوروا علاقات اجتماعية.
٤	حالات التوحد لا تنتشر ولا تتكرر في العائلة.	حالات الفصام تتكرر بصورة واضحة في العائلة.
٥	يبدأ اضطراب التوحد قبل (٣٠) شهرا من العمر.	يظهر الفصام في بداية المراهقة أو في عمر متأخر من الطفولة.
٦	يعاني المتوحدون من قصور أو غياب اللغة.	لا يعاني الفصاميون من قصور في اللغة أو غياب القدرة على التعبير.
٧	المتوحدون يتجنبون التواصل البصري مع الآخرين.	نادرا ما يتجنب الفصاميون التواصل البصري مع الآخرين.

التوحد والاعاقة العقلية

م	اضطراب التوحد	الإعاقة العقلية
١	الأفراد المتوحدون لا يوجد لديهم تعلق بالآخرين ويميلون للعزلة والانسحاب.	المعاقون عقليا يتعلقون بالآخرين ولديهم بعض الوعي الاجتماعي.
٢	لا يعتمد في تشخيص اضطراب التوحد بشكل أساسي على القدرات العقلية.	يعتمد في تشخيص الإعاقة العقلية بشكل أساسي عل اختبارات الذكاء.
٣	يكون الطفل التوحدي طبيعي من حيث المظهر ويتصف بالوسامة والجمال.	توجد أعراض خارجية وشكلية تدل على وجود إعاقة عقلية مثل المنغوليين، وكبر حجم الدماغ وغيرها.
٤	يمكن أن تكون اللغة غير موجودة وان وجدت تكن غير عادية وغير وظيفية.	اللغة موجودة بشكل أفضل مقارنه بالطفل التوحدي.
٥	تركز أدوات التشخيص للأطفال المصابين بالتوحد على الجوانب السلوكية واللغوية والاجتماعية.	تركز الأدوات التي تستخدم لتشخيص الإعاقة العقلية على الجانب المعرفي والعقلي والسلوكي والتكيفي.
٦	يتجنب الأطفال المتوحدون التواصل البصري مع الآخرين..	تجنب التواصل البصري صفة نادرا ما تحدث لدى المعاقين عقليا.

تابع نماذج من فئات التربية الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة

٧- اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد:

حالة مشتركة من نقص الانتباه مع النشاط الزائد والاندفاعية تبدأ في مرحلة مبكرة من العمر، وتستمر حتي مرحلة المراهقة، ويتصف ذوو نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد بصعوبة إنجاز العمل، ومواجهة مشاكل في تنظيم المهام إلى جانب مشاكل في التركيز، مما يؤثر على حياتهم، ويعوقهم عن أداء وظائفهم الاجتماعية والأسرية والمهنية والأكاديمية.

- مفهوم اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد:

اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد هو أحد الاضطرابات السلوكية الشائعة في مرحلة الطفولة والتي غالبًا ما تستمر في مرحلة المراهقة والرشد، وتؤثر تأثيرًا سلبيًا على شخصية الفرد بأسرها جسميًا وانفعاليًا وعقليًا واجتماعيًا، ويعاني خلالها الفرد من مجموعة من الأعراض الأساسية متمثلة في نقص الانتباه، والنشاط الزائد، والاندفاعية، حيث يعاني الفرد من عدم القدرة على الانتباه لفترة طويلة مع وجود حركة زائدة غير ملائمة للموقف، إلى جانب مجموعة من الأعراض تكون مصاحبة للأعراض الأساسية منها:

العدوانية، تدني مفهوم الذات، ومستوى التحصيل الأكاديمي، وعدم القدرة على تحمل الإحباط والعناد، وعدم القدرة على الاتزان الانفعالي، والتأخر الدراسي، وعدم القدرة على الصبر، وضعف المعرفة، يجانب الشعور بعدم الاستقرار والتردد، والتململ.

و اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد هو "اضطراب يتميز بوجود ثلاثة أعراض أساسية هي(نقص الانتباه، الاندفاعية، والنشاط الزائد) ويصنف تحت ثلاثة أنماط:

- النمط غير المنتبه: وهو نمط يسود ويهمين فيه عرض نقص الإنتباه، ويظهر بشكل أكثر من ظهور عَرَضَيْ النشاط الزائد والإندفاعية.
- النمط النشط المندفع: وهو نمط يسود ويهيمن فيه عرض النشاط الزائد والإندفاعية أكثر من عرض نقص الانتباه.
- النمط المختلط: وهو نمط يتلازم ويهيمن فيه ظهور الأعراض الثلاثة معًا (نقص الإنتباه، الإندفاعية، النشاط الزائد).

واضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد هو مشكلة سلوكية يعاني منها الأطفال والمراهقين ويتميز بتلاثة أعراض هى ضعف الإنتباه ،والإندفاعية ، والحركة المفرطة

غير الهادفة وغير المقبولة إجتماعيًا ، ويصاحبه مجموعة من الأعراض الثانوية منها ضعف أو تدنى مستوى التحصيل الدراسى ، وقصور العلاقات الإجتماعية ، وعدم الطاعة ،والعدوانية ، وإحداث الفوضى ، وضعف القدرة علي تحمل الإحباط ، وعدم الإتزان الإنفعالي ،وإنخفاض تقديرات الذات كل هذه الأعراض سواء أكانت أساسية أو ثانوية تشكل مصدرًا أساسيًا للضيق والتوتر وإزعاج المحيطين، حيث يعانى من هذا النشاط الزائد أولياء الأمور والمعلمون والتلاميذ، مما يؤثر على استجابات الوالدين والمعلمين والقائمين على الرعاية ومن ثم يؤثر علي مستوى نموهم ومستقبلهم التعليمي والاجتماعي فيما بعد.

- أعراض إضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد

أكثر الخصائص شيوعًا لدى ذوي اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد هو ضعف التركيز والانتباه، حيث يكون هؤلاء أكثر قابلية للتشتت ولديهم مدى انتباه قصير، وغير قادرين على الاحتفاظ بالانتباه أو تركيز انتباههم أثناء المهام التي تستغرق وقتًا متصلًا، ولا ينتبهون لما يقوله المعلم.

و الأفراد ذوي نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد يفشلون في تركيز انتباههم، ومن ثم عدم اكمال المهام الموكلة إليهم سواء (منزلية – مدرسية)، بجانب صعوبة في التركيز أثناء العمل وأثناء المهام التي يقومون بها.

كما تختلف مظاهر نقص أو قصور الانتباه باختلاف المرحلة العمرية التي يمر بها الفرد، حيث إن مشكلة الانتباه لدى ذوي نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد تعني صعوبة في تركيز الانتباه لفترة طويلة، فيحدث لديهم ما يسمى تشتيت الذهن، وخاصة لسهولة استثارتهم بالمثيرات المختلفة في نفس الوقت، فهم لا يستطيعون إكمال المهام ولكنهم ينتقلون من مثير إلى آخر بسهولة، ويتميز ذوو اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد بالآتي:

١-قصر فترة الانتباه: تشتت الإنتباه بسرعة في ثوانٍ، ويقل التركيز على مثير معين.

٢-سهولة تشتيت الانتباه: لا يستطيع التركيز على مثير واحد، ويتجاهل المثيرات الأخرى فينتقل انتباهه من مثير إلى مثير آخر.

٣-ضعف القدرة على الإنصات: ضعف قدرتهم على التفكير بسبب تسرعهم في الإجابة عن الأسئلة، ولا يستطيعون فهم المعلومات بصورة كاملة.

و السلوك الاندفاعي هو عدم القدرة على التحكم في الذات، حيث يندفع الفرد ولا يفكر إلا بعد أن يقوم بالعمل، والاندفاعية كنمط سلوكي يتضمن الميل نحو الاستجابة دون تفكير في البدائل المطروحة، فيكون مندفعًا في الحديث فهو غالبًا ما يتصرف أو يفعل شيئًا بدون تفكير. ونلاحظها كثيرًا من خلال كثر مقاطعته لحديث الآخرين، والإجابة عن الأسئلة قبل استكمالها وبدون تفكير.

و ذوي اضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد يتصفون بالاندفاعية التي تتسم بالخصائص الآتية:

تبدأ أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط قبل سن ١٢ عامًا، وتكون هذه الأعراض ملحوظة في وقت مبكِّر من عمر ٣ سنوات لدى بعض الأطفال. قد تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط خفيفة أو معتدلة أو حادة، وقد تستمر حتى سن البلوغ .

وفيما مؤشرات إضطراب نقص الانتباه المصحوب بالنشاط الزائد

١. يندفع في الإجابة قبل اكتمال سماع الأسئلة.
٢. يجد صعوبة في انتظار دوره في أمر ما.
٣. يقاطع الآخرين أثناء الحديث ويتطفل عليهم.
٤. يندفع في المحادثات والألعاب بتهور.
٥. لا يستطيع السيطرة على أفعاله.
٦. حساس تجاه النقد الموجه له من الآخرين.
٧. فرط النشاط من تراجع الثقة بالنفس
٨. والعلاقات المضطربة، وضعف الأداء في المدرسة أيضًا
٩. يحدث اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط في كثير من الأحيان في الذكور أكثر من الإناث، وقد تكون السلوكيات مختلفة بين الصبيان والفتيات. على سبيل المثال، قد يكون الصبيان أكثر نشاطًا، وقد تميل الفتيات إلى عدم الانتباه.
١٠. غافل أغلب الوقت تندرج غالبية الأعراض تحت الإهمال.
١١. يفشل في الاهتمام وثيق للتفاصيل أو يقوم بأخطاء طائشة في العمل المدرسي.
١٢. يواجه مشكلة في التركيز على المهام أو اللعب
١٣. يبدو غير منصت، حتى عندما يتم التحدث إليه مباشرة
١٤. يواجه صعوبة في متابعة التعليمات ويفشل في إنهاء العمل المدرسي أو الأعمال المنزلية

١٥. يعاني من مشكلات في تنظيم المهام والأنشطة
١٦. يتجنب أو لا يُعجَب بالمهام التي تتطلب مجهودًا عقليًا مركّزًا، مثل الواجب المنزلي
١٧. يفقد العناصر اللازمة للمهام أو الأنشطة، على سبيل المثال، الألعاب والتكليفات المدرسية وأقلام الرصاص
١٨. ينسى القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل نسيان للقيام بالأعمال المنزلية
١٩. يتململ أو يقرع بيديه أو قدميه أو يتلوى في المقعد
٢٠. يجد صعوبة في الجلوس في الفصل أو في المواقف الأخرى
٢١. يجري بالجوار أو يتسلق في مواقف لا تناسب فعل ذلك
٢٢. يجد صعوبة في اللعب أو القيام بالأنشطة بهدوء
٢٣. يتحدث كثيرًا
٢٤. يتسرع بالإجابة ويقاطع السائل
٢٥. يجد صعوبة في انتظار دوره
٢٦. يقطع على الآخرين حديثهم أو ألعابهم أو أنشطتهم أو يتطفل عليهم
٢٧. الميل إلى وقع المزيد من الحوادث والإصابات بجميع أنواعها أكثر من الأطفال الذين ليس لديهم اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط
٢٨. من المرجح أن تواجه مشكلة في التفاعل مع الأقران والبالغين وتقبلك من جانبهم
٢٩. اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لا يسبب مشاكل نفسية أو مشاكل في النمو.
٣٠. اضطراب التحدي المعارض وهو نمط من أنماط السلوك السلبي المتحدي والعدائي تجاه رموز السلطة.
٣١. إن اضطراب السلوك يتسم بانتهاجه للسلوك المعادي للمجتمع كالسرقة والتشاجر وتدمير الممتلكات وإلحاق الضرر بالناس أو الحيوانات.
٣٢. إن اضطراب تقلبات المزاج التخريبية يتسم بالانفعالية وحدة الطباع والمشكلات الناجمة عن تحمل الإحباط
٣٣. صعوبات التعلُّم مشاكل في القراءة والكتابة والاستيعاب والتواصل

الأسباب

تشملُ العواملُ التي قد تكون مُضمّنة في تطوُّرِ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط الجيناتِ أو المُشكلاتِ المُتعلقةِ بالجهازِ العصبي المركزي في لحظاتٍ أساسيةٍ خلال التطوُّر والبيئةَ مثل التعرُّض للسموم البيئية – مثل الرصاص، الموجود بشكل أساسي في الطلاء والأنابيب والمباني

القديمة – تعاطِي الأم للمخدرات والكحول، أو التدخين أثناء الحمل –الولادة المبكرة–بعض الامراض

الوقاية والعلاج

إن علاج اضطراب الاسترسال العقلي حالة مرتبطة بنمو الدماغ تؤثر على كيفية إدراك الشخص للآخرين والتواصل معهم و للمساعدة في تقليل خطر إصابة طفلكِ بـ اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD):

- الاهتمام بغذاء الام فى فترة الحمل.
- حماية طفلكِ من التعرُّض للملوِّثات والسموم، وتشمل تدخين السجائر، والطلاء المحتوي على الرصاص.
- الحد من فترات مشاهدة التلفاز التلفاز وألعاب الفيديو.
- التربية النفسية السوية.

العلاج: يعتمد علاج الاضطراب على ثلاث ركائز أساسية يكمل بعضها بعضًا:

العلاج الدوائي:

يساعد على زيادة التركيز والانتباه لمدة أطول، تقليص الحركة والاندفاعية، وتنقسم الأدوية المستخدمة إلى نوعين:

الأدوية المنشطة:

تعمل على تنشيط الناقلات العصبية، وبالتالي رفع القدرة على التركيز والتحكم بالسلوكيات.

الأدوية غير المنشطة (المثبطة).

تعمل على تقوية المستقبلات الكيميائية في خلايا الدماغ وزيادة فعالية الناقلات العصبية لتحسين القدرة على التركيز والعلاج الدوائي فعَّال في سيطرة على أعراض الاضطراب الرئيسة؛ ولكن استخدامه وحده لا يغني عن العلاج السلوكي والتربوي المكملين له.

العلاج السلوكي والتربوي:

يعتمد هذا العلاج على تعديل سلوكيات الطفل عن طريق أساليب واستراتيجيات يستخدمها الأهل؛ لاستبدال سلوكياته السلبية بالإيجابية وتدريبه على اكتساب مهارات جديدة.

المراجع :

١. جمال الخطيب ، وآخرون (١٩٩٧). المدخل إلى التربية الخاصة ، العين – دولة الإمارات العربية : المتحدة مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى.

٢. ابر أهيم أبو نيان (٢٠٠١).صعوبات التعلّم . طرق التدريس والاستراتيجيات المعرفية ، الرياض – المملكة العربية السعودية : أكاديمية التربية الخاصة ، الطبعة الأولى .

٣. فاروق الروسان(٢٠٠١) . سيكولوجية الأطفال غير العاديين . مقدمة في التربية الخاصة ، عمان – المملكة الأردنية : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الخامسة .

٤. سيد عبد الرحمن (١٩٩٩). سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة ، القاهرة . جمهورية مصر العربية : جامعة عين شمس .

٥.عبد المطلب امين القريطى(٢٠٠٥).سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة وتربيتهم،ط٤،دار الفكر العربى،القاهرة،

٦.لطفى بركات(١٩٨١).تربية المعوقين في العالم العربى،المريخ،الرياض

٧.ناصر على (١٩٩٥).المنهج الاضافى ودورة في تنمية المهارات التعويضبة،بحوث ودراسات، القاهرة،ص ص ٦٠-١٠٠

٨- طلعت حمزة الوزنة (٢٠٠٤) .التوحد بين التشخيص والعلاج ، مجلة المنال ع ١٩٣ ابريل ٢٠٠٥م ، الرياض .

٩-ابراهيم عبدالله الزريقات (٢٠٠٤) .التوحد الخصائص والعلاج ,دار الفكر ،عمان .